

Bunga Rampai

KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA INDONESIA

ISU TERKINI DAN PERAN STRATEGIS KEBIDANAN

Dina Isfentiani • Ida Susila • Indah Yani Br. Tambunan
Nur Hidayah Afnas • Siti Komariyah • Ika Nur Saputri

Editor: Sumiaty

BUNGA RAMPAI: KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA INDONESIA: ISU TERKINI DAN PERAN STRATEGIS KEBIDANAN

Penulis:

Dina Isfentiani, S.Kep.Ns., M.Ked

Bdn. Ida Susila,. SST,. M.Kes.

Bd. Indah Yani Br. Tambunan, S. Tr. Keb., M.Kes

Bd. Nur Hidayah Afnas, S.ST., M.Biomed

Siti Komariyah, S.SiT., M.Kes

Dr. Bd. Ika Nur Saputri, SST., M.Keb.

Editor:

Sumiaty, SST., Bdn., MPH., M.Keb.



**Optimal
Untuk
Negeri**

Bunga Rampai: Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia: Isu Terkini Dan Peran Strategis Kebidanan

Penulis: Dina Isfentiani, S.Kep.Ns., M.Ked.

Bdn. Ida Susila, SST., M.Kes.

Bd. Indah Yani Br. Tambunan, S. Tr. Keb., M.Kes.

Bd. Nur Hidayah Afnas, S.ST., M.Biomed

Siti Komariyah, S.SiT., M.Kes.

Dr. Bd. Ika Nur Saputri, SST., M.Keb.

Editor: Sumiaty, SST., Bdn., MPH., M.Keb.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7426-22-2

Cetakan Pertama: Oktober, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya bunga rampai *Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia: Isu Terkini dan Peran Strategis Kebidanan*. Buku ini lahir dari kegelisahan sekaligus harapan: di satu sisi, remaja Indonesia menghadapi spektrum tantangan yang kian kompleks—mulai dari arus informasi digital yang tak selalu akurat hingga kesenjangan akses layanan ramah remaja; di sisi lain, kita memiliki modal sosial, kebijakan, dan profesi kebidanan yang kuat untuk memastikan setiap remaja tumbuh sehat, berdaya, dan terlindungi hak-haknya.

Sebagai bangsa yang sedang menikmati bonus demografi, investasi pada kesehatan reproduksi remaja bukan pilihan, melainkan keniscayaan. Kualitas generasi mendatang ditentukan oleh kemampuan kita hari ini dalam memberikan edukasi yang benar, layanan yang terjangkau, serta pendampingan yang empatik dan berbasis bukti. Di titik inilah profesi kebidanan memegang peran strategis—bukan hanya pada tataran pelayanan klinis, tetapi juga pada ranah promotif, preventif, advokasi kebijakan, literasi kesehatan, serta pemberdayaan keluarga dan komunitas.

Bunga rampai ini menghimpun pemikiran dan pengalaman lapangan dari para akademisi, praktisi, serta penggiat kesehatan remaja di Indonesia. Topik-topik yang diangkat sengaja disusun berjenjang agar saling melengkapi dan memberikan gambaran utuh: edukasi kesehatan reproduksi remaja, pencegahan kehamilan tidak diinginkan pada remaja, infeksi menular seksual (IMS) pada remaja, menstruasi dan permasalahan terkait pada remaja, kesehatan mental dan seksualitas remaja, serta peran strategis kebidanan dalam peningkatan kesehatan reproduksi remaja. Setiap bab menawarkan kerangka konseptual, bukti mutakhir, praktik baik, serta rekomendasi yang dapat langsung diadaptasi di berbagai setting: sekolah, puskesmas, klinik mandiri, hingga komunitas.

Kami menempatkan edukasi kesehatan reproduksi remaja sebagai fondasi, karena literasi yang baik adalah benteng pertama melawan mitos, stigma, dan perilaku berisiko. Bab pencegahan kehamilan tidak diinginkan mengurai pendekatan komprehensif yang menghormati nilai budaya dan hak remaja sekaligus menegaskan standar etik dan keselamatan. Pembahasan IMS pada remaja menekankan pentingnya skrining, konseling, dan jejaring rujukan yang ramah remaja. Sementara itu, bab menstruasi dan permasalahannya mengajak kita melampaui aspek biologis menuju isu akses produk, sanitasi, dan martabat remaja perempuan. Tema kesehatan mental dan seksualitas mempertautkan kesejahteraan psikologis dengan pengambilan keputusan seksual yang sehat, menegaskan bahwa seksualitas remaja adalah wilayah tumbuh

kembang yang membutuhkan dialog aman, bukan penghakiman. Keseluruhan rangkaian bermuara pada bab tentang peran strategis kebidanan, yang merumuskan kompetensi, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi layanan untuk memperkuat ekosistem kesehatan reproduksi remaja di Indonesia.

Kami menyadari bahwa keberhasilan implementasi gagasan dalam buku ini bergantung pada sinergi: pendidik yang menyiapkan kurikulum responsif, pengambil kebijakan yang memastikan regulasi dan pendanaan yang memadai, praktisi yang menghadirkan layanan ramah remaja, serta keluarga dan komunitas yang menjadi lingkungan pengasuhan utama. Karena itu, buku ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa kebidanan dan kesehatan, bidan dan tenaga kesehatan, pendidik, pengelola program, pembuat kebijakan, dan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang remaja.

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

CHAPTER 1 EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 1

Dina Isfentiani, S.Kep.Ns., M.Ked.	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Isu Terkini Kesehatan Reproduksi Remaja	2
C. Perkawinan dan Pernikahan Dini.....	4
D. Aborsi.....	6
E. Peran Strategis Kebidanan	7
F. Pelibatan Remaja Sebagai Agent Perubahan	9
G. Layanan Kesehatan Reproduksi Ramah Remaja.....	10
H. Tujuan Kesehatan Reproduksi Remaja.....	11
I. Strategi Untuk Mencapai Tujuan Kesehatan Reproduksi Remaja.....	12
J. Simpulan	12
K. Daftar Pustaka.....	12

CHAPTER 2 PENCEGAHAN KEHAMILAN TIDAK DIINGINKAN PADA

REMAJA..... 15

Bdn. Ida Susila, SST., M.Kes.	15
A. Pendahuluan/Prolog.....	15
B. Faktor Penyebab Kehamilan Tidak Diinginkan pada Remaja	17
C. Dampak Kehamilan Tidak Diinginkan pada Remaja	20
D. Strategi Pencegahan Berbasis Pendidikan.....	23
E. Strategi Pencegahan Berbasis Keluarga dan Lingkungan.....	26
F. Akses terhadap Layanan Kesehatan Reproduksi Ramah Remaja.....	29
G. Kebijakan dan Regulasi dalam Pencegahan Kehamilan Remaja	32
H. Pemanfaatan Teknologi dan Media dalam Pencegahan.....	35
I. Peran Masyarakat dan Lembaga Swadaya	38
J. Simpulan	41
K. Daftar Pustaka.....	42
L. Glosarium.....	43

CHAPTER 3 INFeksi MENULAR SEKSUAL (IMS) PADA REMAJA47

Bd. Indah Yani Br. Tambunan, S. Tr. Keb. M. Kes.....	47
A. Pendahuluan/Prolog.....	47
B. Konsep Dasar Infeksi Menular Seksual (IMS).....	49

C. Tanda, Gejala, dan Komplikasi IMS pada Remaja	51
D. Pencegahan Infeksi Menular Seksual (IMS) pada Remaja	53
E. Diagnosis dan Pengobatan IMS pada Remaja	56
F. Aspek Psikososial pada Remaja dengan IMS	58
G. Peran Orang Tua, Guru, dan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanganan IMS pada Remaja	60
H. Tantangan dalam Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Menular Seksual (IMS) di Kalangan Remaja	63
I. Evaluasi Program Pencegahan dan Penanganan Infeksi Menular Seksual (IMS) pada Remaja	66
J. Simpulan	68
K. Daftar Pustaka	69
L. Glosarium	70

CHAPTER 4 MENSTRUASI DAN PERMASALAHAN TERKAIT PADA

REMAJA.....73

Bd. Nur Hidayah Afnas, S.ST, M.Biomed	73
A. Pendahuluan/Prolog	73
B. Fisiologi Menstruasi pada Remaja	74
C. Karakteristik Menstruasi pada Remaja	76
D. Permasalahan Menstruasi pada Remaja	77
E. Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Menstruasi pada Remaja	79
F. Dampak Permasalahan Menstruasi pada Remaja	80
G. Upaya Penanganan dan Pencegahan	82
H. Peran Orang Tua, Sekolah, dan Tenaga Kesehatan	84
I. Kebijakan dan Dukungan Lintas Sektor	85
J. Simpulan	86
K. Daftar Pustaka	87
L. Glosarium	88

CHAPTER 5 KESEHATAN MENTAL DAN SEKSUALITAS REMAJA91

Siti Komariyah, S.SiT,M.Kes	91
A. Pendahuluan/Prolog	91
B. Konsep Dasar Kesehatan Mental Remaja	92
C. Konsep Dasar Seksualitas Remaja	93
D. Isu dan Tantangan Kesehatan Mental Remaja	95
E. Hubungan Kesehatan Mental dengan Seksualitas	96
F. Strategi Promotif dan Preventif	97
G. Peran Bidan, Perawat, dan Tenaga Kesehatan	99
H. Simpulan	100
I. Daftar Pustaka	100
J. Glosarium	101

CHAPTER 6 PERAN STRATEGIS KEBIDANAN DALAM PENINGKATAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	103
Dr. Bd. Ika Nur Saputri, SST., M.Keb.....	103
A. Pendahuluan/Prolog.....	103
B. Konsep Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja.....	104
C. Kompetensi Bidan dalam Pelayanan Remaja.....	106
D. Peran Bidan dalam Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja	107
E. Peran Bidan dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja	108
F. Kolaborasi Bidan dengan Lintas Sektor	110
G. Inovasi Bidan dalam Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja	111
H. Tantangan dan Hambatan dalam Peran Kebidanan	113
I. Strategi dan Rekomendasi Penguatan Peran Kebidanan.....	114
J. Simpulan	115
K. Daftar Pustaka.....	116
L. Glosarium.....	117
PROFIL PENULIS	119

CHAPTER 1

EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

Dina Isfentiani, S.Kep.Ns., M.Ked.

A. Pendahuluan

Kesehatan reproduksi remaja merupakan isu penting yang perlu mendapat perhatian serius. Remaja adalah bagian dari kelompok usia yang rentan terhadap berbagai masalah kesehatan reproduksi, baik fisik maupun psikologis. Latar belakang kesehatan reproduksi remaja di Indonesia menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan yang perlu diatasi.

Remaja berada pada masa transisi dari anak-anak menuju masa dewasa, yang ditandai dengan perubahan fisik, emosi, dan sosial yang signifikan. Pada masa ini, remaja mulai mengeksplorasi identitas diri, termasuk identitas seksual. Apabila remaja, kurang mendapatkan pengetahuan dan informasi tentang kesehatan reproduksi dapat menjadikan remaja rentan terhadap berbagai masalah, termasuk masalah Kesehatan reproduksinya.

Beberapa permasalahan yang sering terjadi pada remaja tentang kesehatan reproduksi nya antara lain:

1. Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD): KTD dapat menyebabkan berbagai masalah, baik fisik maupun psikologis, bagi remaja,
2. Penyakit Menular Seksual (PMS): PMS seperti HIV/AIDS, sifilis, dan gonore dapat menyerang remaja yang tidak memiliki pengetahuan dan perilaku seksual yang sehat,
3. Aborsi: Aborsi dapat menyebabkan berbagai komplikasi, baik fisik maupun psikologis, bagi remaja,
4. Pernikahan Dini: Pernikahan dini dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk KTD dan PMS.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kejadian KTD pada remaja masih tinggi. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 1,2 juta kasus KTD pada remaja berusia 15-19 tahun. Selain itu, angka kejadian PMS juga meningkat pada kelompok usia remaja.

Beberapa faktor penyebab permasalahan kesehatan reproduksi remaja antara lain:1). Kurangnya Pengetahuan: Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan

reproduksi dapat membuat remaja rentan terhadap berbagai masalah, 2). Perilaku Seksual Berisiko: Perilaku seksual berisiko, seperti seks bebas dan tidak menggunakan kondom, dapat meningkatkan risiko PMS dan KTD, 3). Kurangnya Akses Layanan Kesehatan: Kurangnya akses layanan kesehatan reproduksi yang ramah dan komprehensif dapat membuat remaja kesulitan mendapatkan informasi dan layanan yang dibutuhkan.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan Kesehatan reproduksi remaja, antara lain: 1). Program Kesehatan Reproduksi Remaja: Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja tentang kesehatan reproduksi, 2). Layanan Kesehatan Reproduksi Ramah Remaja: Layanan ini bertujuan untuk menyediakan akses layanan kesehatan reproduksi yang ramah dan komprehensif bagi remaja, 3). Pendidikan Kesehatan Reproduksi: Pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja tentang kesehatan reproduksi.

Beberapa kebijakan Pemerintah Indonesia terkait dengan Kesehatan reproduksi remaja seperti tertuang pada Permenkes No 2 tahun 2025 pasal 14, 15 dan pasal 16 disampaikan bahwa dalam Upaya preventif kesehatan reproduksi pada remaja, dapat dilakukan melalui pemberian imunisasi tetanus difteri, human papilloma virus dan imunisasi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Skreening dan deteksi dini penyakit, pemberian suplemen gizi, pemberian lingkungan yang kondusif. Selain itu juga dilakukan dengan Upaya kuratif pada Kesehatan reproduksi dan tatalaksana rujukan sesuai dengan kondisi Kesehatan remaja serta Upaya rehabilitative system Kesehatan reproduksi melalui pelayanan pemulihan kondisi akibat kelainan penyakit pada system reproduksi.

B. Isu Terkini Kesehatan Reproduksi Remaja

1. Kehamilan Tidak Diinginkan (Ktd)

a. Definisi

Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) pada remaja adalah kehamilan yang tidak direncanakan atau diinginkan oleh remaja, baik karena kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, perilaku seksual berisiko, atau faktor lainnya.

KTD pada remaja juga dapat didefinisikan sebagai kehamilan yang terjadi pada remaja berusia 10-19 tahun yang tidak direncanakan atau diinginkan.

2. Risiko KTD

KTD pada remaja dapat terjadi beberapa risiko antara lain:

- a. Kurangnya Pengetahuan: Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan kontrasepsi dapat meningkatkan risiko KTD.

- b. Perilaku Seksual Berisiko: Perilaku seksual berisiko, seperti seks bebas dan tidak menggunakan kondom, dapat meningkatkan risiko KTD.
 - c. Kurangnya Akses Layanan Kesehatan: Kurangnya akses layanan kesehatan reproduksi yang ramah dan komprehensif dapat membuat remaja kesulitan mendapatkan informasi dan layanan yang dibutuhkan.
3. Penyebab KTD
- KTD pada remaja dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain:
- a. Kurangnya Pendidikan Kesehatan Reproduksi: Kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah dapat membuat remaja tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang kesehatan reproduksi.
 - b. Pengaruh Media Sosial: Pengaruh media sosial dapat membuat remaja terpapar pada informasi yang tidak akurat tentang kesehatan reproduksi.
 - c. Kurangnya Komunikasi dengan Orang Tua: Kurangnya komunikasi dengan orang tua dapat membuat remaja tidak memiliki dukungan yang cukup dalam menghadapi masalah kesehatan reproduksi.
4. Penanganan KTD
- Bila KTD sudah terjadi pada remaja, penanganan yang tepat sangat penting. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:
- a. Konsultasi dengan Tenaga Kesehatan: Remaja dapat berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan informasi dan layanan yang dibutuhkan.
 - b. Pendidikan dan Konseling: Pendidikan dan konseling dapat membantu remaja memahami pilihan yang tersedia dan membuat keputusan yang tepat.
 - c. Dukungan dari Orang Tua dan Masyarakat: Dukungan dari orang tua dan masyarakat sangat penting dalam membantu remaja menghadapi KTD.
5. Peran orang tua bila terjadi KTD
- Orang tua dapat berperan penting dalam membantu remaja menghadapi KTD, antara lain:
- a. Memberikan Dukungan Emosional: Orang tua dapat memberikan dukungan emosional kepada remaja yang mengalami KTD.
 - b. Membantu Mencari Informasi: Orang tua dapat membantu remaja mencari informasi yang akurat tentang KTD dan pilihan yang tersedia.
6. Peran Tenaga kesehatan dalam membantu remaja menghadapi KTD
- a. Memberikan Informasi yang Akurat: Tenaga kesehatan dapat memberikan informasi yang akurat tentang KTD dan pilihan yang tersedia.
 - b. Memberikan Layanan Kesehatan: Tenaga kesehatan dapat memberikan layanan kesehatan yang dibutuhkan oleh remaja yang mengalami KTD.
7. Peran penting Pemerintah dalam mencegah dan menangani KTD

- a. Mengembangkan Program Pendidikan Kesehatan Reproduksi: Pemerintah dapat mengembangkan program pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif untuk remaja.
 - b. Meningkatkan Akses Layanan Kesehatan: Pemerintah dapat meningkatkan akses layanan kesehatan reproduksi yang ramah dan komprehensif bagi remaja.
8. Peran Masyarakat yang sangat penting dalam membantu penyelesaian KTD pada remaja
- a. Memberikan Dukungan: Masyarakat dapat memberikan dukungan kepada remaja yang mengalami KTD.
 - b. Meningkatkan Kesadaran: Masyarakat dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan reproduksi remaja.

C. Perkawinan dan Pernikahan Dini

1. Definisi

Perkawinan dan pernikahan dini pada remaja adalah pernikahan yang terjadi pada usia remaja, yaitu antara 10-19 tahun, yang dapat memiliki dampak signifikan pada kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan remaja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dan pernikahan dini pada remaja

- a. Kurangnya Pengetahuan: Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan hak-hak perempuan dapat membuat remaja lebih rentan terhadap pernikahan dini.
- b. Tradisi dan Budaya: Tradisi dan budaya yang kuat dapat mempengaruhi keputusan remaja untuk menikah dini.
- c. Kemiskinan: Kemiskinan dapat membuat keluarga lebih cenderung untuk menikahkan anak perempuan mereka secara dini sebagai strategi untuk mengurangi beban ekonomi.

Pengaruh terhadap perkembangan mental remaja dengan perkawinan dan pernikahan dini pada remaja. Pernikahan dini dapat memiliki dampak signifikan pada perkembangan mental remaja, antara lain:

- a. Stres dan Kecemasan: Pernikahan dini dapat menyebabkan stres dan kecemasan pada remaja.
- b. Depresi: Remaja yang menikah dini lebih rentan terhadap depresi dan masalah kesehatan mental lainnya.
- c. Kurangnya Pendidikan: Pernikahan dini dapat menyebabkan remaja putus sekolah dan kurangnya kesempatan untuk meningkatkan pendidikan dan karir.

2. Peran Orang Tua

Orang tua dapat berperan penting dalam mencegah pernikahan dini pada remaja, antara lain:

- a. Memberikan Pendidikan: Orang tua dapat memberikan pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan hak-hak perempuan kepada remaja.
- b. Mendukung Pendidikan: Orang tua dapat mendukung pendidikan remaja dan membantu mereka mencapai tujuan akademis.

3. Peran Tokoh Agama

Tokoh agama dapat berperan penting dalam mencegah pernikahan dini pada remaja, antara lain:

- a. Memberikan Pendidikan: Tokoh agama dapat memberikan pendidikan tentang nilai-nilai agama dan hak-hak perempuan.
- b. Mendorong Kesadaran: Tokoh agama dapat mendorong kesadaran masyarakat tentang dampak pernikahan dini.

4. Peran Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat dapat berperan penting dalam mencegah pernikahan dini pada remaja, antara lain:

- a. Meningkatkan Kesadaran: Tokoh masyarakat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak pernikahan dini.
- b. Mendukung Pendidikan: Tokoh masyarakat dapat mendukung pendidikan remaja dan membantu mereka mencapai tujuan akademis.

D. Aborsi

1. Definisi

Aborsi pada remaja adalah tindakan mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan pada usia remaja, yaitu antara 10-19 tahun. Aborsi dapat dilakukan dengan menggunakan obat atau prosedur medis.

Beberapa faktor yang mempengaruhi remaja melakukan aborsi antara lain:

- a. Kurangnya Pengetahuan: Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan kontrasepsi dapat membuat remaja lebih rentan terhadap kehamilan tidak diinginkan.
- b. Tekanan Sosial: Tekanan sosial dari keluarga, teman, atau masyarakat dapat membuat remaja merasa tidak siap untuk memiliki anak sehingga dilakukan aborsi.
- c. Kurangnya Dukungan: Kurangnya dukungan dari keluarga atau pasangan dapat membuat remaja merasa tidak mampu untuk memiliki anak dan pada akhirnya aborsi merupakan pilihan remaja.

2. Peran dan sikap orang tua

Orangtua dapat berperan penting dalam menghadapi putrinya yang melakukan aborsi, antara lain:

- a. Memberikan Dukungan: Orangtua dapat memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada putrinya yang mengalami kehamilan tidak diinginkan.
- b. Membantu Mencari Informasi: Orangtua dapat membantu putrinya mencari informasi tentang pilihan yang tersedia dan membantu mereka membuat keputusan yang tepat.
- c. Meningkatkan Komunikasi: Orangtua dapat meningkatkan komunikasi dengan putrinya untuk memahami kebutuhan dan perasaan mereka.

3. Peran Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan dapat berperan penting dalam membantu remaja yang melakukan aborsi, antara lain:

- a. Memberikan Informasi: Tenaga kesehatan dapat memberikan informasi tentang pilihan yang tersedia dan membantu remaja membuat keputusan yang tepat.
- b. Memberikan Layanan Kesehatan: Tenaga kesehatan dapat memberikan layanan kesehatan yang aman dan berkualitas kepada remaja yang melakukan aborsi.
- c. Meningkatkan Kesehatan Mental: Tenaga kesehatan dapat membantu meningkatkan kesehatan mental remaja yang melakukan aborsi.

4. Peran Sekolah

Sekolah dapat berperan penting dalam menghadapi remaja yang melakukan aborsi, antara lain:

- a. Memberikan Pendidikan: Sekolah dapat memberikan pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan hak-hak perempuan kepada remaja.
- b. Meningkatkan Kesadaran: Sekolah dapat meningkatkan kesadaran remaja tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan hak-hak perempuan.
- c. Memberikan Dukungan: Sekolah dapat memberikan dukungan kepada remaja yang mengalami kehamilan tidak diinginkan atau melakukan aborsi.

5. Peran Masyarakat

Masyarakat dapat berperan penting dalam menghadapi remaja yang melakukan aborsi, antara lain:

- a. Meningkatkan Kesadaran: Masyarakat dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan hak-hak perempuan.
- b. Memberikan Dukungan: Masyarakat dapat memberikan dukungan kepada remaja yang mengalami kehamilan tidak diinginkan atau melakukan aborsi.
- c. Mengurangi Stigma: Masyarakat dapat mengurangi stigma terhadap remaja yang melakukan aborsi.

6. Peran Pemerintah dan Kebijakan

Pemerintah dapat berperan penting dalam menghadapi kasus aborsi, antara lain:

- a. Mengembangkan Kebijakan: Pemerintah dapat mengembangkan kebijakan yang mendukung kesehatan reproduksi dan hak-hak perempuan.
- b. Meningkatkan Akses Layanan Kesehatan: Pemerintah dapat meningkatkan akses layanan kesehatan reproduksi yang aman dan berkualitas.
- c. Meningkatkan Pendidikan: Pemerintah dapat meningkatkan pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan hak-hak Perempuan kepada remaja.

E. Peran Strategis Kebidanan

1. Edukasi Kesehatan Reproduksi

Beberapa topik yang dapat dibahas dalam edukasi kesehatan reproduksi pada remaja antara lain:

- a. Anatomi dan Fisiologi Reproduksi: Pengetahuan tentang anatomi dan fisiologi reproduksi dapat membantu remaja memahami bagaimana tubuh mereka bekerja
- b. Kontrasepsi dan Kesehatan Reproduksi: Pengetahuan tentang kontrasepsi dan kesehatan reproduksi dapat membantu remaja membuat keputusan yang tepat tentang kesehatan reproduksi mereka

- c. Pencegahan Penyakit Menular Seksual: Pengetahuan tentang pencegahan penyakit menular seksual dapat membantu remaja menghindari risiko penyakit menular seksual
- d. Kesehatan Mental dan Emosi: Pengetahuan tentang kesehatan mental dan emosi dapat membantu remaja mengelola stres dan emosi mereka

2. Metode Pelaksanaan Edukasi

Beberapa metode yang dapat digunakan dalam pelaksanaan edukasi kesehatan reproduksi pada remaja antara lain:

- a. Penyuluhan: Penyuluhan dapat dilakukan melalui ceramah, diskusi, atau presentasi.
- b. Media Interaktif: Media interaktif seperti video, game, atau aplikasi dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi.
- c. Peer Education: Peer education dapat dilakukan oleh remaja yang telah terlatih untuk memberikan edukasi kepada teman-teman mereka.

3. Waktu yang Tepat

Waktu yang tepat untuk pelaksanaan edukasi kesehatan reproduksi remaja adalah:

- a. Sekolah: Edukasi kesehatan reproduksi dapat dilakukan di sekolah sebagai bagian dari kurikulum.
- b. Komunitas: Edukasi kesehatan reproduksi dapat dilakukan di komunitas melalui penyuluhan atau kegiatan lainnya.

4. Pelaksana Edukasi

Pelaksana edukasi kesehatan reproduksi remaja dapat menunjuk:

- a. Guru atau Pendidik: Guru atau pendidik dapat menjadi pelaksana edukasi kesehatan reproduksi di sekolah.
- b. Tenaga Kesehatan: Tenaga kesehatan dapat menjadi pelaksana edukasi kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan.
- c. Remaja Terlatih: Remaja terlatih dapat menjadi pelaksana edukasi kesehatan reproduksi melalui peer education.

5. Tolok Ukur Evaluasi

Tolok ukur evaluasi pelaksanaan edukasi kesehatan reproduksi remaja dapat berupa:

- a. Pengetahuan: Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dapat diukur melalui tes atau kuesioner.
- b. Sikap: Sikap remaja terhadap kesehatan reproduksi dapat diukur melalui kuesioner atau wawancara.
- c. Perilaku: Perilaku remaja terkait kesehatan reproduksi dapat diukur melalui observasi atau kuesioner.

F. Pelibatan Remaja Sebagai Agent Perubahan

Penunjukkan remaja yang sesuai dan sebaya dalam pelaksanaan edukasi kesehatan reproduksi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi.

Karakteristik remaja yang dipilih harus memiliki:

1. Usia yang sesuai: Remaja yang dipilih harus memiliki usia yang sesuai dengan target audiens.
2. Pengetahuan yang cukup: Remaja yang dipilih harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang kesehatan reproduksi.
3. Kemampuan komunikasi yang baik: Remaja yang dipilih harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk menyampaikan informasi kepada teman-temannya.

1. Penyampaian Peran pada Remaja pelaksana edukasi

Penyampaian peran pada remaja yang ditunjuk dalam pelaksanaan edukasi kesehatan reproduksi sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memahami tanggung jawab mereka. Peran remaja yang ditunjuk dapat meliputi:

- a. Menyampaikan informasi: Remaja yang ditunjuk dapat menyampaikan informasi tentang kesehatan reproduksi kepada teman-temannya.
- b. Mengorganisir kegiatan: Remaja yang ditunjuk dapat mengorganisir kegiatan edukasi kesehatan reproduksi di sekolah atau komunitas.
- c. Meningkatkan kesadaran: Remaja yang ditunjuk dapat meningkatkan kesadaran teman-temannya tentang pentingnya kesehatan reproduksi.

2. Materi edukasi

Penyampaian materi yang sesuai kepada remaja yang ditunjuk sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang cukup tentang kesehatan reproduksi. Materi yang disampaikan dapat meliputi:

- a. Anatomi dan fisiologi reproduksi: Pengetahuan tentang anatomi dan fisiologi reproduksi dapat membantu remaja memahami bagaimana tubuh mereka bekerja.
- b. Kontrasepsi dan kesehatan reproduksi: Pengetahuan tentang kontrasepsi dan kesehatan reproduksi dapat membantu remaja membuat keputusan yang tepat tentang kesehatan reproduksi mereka.
- c. Pencegahan penyakit menular seksual: Pengetahuan tentang pencegahan penyakit menular seksual dapat membantu remaja menghindari risiko penyakit menular seksual.

3. Metode Edukasi

Penyampaian metode edukasi pada remaja yang ditunjuk sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menyampaikan informasi dengan efektif. Metode edukasi yang dapat digunakan meliputi:

- a. Penyuluhan: Penyuluhan dapat dilakukan melalui ceramah, diskusi, atau presentasi.
- b. Media interaktif: Media interaktif seperti video, game, atau aplikasi dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi.
- c. Peer education: Peer education dapat dilakukan oleh remaja yang telah terlatih untuk memberikan edukasi kepada teman-temannya.

G. Layanan Kesehatan Reproduksi Ramah Remaja

Layanan kesehatan reproduksi ramah remaja adalah layanan kesehatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksi remaja dengan cara yang ramah, aman, dan nyaman. Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi, serta memberikan akses yang mudah dan terjangkau untuk layanan kesehatan reproduksi.

Apa yang dapat diberikan pada remaja dalam layanan kesehatan reproduksi yang ramah? Dalam layanan kesehatan reproduksi ramah remaja, beberapa hal yang dapat diberikan pada remaja antara lain:

1. Informasi dan Edukasi: Informasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi, termasuk anatomi dan fisiologi reproduksi, kontrasepsi, dan pencegahan penyakit menular seksual.

2. Layanan Kesehatan Reproduksi: Layanan kesehatan reproduksi yang meliputi pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan konseling tentang kesehatan reproduksi.
3. Konseling dan Dukungan: Konseling dan dukungan untuk remaja yang menghadapi masalah kesehatan reproduksi, termasuk kehamilan tidak diinginkan, penyakit menular seksual, dan masalah kesehatan mental.
4. Akses Kontrasepsi: Akses kontrasepsi yang aman dan efektif untuk remaja yang membutuhkan.
5. Pengobatan dan Rujukan: Pengobatan dan rujukan untuk remaja yang membutuhkan perawatan lebih lanjut.

H. Tujuan Kesehatan Reproduksi Remaja

Kesehatan reproduksi remaja merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas hidup remaja. Tujuan kesehatan reproduksi remaja adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku sehat remaja dalam mengelola kesehatan reproduksinya.

1. Meningkatkan Pengetahuan Remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

Meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja sangat penting untuk membantu mereka membuat keputusan yang tepat tentang kesehatan reproduksinya. Pengetahuan yang cukup tentang kesehatan reproduksi dapat membantu remaja memahami bagaimana tubuh mereka bekerja, bagaimana mencegah penyakit menular seksual, dan bagaimana mengelola kesehatan reproduksinya.

2. Meningkatkan Kesadaran Remaja akan Pentingnya Kesehatan Reproduksi Remaja

Meningkatkan kesadaran remaja akan pentingnya kesehatan reproduksi remaja sangat penting untuk membantu mereka memahami bahwa kesehatan reproduksi adalah bagian penting dari kesehatan keseluruhan. Kesadaran yang tinggi tentang kesehatan reproduksi dapat membantu remaja membuat keputusan yang tepat tentang kesehatan reproduksinya dan menghindari perilaku berisiko.

3. Menekan Angka Kejadian Kasus Kesehatan Reproduksi Remaja

Menekan angka kejadian kasus kesehatan reproduksi remaja sangat penting untuk mengurangi dampak negatif kesehatan reproduksi pada remaja. Kasus kesehatan reproduksi remaja yang umum terjadi antara lain kehamilan tidak diinginkan, penyakit menular seksual, dan aborsi. Dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja tentang kesehatan reproduksi, kita dapat menekan angka kejadian kasus kesehatan reproduksi remaja.

I. Strategi Untuk Mencapai Tujuan Kesehatan Reproduksi Remaja

Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan kesehatan reproduksi remaja antara lain:

1. Pendidikan Kesehatan Reproduksi: Pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif dapat membantu remaja memahami tentang kesehatan reproduksi dan membuat keputusan yang tepat tentang kesehatan reproduksinya.
2. Layanan Kesehatan Reproduksi: Layanan kesehatan reproduksi yang ramah dan aksesibel dapat membantu remaja mendapatkan informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang mereka butuhkan.
3. Kampanye Kesadaran: Kampanye kesadaran tentang kesehatan reproduksi dapat membantu meningkatkan kesadaran remaja akan pentingnya kesehatan reproduksi.

J. Simpulan

Edukasi kesehatan reproduksi pada remaja merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas hidup remaja. Isu terkini yang dihadapi remaja dalam kesehatan reproduksi antara lain kehamilan tidak diinginkan, penyakit menular seksual, dan aborsi.

Kebidanan memiliki peran strategis dalam edukasi kesehatan reproduksi pada remaja. Kebidanan dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja tentang kesehatan reproduksi melalui pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif.

Tujuan kesehatan reproduksi remaja adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku sehat remaja dalam mengelola kesehatan reproduksinya. Tujuan ini dapat dicapai melalui pendidikan kesehatan reproduksi yang efektif, layanan kesehatan reproduksi yang ramah, dan kampanye kesadaran tentang kesehatan reproduksi.

Edukasi kesehatan reproduksi pada remaja sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku sehat remaja dalam mengelola kesehatan reproduksinya. Kebidanan memiliki peran strategis dalam edukasi kesehatan reproduksi pada remaja dan dapat membantu mencapai tujuan kesehatan reproduksi remaja.

K. Daftar Pustaka

- Adolescent Pregnancy and Parenting: A Review of the Literature (Journal of Youth and Adolescence, Vol. 47, No. 4, 2018, DOI: 10.1007/s10964-017-0754-5).
- Advocates for Youth. (2019). Guidelines for Comprehensive Sexuality Education.

Dartiwen Dartiwen, Mira Aryanti (2024), Analisis Faktor Penyebab Kehamilan Tidak Diinginkan Pada Remaja, Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan, vol 15, no 1, DOI: <https://doi.org/10.26751/jikk.v15i1.2149>

Guttmacher Institute. (2020). Adolescent Abortion.

International Planned Parenthood Federation. (2020), Sexual and Reproductive Health Education.

International Planned Parenthood Federation. (2020). Peer Education.

International Planned Parenthood Federation. (2020). Youth-Friendly Sexual and Reproductive Health Services.

Journal of Adolescent Health. (2019). The Impact of Peer Education on Adolescent Sexual Health. Vol. 64, No. 4.

Journal of Adolescent Health. (2019). The Impact of Sexuality Education on Adolescent Sexual Health. Vol. 64, No. 4.

Journal of Adolescent Health. (2019). Youth-Friendly Health Services: A Review of the Literature. Vol. 64, No. 4.

Journal of Adolescent Health. (2020). Abortion Among Adolescents: A Systematic Review. Vol. 66, No. 4.

Journal of Adolescent Health. (2020). Unintended Pregnancy among Adolescents: A Systematic Review. Vol. 66, No. 4.

Jurnal Keluarga dan Konseling, Vol 6, No.1 (2018), Peran Orang Tua dalam Mencegah Kehamilan Tidak Diinginkan pada Remaja

Jurnal Kesehatan Reproduksi, Vol.10, No.2, (2020), Kehamilan Tidak Diinginkan pada Remaja: Faktor Penyebab dan Dampak

Jurnal Kesehatan Reproduksi. (2020). Pernikahan Dini pada Remaja: Faktor Penyebab dan Dampak. Vol. 10, No. 2.

Jurnal pendidikan Kesehatan, Vol 8, No.1 (2019), Pendidikan Kesehatan Reproduksi untuk Remaja: Sebuah Tinjauan Literatur

Kementerian Kesehatan RI. (2020). Pedoman Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak

Save the Children. (2019). The Impact of Abortion on Adolescent Girls.

Save the Children. (2019). The Impact of Early Marriage on Girls' Education

The Impact of Reproductive Health Education on Adolescent Pregnancy (Journal of School Health, Vol. 89, No. 6, 2019, DOI: 10.1111/josh.12764).

UNICEF. (2019). Early and Forced Marriage.

UNICEF. (2019). Early Marriage: A Harmful Practice That Must End.

UNICEF. (2020). Comprehensive Sexuality Education.

Unintended Pregnancy among Adolescents: A Systematic Review (Journal of Adolescent Health, Vol. 66, No. 4, 2020, DOI: 10.1016/j.jadohealth.2019.11.306).

WHO. (2019). Adolescent Sexual and Reproductive Health.

WHO. (2020). Adolescent Pregnancy.

CHAPTER 2

PENCEGAHAN KEHAMILAN TIDAK DIINGINKAN PADA REMAJA

Bdn. Ida Susila, SST., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

1. Gambaran umum masalah kehamilan tidak diinginkan pada remaja

Kehamilan tidak diinginkan pada remaja merupakan fenomena kompleks yang terjadi ketika kehamilan muncul di luar rencana, kesiapan, atau persetujuan yang matang dari pihak remaja dan lingkungannya. Masa remaja adalah periode transisi yang ditandai oleh perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang cepat; pada fase ini, kemampuan kognitif dan emosi masih berkembang sementara pengaruh teman sebaya, media, dan norma sosial kerap menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan. Di tengah dinamika tersebut, keterbatasan literasi kesehatan reproduksi, mitos seputar seksualitas, rendahnya keterampilan negosiasi dan penolakan, serta akses layanan kesehatan yang belum ramah remaja dapat memperbesar kerentanan terhadap perilaku berisiko yang berujung kehamilan yang tidak direncanakan.

Konteks keluarga dan masyarakat turut memberi warna. Komunikasi orang tua remaja yang minim, pengasuhan yang terlalu permisif atau sebaliknya sangat otoriter, serta pola asuh yang tidak sensitif terhadap kebutuhan psikososial remaja, dapat memunculkan keputusan impulsif. Di sisi lain, ketimpangan gender dan relasi kuasa termasuk tekanan pasangan, kekerasan seksual, atau paksaan halus dapat membuat remaja perempuan sulit menegosiasikan hubungan yang aman. Lingkungan digital yang serbaterhubung menghadirkan informasi yang tidak selalu akurat; tanpa pendampingan, remaja dapat mengandalkan sumber yang menyesatkan mengenai kontrasepsi, persetujuan seksual, dan batasan risiko. Semua faktor ini membentuk “ekologi risiko” yang saling berkelindan, menjadikan kehamilan tidak diinginkan pada remaja bukan sekadar persoalan individu, melainkan isu kesehatan masyarakat dan pembangunan manusia.

2. Dampak kesehatan, psikologis, sosial, dan ekonomi

Kehamilan tidak diinginkan pada remaja membawa konsekuensi kesehatan yang nyata. Secara fisik, remaja hamil memiliki risiko lebih tinggi mengalami anemia, kelahiran prematur, bayi berat lahir rendah, hingga komplikasi obstetri tertentu karena kondisi biologis yang belum sepenuhnya matang dan keterlambatan akses antenatal yang memadai. Risiko infeksi, kekurangan gizi, serta gangguan pemulihan pascapersalinan juga meningkat ketika kehamilan tidak dipersiapkan dengan baik. Pada situasi tertentu, remaja dapat menempuh pilihan yang tidak aman untuk mengakhiri kehamilan, yang berpotensi menimbulkan komplikasi serius.

Dari sisi psikologis, kehamilan yang tidak direncanakan menimbulkan stres, rasa bersalah, cemas, dan depresi. Identitas diri remaja yang sedang dibentuk bisa terguncang, memunculkan konflik intrapersonal dan interpersonal, termasuk dengan orang tua, pasangan, dan teman sebaya. Stigma sosial kerap memperparah tekanan mental, menurunkan rasa percaya diri, dan menghambat remaja mencari dukungan. Pada sebagian kasus, relasi dengan pasangan menjadi tidak stabil, meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan dalam pacaran atau rumah tangga di usia sangat muda.

Dampak sosialnya tampak pada putus sekolah, penurunan prestasi, dan terhambatnya kelanjutan studi. Berkurangnya peluang pendidikan akan berimbas pada akses pekerjaan formal di masa depan, menurunkan pendapatan sepanjang siklus kehidupan, dan memperkuat lingkaran kemiskinan. Stigma komunitas dapat mengisolasi remaja dari jejaring dukungan, sementara ketidakmatangan ekonomi keluarga memaksa kompromi yang merugikan, seperti pernikahan dini atau pekerjaan informal berisiko. Konsekuensi ini bukan hanya dialami remaja perempuan; remaja laki-laki yang menjadi ayah juga menghadapi beban psikososial dan ekonomi, terutama jika dukungan keluarga dan sistem belum siap. Pada akhirnya, anak yang lahir dari kehamilan remaja berisiko menghadapi keterbatasan stimulasi perkembangan, nutrisi tidak optimal, dan lingkungan pengasuhan yang penuh tekanan menciptakan dampak antargenerasi yang menghambat kualitas sumber daya manusia.

3. Pentingnya upaya pencegahan berbasis keluarga, sekolah, masyarakat, dan kebijakan

Pencegahan kehamilan tidak diinginkan pada remaja menuntut pendekatan yang holistik, berlapis, dan berkesinambungan. Di tingkat keluarga, komunikasi hangat dan terbuka mengenai nilai, relasi sehat, batasan, serta kesehatan reproduksi terbukti menjadi fondasi protektif yang kuat. Orang tua yang hadir, responsif, dan konsisten dapat membangun kepercayaan sehingga remaja

merasa aman berdiskusi tentang rasa ingin tahu, tekanan teman sebaya, dan dilema etis tanpa takut dihakimi. Keterlibatan ayah dan figur pengasuhan lain sama pentingnya, karena memberikan teladan relasi yang setara dan menghargai persetujuan dalam setiap interaksi.

Sekolah menjadi ruang strategis untuk menyelenggarakan pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif, berjenjang sesuai usia, dan berbasis bukti. Kurikulum yang tidak hanya menyampaikan aspek biologis, tetapi juga keterampilan hidup seperti pengambilan keputusan, penolakan yang asertif, literasi digital, empati, dan resolusi konflik, akan memperlengkapi remaja menghadapi situasi nyata. Layanan konseling di sekolah, rujukan ke fasilitas kesehatan, serta kegiatan teman sebaya terlatih dapat memperkuat dampak pembelajaran. Sinergi sekolah dengan puskesmas, posyandu remaja, dan organisasi kepemudaan memperluas akses ke informasi yang kredibel dan layanan yang sensitif terhadap kebutuhan remaja.

Pada tataran masyarakat, norma dan budaya yang mendukung relasi sehat perlu dipupuk. Keterlibatan tokoh masyarakat, pemuka agama, organisasi pemuda, dan media lokal dapat menggeser wacana dari stigma dan larangan semata menjadi percakapan konstruktif tentang tanggung jawab, kesetaraan gender, dan persetujuan. Pusat kegiatan remaja yang aman baik luring maupun daring dapat menjadi "ruang aman" untuk belajar, berdiskusi, dan mencari bantuan. Penggunaan teknologi melalui kampanye digital, aplikasi edukasi, dan telekonseling menambah jangkauan, terutama bagi remaja di wilayah dengan keterbatasan layanan.

Kebijakan publik menjadi payung yang memastikan ekosistem pencegahan berjalan. Regulasi yang memperkuat perlindungan anak dan remaja, mencegah pernikahan usia anak, serta menindak kekerasan seksual adalah prasyarat yang tidak bisa ditawar. Di bidang kesehatan, layanan ramah remaja yang menjamin kerahasiaan, nondiskriminasi, dan akses informasi serta konseling kontrasepsi yang akurat perlu tersedia di lini primer. Di sektor pendidikan, kebijakan sekolah ramah remaja dan mekanisme "kembali bersekolah" bagi remaja hamil atau pascapersalinan penting untuk memutus rantai putus sekolah. Dukungan lintas sector kesehatan, pendidikan, sosial, hukum, dan ketenagakerjaan harus diorkestrasi agar program saling menguatkan, bukan berjalan sendiri-sendiri.

B. Faktor Penyebab Kehamilan Tidak Diinginkan pada Remaja

Kehamilan tidak diinginkan pada remaja lahir dari interaksi banyak lapisan individu, keluarga, teman sebaya, sekolah, komunitas, hingga kebijakan. Di tingkat pribadi, perkembangan biologis dan psikologis yang masih berlangsung membuat

remaja lebih peka terhadap dorongan dan imbalan jangka pendek. Di tingkat relasional, kualitas komunikasi dengan orang tua dan pasangan, serta norma kelompok sebaya, membentuk cara remaja menilai risiko dan membuat keputusan. Lingkungan yang lebih luas budaya, media, ekonomi, dan akses layanan menentukan apakah informasi yang diterima akurat, dukungan tersedia, dan pilihan aman dapat diakses. Empat kelompok faktor berikut kerap saling tumpang-tindih dan memperkuat, sehingga perlu dipahami sebagai satu ekosistem, bukan sebab tunggal yang berdiri sendiri.

1. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi

Defisit literasi kesehatan reproduksi membuat remaja kesulitan memahami kapan kehamilan dapat terjadi, bagaimana persetujuan seksual yang sehat, dan apa pilihan pencegahannya. Banyak remaja keliru mengenai masa subur, mengira hubungan seksual “pertama kali” tidak menyebabkan kehamilan, atau menilai metode tidak efektif seperti senggama terputus dan douching sebagai pelindung memadai. Pengetahuan tentang kontrasepsi modern cara kerja, efektivitas, efek samping, dan cara mendapatkan sering kali dangkal atau bercampur mitos, misalnya anggapan bahwa kontrasepsi selalu menyebabkan kemandulan atau mengganggu pertumbuhan. Minimnya pemahaman tentang infeksi menular seksual, termasuk kaitannya dengan risiko kehamilan melalui peradangan dan luka mukosa, menambah kompleksitas pengambilan keputusan.

Kesenjangan informasi ini bukan hanya akibat kurangnya materi di sekolah, melainkan juga cara penyampaian yang moralistik, penuh larangan, dan jarang memberi ruang dialog. Pelajaran yang terlalu menekankan aspek biologis tanpa membekali keterampilan hidup komunikasi asertif, negosiasi batas, penolakan, dan perencanaan membuat remaja memahami “apa itu reproduksi” tetapi tidak terampil mengatakan “tidak” atau merencanakan “bagaimana tetap aman”. Di sisi layanan, sebagian remaja ragu bertanya karena takut dihakimi, khawatir kerahasiaan tidak terjaga, atau terhalang syarat administratif. Alhasil, keputusan penting kerap diambil berdasarkan potongan informasi dari teman, unggahan media sosial, atau iklan yang bias.

2. Pengaruh lingkungan sosial, budaya, dan media

Norma budaya dan harapan sosial membingkai cara remaja memandang seksualitas dan peran gender. Di sebagian komunitas, percakapan terbuka tentang seks dianggap tabu, sehingga remaja mencari jawaban di tempat lain yang belum tentu kredibel. Di sisi lain, standar ganda gender masih kuat: perilaku seksual remaja laki-laki kerap ditoleransi, sementara remaja perempuan menanggung stigma lebih berat. Tekanan teman sebaya keinginan “menjadi sama” atau diterima dapat mendorong keputusan impulsif, terutama ketika keberanian dinilai sebagai bukti kedewasaan. Kondisi keluarga dengan pengawasan longgar atau sebaliknya sangat otoriter, konflik yang sering, serta keterbatasan waktu orang tua karena beban kerja juga memperlemah jejaring protektif di rumah.

Media massa dan terutama media sosial membentuk lanskap baru. Paparan konten seksual yang glamor, romantisasi hubungan tanpa membahas konsekuensi, serta arus “edukasi” yang tidak terverifikasi menciptakan persepsi risiko yang bias. Algoritma yang mengulang konten serupa mempersempit sudut pandang, sementara pengaruh selebritas atau influencer memberi model perilaku yang mudah ditiru. Praktik pergaulan digital sexting, grooming, hingga eksploitasi berbasis gambar menambah jalur risiko, terlebih bila remaja belum mahir memilah privasi, persetujuan, dan keamanan digital. Di wilayah urban miskin maupun pedesaan, faktor struktural seperti kemiskinan, putus sekolah, dan kurangnya sarana rekreasi sehat mendorong remaja mencari pelarian pada aktivitas berisiko.

3. Faktor psikologis dan perilaku berisiko

Masa remaja ditandai ketidakseimbangan perkembangan antara sistem pencari imbalan dan kontrol diri. Sensasi mencari pengalaman baru, kebutuhan akan pengakuan, serta persepsi “tidak akan terjadi pada saya” mendorong perilaku berisiko. Impulsivitas, regulasi emosi yang belum mapan, dan bias optimisme membuat pencegahan yang memerlukan perencanaan seperti menyiapkan kondom atau mengikuti jadwal kontrasepsi sering diabaikan. Gangguan kesehatan mental (kecemasan, depresi), pengalaman masa kecil yang merugikan, maupun trauma kekerasan memperbesar kemungkinan mencari pelarian melalui perilaku seksual yang tidak aman sebagai bentuk coping.

Penggunaan alkohol dan zat adiktif menurunkan kewaspadaan, melemahkan penilaian risiko, dan mengganggu kemampuan bernegosiasi. Dalam situasi pesta atau kumpul malam, keputusan sering diambil spontan dengan informasi terbatas. Debut seksual yang terlalu dini tanpa kesiapan pengetahuan dan keterampilan komunikasi mempertinggi ketidakonsistenan penggunaan

kontrasepsi. Relasi yang tidak seimbang misalnya pasangan jauh lebih tua atau dominan menekan kemampuan remaja menetapkan batas dan menolak hubungan tanpa perlindungan. Semua ini membentuk pola perilaku yang, tanpa intervensi, berulang dan menguat.

4. Ketidaksetaraan gender dan kekerasan seksual

Ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang tertanam dalam norma, praktik sosial, dan struktur ekonomi menjadi tanah subur kehamilan tidak diinginkan. Remaja perempuan sering kali memikul tanggung jawab reproduksi tanpa hak yang setara untuk menentukan, sementara remaja laki-laki didorong menunjukkan “maskulinitas” lewat dominasi dan inisiatif seksual. Dalam relasi semacam ini, negosiasi kontrasepsi menjadi berat sebelah; permintaan penggunaan kondom dapat dianggap “tidak percaya” atau memicu konflik, sehingga remaja memilih mengalah demi mempertahankan hubungan. Perkawinan usia anak, yang masih terjadi di sebagian komunitas, memutus akses pendidikan dan layanan kesehatan remaja perempuan serta mendorong kehamilan dini karena peran istri-ibu melekat sejak awal.

Kekerasan seksual mulai dari tekanan halus, paksaan emosional, pemaksaan hubungan intim, hingga pemerkosaan langsung menempatkan remaja pada risiko kehamilan yang tidak diinginkan. Banyak kasus tidak dilaporkan karena rasa malu, takut menyalahkan diri, ancaman pelaku, atau ketidakpercayaan pada mekanisme pelaporan. Hambatan akses terhadap layanan pascakekerasan konseling, kontrasepsi darurat, profilaksis infeksi, dan pendampingan hukum membuat peluang pencegahan kehamilan dan pemulihan psikologis terlewat. Di ranah digital, kekerasan berbasis gender seperti penyebaran konten intim tanpa persetujuan dan pemerasan seksual memperluas kendali pelaku atas korban, mengurung remaja dalam lingkaran diam dan ketidakberdayaan. Tanpa kebijakan tegas, layanan ramah korban, dan perubahan norma yang menempatkan persetujuan serta kesetaraan sebagai nilai utama, ketidaksetaraan dan kekerasan ini akan terus mereproduksi kehamilan tidak diinginkan di kalangan remaja.

C. Dampak Kehamilan Tidak Diinginkan pada Remaja

Kehamilan yang terjadi pada masa remaja terlebih ketika tidak direncanakan bukan sekadar peristiwa biologis, melainkan sebuah kejadian yang mengguncang lintasan perkembangan pribadi dan sosial. Dampaknya menjalar dari kesehatan fisik dan reproduksi, kondisi psikologis, hubungan sosial serta pendidikan, hingga konsekuensi jangka panjang yang dapat memengaruhi kualitas hidup ibu remaja dan anaknya. Memahami spektrum dampak ini membantu perancang program dan praktisi kesehatan merumuskan intervensi yang nyata, sensitif, dan berkelanjutan.

1. Dampak fisik dan kesehatan reproduksi

Secara biologis, tubuh remaja masih berada dalam fase pematangan. Kehamilan pada fase ini meningkatkan kerentanan terhadap berbagai komplikasi, terutama bila akses ke layanan kesehatan terbatas atau baru dijangkau pada trimester lanjut. Ibu remaja lebih sering datang dengan status gizi yang belum optimal, sehingga mudah mengalami anemia yang berkaitan dengan kelelahan, daya tahan tubuh menurun, dan risiko perdarahan saat persalinan. Ketidaksiapan anatomi panggul dapat meningkatkan kemungkinan ketidakselarasan ukuran kepala janin dengan panggul ibu, yang pada gilirannya berisiko memanjang-nya proses persalinan, kelelahan ibu, dan tindakan obstetri darurat. Dalam kehamilan remaja, keteraturan kunjungan antenatal sering kali terhambat oleh stigma, kurangnya dukungan keluarga, atau ketidaktahuan tentang tanda bahaya; hal ini membuat kondisi seperti tekanan darah tinggi dalam kehamilan, preeklamsia, infeksi saluran kemih, atau gangguan pertumbuhan janin terdeteksi terlambat.

Konsekuensi terhadap bayi juga signifikan. Bayi dari ibu remaja memiliki peluang lebih besar lahir dengan berat badan rendah, prematur, dan memerlukan perawatan neonatal intensif. Risiko ini dipengaruhi oleh gizi ibu, jarak kehamilan yang terlalu dekat, serta paparan perilaku berisiko seperti merokok atau konsumsi alkohol pada sebagian remaja. Pada konteks kehamilan yang tidak diinginkan, sebagian remaja memilih mengakhiri kehamilan dengan cara tidak aman karena takut atau minimnya akses layanan; tindakan semacam ini meningkatkan risiko perdarahan hebat, infeksi, kerusakan rahim, hingga gangguan kesuburan pada masa depan. Setelah persalinan, masa nifas dapat diwarnai tantangan seperti pembengkakan payudara, infeksi, dan kesulitan menyusui, apalagi bila dukungan laktasi lemah. Kurangnya pengetahuan dan dukungan terhadap kontrasepsi pascapersalinan juga membuka peluang kehamilan berulang dalam jarak yang sangat dekat, yang kian menambah beban kesehatan ibu remaja.

2. Dampak psikologis dan emosional

Kehamilan yang tidak direncanakan pada masa remaja mengganggu tugas-tugas perkembangan psikologis penting: pembentukan identitas diri, kemandirian, dan ketrampilan mengelola relasi. Banyak remaja mengalami ambivalensi—campuran rasa sayang, takut, bingung, dan marah—yang dapat berayun dari hari ke hari. Tekanan dari pasangan, keluarga, dan lingkungan sosial memicu perasaan terisolasi atau disalahkan, sementara stigma menahan remaja untuk mencari bantuan. Kondisi ini meningkatkan risiko gangguan kecemasan, depresi, hingga pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Bila kehamilan terjadi akibat paksaan atau kekerasan, lapisan trauma membuat gejala seperti kilas balik, mimpi buruk, dan hiperwaspada semakin mungkin dialami.

Setelah persalinan, perubahan hormonal, kurang tidur, dan tanggung jawab pengasuhan yang tiba-tiba dapat memicu kesedihan pascapersalinan, bahkan depresi pascapersalinan. Pada remaja, gejalanya kerap tersamar sebagai "rewel" atau "malas," sehingga dukungan datang terlambat. Relasi dengan pasangan juga teruji: ketidakmatangan emosi dan ekonomi dapat memantik konflik, kecemburuan, atau kekerasan dalam pacaran. Tanpa konseling dan jejaring dukungan, tekanan psikologis mudah berlarut, memengaruhi cara ibu merawat diri dan bayinya, serta mengganggu proses ikatan emosional yang sehat antara ibu dan anak.

3. Dampak sosial, pendidikan, dan ekonomi

Di ranah sosial, kehamilan remaja sering kali memutus ritme kehidupan yang sedang dibangun. Banyak remaja berhenti sekolah sementara atau permanen karena malu, aturan sekolah yang tidak akomodatif, atau keharusan merawat bayi. Putus sekolah mengurangi kesempatan mereka mengakses pendidikan tinggi dan pekerjaan formal, yang pada akhirnya menekan pendapatan sepanjang kehidupan kerja. Ketika dukungan keluarga terbatas, remaja rentan terjebak dalam pernikahan dini sebagai "solusi," yang ironisnya memperkuat ketergantungan ekonomi dan membatasi otonomi. Biaya kehamilan, persalinan, dan pengasuhan bayi menjadi beban nyata bagi keluarga, terutama yang sudah berada pada kondisi rentan sosial ekonomi.

Di tingkat komunitas, stigma terhadap ibu remaja dapat berujung pada pengucilan halus: undangan yang berkurang, gosip, atau layanan publik yang dipersulit. Sementara itu, remaja laki-laki yang menjadi ayah sering luput dari perhatian program padahal keterlibatan mereka amat menentukan stabilitas ekonomi dan emosional keluarga muda. Ketika lingkungan tidak menyediakan layanan ramah remaja, penitipan anak yang terjangkau, atau jalur kembali bersekolah, maka peluang remaja untuk memulihkan jalur pendidikannya kian menyempit. Akumulasi faktor-faktor ini menciptakan lingkaran yang saling menguatkan antara kemiskinan, kesehatan yang rapuh, dan keterbatasan kesempatan.

4. Konsekuensi jangka panjang bagi ibu remaja dan bayi

Dampak kehamilan remaja tidak berhenti pada masa nifas; ia beresonansi sepanjang daur kehidupan. Bagi ibu, pendidikan yang terhenti dan terbatasnya pengalaman kerja formal menurunkan daya saing di pasar kerja, sehingga pendapatan rata-rata seumur hidup cenderung lebih rendah. Ketergantungan ekonomi yang bertahan lama memengaruhi posisi tawar dalam rumah tangga dan mempersulit akses pada layanan kesehatan berkualitas. Dari sisi kesehatan reproduksi, riwayat persalinan dini terutama bila berulang berkaitan dengan

peningkatan risiko komplikasi pada kehamilan-kehamilan berikutnya. Gangguan psikologis yang tidak tertangani, seperti depresi atau kecemasan kronis, dapat menyelimuti pola asuh, mengurangi sensitivitas terhadap kebutuhan bayi, dan mengganggu kualitas ikatan ibu-anak.

Bagi bayi, awal kehidupan yang sarat keterbatasan berpotensi membentuk lintasan perkembangan yang menantang. Bayi yang lahir prematur atau dengan berat badan rendah berisiko mengalami keterlambatan tumbuh kembang, masalah belajar, dan kerentanan terhadap infeksi pada tahun-tahun awal. Lingkungan pengasuhan yang penuh tekanan karena kemiskinan, dukungan sosial minim, atau kesehatan mental ibu yang rapuh dapat membatasi stimulasi kognitif dan emosional yang dibutuhkan anak untuk berkembang optimal. Pada jangka panjang, anak dari ibu remaja lebih rentan mengalami hambatan prestasi akademik, putus sekolah, dan bahkan mengulangi pola kehamilan remaja pada generasi berikutnya. Inilah yang disebut dampak antargenerasi: ketika hambatan di awal kehidupan tidak diatasi, ia berpotensi menurunkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan ekonomi keluarga di masa mendatang.

D. Strategi Pencegahan Berbasis Pendidikan

Pendidikan merupakan benteng pertama yang menempatkan remaja sebagai subjek yang berdaya, bukan sekadar objek perlindungan. Di dalamnya, pencegahan kehamilan tidak diinginkan tidak dipahami semata sebagai larangan terhadap perilaku, melainkan sebagai proses pembelajaran jangka panjang yang membangun pengetahuan yang tepat, sikap yang sehat, dan keterampilan praktis untuk mengambil keputusan. Strategi yang efektif selalu menautkan sekolah, keluarga, layanan kesehatan, dan komunitas dalam satu ekosistem, dengan kurikulum yang komprehensif, tenaga pendidik yang kompeten, orang tua yang terlibat, serta pengalaman belajar yang aplikatif dan berpusat pada remaja.

1. Pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah

Pendidikan kesehatan reproduksi yang efektif di sekolah harus komprehensif, berjenjang sesuai usia, dan berorientasi pada keterampilan, bukan sekadar daftar fakta biologis. Materi yang disampaikan tidak hanya mencakup anatomi, pubertas, dan proses reproduksi, tetapi juga persetujuan dalam relasi, kesetaraan gender, perlindungan dari kekerasan, pencegahan infeksi menular seksual, serta informasi akurat tentang kontrasepsi modern beserta efektivitas, cara pakai, dan aksesnya. Pendekatan komprehensif berarti mengaitkan pengetahuan dengan keterampilan nyata: bagaimana menyampaikan penolakan secara tegas dan aman, bagaimana bernegosiasi dengan pasangan, bagaimana mencari bantuan profesional tanpa rasa takut, dan bagaimana mengevaluasi

informasi yang beredar di media sosial. Pembelajaran semestinya kontekstual dengan budaya setempat, menggunakan bahasa yang menghormati nilai keluarga, serta menegaskan bahwa tujuan utama pendidikan adalah keselamatan, kesehatan, dan masa depan remaja, bukan mendorong mereka berperilaku seksual.

Metode pengajaran berperan besar dalam keberhasilan program. Kelas yang partisipatif melalui diskusi studi kasus, permainan peran, simulasi pengambilan keputusan, atau proyek kampanye sekolah membantu remaja mempraktikkan keterampilan dalam situasi yang aman. Integrasi lintas mata pelajaran membuat pesan kunci lebih kuat: topik persetujuan dan empati dapat muncul di pendidikan karakter; literasi media dan verifikasi informasi masuk dalam pelajaran TIK; statistik tentang risiko dan efektivitas kontrasepsi dibahas di matematika. Sekolah juga perlu memastikan adanya mekanisme rujukan yang jelas menuju layanan ramah remaja di puskesmas atau klinik, termasuk akses konseling privat yang menjaga kerahasiaan. Evaluasi program dilakukan bukan hanya melalui ulangan, melainkan lewat pengukuran perubahan sikap, kepercayaan diri, dan niat berperilaku aman, sehingga sekolah mengetahui bagian mana yang perlu dikuatkan dari waktu ke waktu.

2. Peran guru, tenaga kesehatan, dan konselor

Guru memegang peran sebagai fasilitator yang menciptakan suasana kelas aman, nonjudgmental, dan menghargai keragaman pengalaman remaja. Mereka menata aturan diskusi yang melindungi kerahasiaan, merespons pertanyaan dengan bahasa yang netral dan berbasis bukti, serta peka terhadap tanda-tanda kerentanan seperti perundungan, gejala depresi, atau indikasi kekerasan dalam pacaran. Guru bimbingan konseling menjadi garda terdepan dalam dukungan individual: menyediakan sesi konseling privat, melakukan asesmen sederhana atas risiko, dan menghubungkan siswa dengan layanan psikologis atau kesehatan reproduksi ketika diperlukan. Konselor harus dibekali pendekatan berperspektif trauma agar mampu menangani pengungkapan kekerasan dengan aman, menghindari menyalahkan korban, dan memastikan rujukan cepat ke layanan medis, hukum, dan perlindungan.

Tenaga kesehatan bidan, perawat, dokter puskesmas melengkapi peran sekolah melalui edukasi yang akurat dan layanan langsung. Kehadiran mereka di sekolah dalam bentuk kelas tematik berkala, skrining kesehatan, atau klinik keliling memperkecil jarak antara pengetahuan dan akses. Di sisi layanan, mereka menyediakan konseling kontrasepsi yang ramah remaja, menjelaskan pilihan dan efek samping dengan bahasa yang mudah dipahami, serta menjamin kerahasiaan. Kolaborasi formal antara sekolah dan fasilitas kesehatan dituangkan dalam alur

rujukan yang sederhana: siapa dihubungi, bagaimana prosedur izin, dan bagaimana tindak lanjutnya. Ketika setiap pihak memahami perannya dan berkoordinasi dengan mulus, remaja tidak dibiarkan berpindah-pindah layanan tanpa kepastian.

3. Edukasi berbasis keluarga

Keluarga adalah ruang pertama tempat nilai, sikap, dan keterampilan hidup ditanamkan. Edukasi berbasis keluarga bertujuan memperkuat komunikasi orang tua–remaja yang hangat, terbuka, dan saling menghormati. Banyak keluarga merasa canggung membahas seksualitas; karena itu sekolah dan puskesmas dapat menyediakan kelas orang tua yang membekali mereka dengan pengetahuan dasar, cara menjawab pertanyaan sulit, dan strategi memulai percakapan tanpa menghakimi. Pendekatan yang efektif mengakui peran nilai agama dan budaya, namun mengarahkan diskusi pada tujuan bersama: menjaga kesehatan, keselamatan, dan masa depan anak. Ayah perlu dilibatkan setara dengan ibu, karena keterlibatan figur ayah dengan teladan komunikasi menghormati batas dan persetujuan terbukti protektif bagi remaja.

Di tingkat praktik, keluarga dapat membangun “ritual komunikasi” yang teratur, misalnya waktu mingguan untuk saling berbagi pengalaman dan kekhawatiran. Orang tua membantu remaja membuat rencana aman ketika menghadapi tekanan teman sebaya, menyepakati batasan pergaulan dan penggunaan gawai, serta memetakan sumber bantuan jika terjadi keadaan darurat. Untuk keluarga rentan misalnya orang tua tunggal atau keluarga pekerja dengan waktu terbatas dukungan komunitas dan teknologi menjadi penting: grup WhatsApp orang tua, modul digital singkat, atau sesi tatap muka singkat di posyandu remaja memudahkan edukasi berkelanjutan. Ketika keluarga merasa didukung dan memiliki alat untuk berdialog, remaja cenderung mencari nasihat pada orang tua ketimbang pada sumber yang tidak dapat dipercaya.

4. Penguatan keterampilan hidup (life skills) untuk remaja

Keterampilan hidup adalah jembatan yang mengubah pengetahuan menjadi perilaku nyata. Remaja membutuhkan perangkat konkret untuk menavigasi situasi berisiko: kemampuan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan konsekuensi, mengelola emosi ketika berada di bawah tekanan, berkomunikasi secara asertif, menolak ajakan yang tidak aman, dan menegosiasikan batas diri. Latihan-latihan praktis seperti bermain peran menolak ajakan dengan tiga langkah (jelaskan alasan, sampaikan penolakan dengan tegas, tawarkan alternatif aman), simulasi percakapan tentang persetujuan, atau skenario negosiasi penggunaan kondom membangun memori otot sosial yang dapat diakses remaja saat situasi nyata terjadi. Penguatan keterampilan regulasi

emosi melalui teknik sederhana (napas dalam, jeda 10 detik sebelum merespons, atau menuliskan pikiran) membantu mereka meredakan impulsivitas yang sering memicu keputusan berisiko.

Dalam ekosistem digital, literasi media menjadi bagian tak terpisahkan dari life skills. Remaja perlu terampil mengenali misinformasi kesehatan reproduksi, memahami jejak digital, serta melindungi diri dari grooming, sextortion, dan penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Keterampilan meminta bantuan juga harus diajarkan: kepada siapa harus bicara, bagaimana menjelaskan masalah dengan jelas, dan bagaimana mencatat bukti jika terjadi pelanggaran. Program life skills yang kuat selalu diikat pada tujuan pribadi remaja sekolah, karier, cita-cita agar mereka melihat keterampilan ini sebagai investasi masa depan. Ketika kepercayaan diri (self-efficacy) meningkat, norma teman sebaya yang mendukung perilaku aman diperkuat, dan rute bantuan jelas, maka kemungkinan remaja mampu mempertahankan keputusan sehat akan jauh lebih besar.

E. Strategi Pencegahan Berbasis Keluarga dan Lingkungan

Pencegahan kehamilan tidak diinginkan pada remaja tidak akan efektif bila hanya diletakkan di pundak sekolah atau layanan kesehatan. Keluarga dan lingkungan sosial adalah “ekosistem terdekat” tempat nilai, sikap, dan keterampilan hidup sehari-hari dibentuk, dipraktikkan, dan diuji. Di ruang inilah remaja belajar memaknai keintiman, batas diri, rasa aman, tanggung jawab, serta cara meminta bantuan ketika berada pada situasi berisiko. Karena itu, strategi pencegahan harus menyentuh kualitas komunikasi di rumah, pola dukungan pengambilan keputusan, pengaruh teman sebaya, serta suara tokoh dan organisasi yang menjadi rujukan di komunitas.

1. Komunikasi efektif orang tua dengan remaja

Komunikasi yang efektif berawal dari penerimaan tanpa menghakimi. Remaja lebih mudah membuka diri ketika orang tua memperlihatkan kesediaan untuk mendengar cerita sampai tuntas, memvalidasi perasaan, dan merespons dengan empati ketimbang dengan ceramah atau ancaman. Keterampilan mendengar aktif seperti merangkum kembali inti cerita, menanyakan klarifikasi dengan nada ingin memahami, dan menanggapi emosi alih-alih sekadar fakta menciptakan rasa aman psikologis yang menjadi prasyarat dialog tentang topik sensitif, termasuk relasi, batasan, dan kesehatan reproduksi. Saat remaja mengajukan pertanyaan yang sulit, orang tua dapat mengakui keterbatasan pengetahuan lalu bersama-sama mencari sumber tepercaya; sikap jujur seperti ini justru memperkuat kredibilitas orang tua.

Konteks digital perlu masuk dalam percakapan keluarga. Orang tua yang peka akan bertanya tentang pengalaman anak di media sosial, jenis konten yang mereka lihat, dan bagaimana mereka menilai ajakan atau tekanan dari teman sebaya di ruang daring. Alih-alih mengawasi secara represif, keluarga dapat membangun kesepakatan bersama misalnya tentang privasi, berbagi kata sandi darurat, atau kapan harus menghubungi orang dewasa tepercaya sebagai pagar keselamatan yang disepakati, bukan dipaksakan. Di keluarga dengan jejak trauma atau konflik berkepanjangan, pendekatan yang berperspektif trauma membantu percakapan tetap aman: menghindari nada menyalahkan, memberikan jeda saat emosi memuncak, dan menawarkan dukungan profesional bila diperlukan. Ketika komunikasi keluarga rutin, hangat, dan dapat diprediksi, remaja memiliki “pelabuhan aman” untuk kembali dan tempat bertanya sebelum mengambil keputusan yang berisiko.

2. Dukungan keluarga dalam pengambilan keputusan

Dukungan yang efektif bukan hanya nasihat, melainkan pendampingan dalam proses menimbang pilihan dan konsekuensinya. Orang tua dapat memandu remaja menggunakan kerangka pengambilan keputusan sederhana mengidentifikasi masalah, menyusun alternatif, menaksir risiko dan manfaat, lalu memilih langkah yang paling selaras dengan nilai pribadi dan keselamatan. Dalam isu relasi dan seksualitas, pendampingan ini menyentuh hal-hal praktis seperti merencanakan rute pulang yang aman, menyepakati “kode darurat” saat remaja butuh dijemput, atau mengatur kunjungan ke layanan ramah remaja untuk konseling kontrasepsi tanpa stigma. Dukungan informasi, emosional, dan logistik berjalan beriringan: keluarga membantu mencari pengetahuan akurat, menyediakan ruang untuk mengekspresikan ketakutan dan kebingungan, dan memfasilitasi akses layanan atau transportasi ketika dibutuhkan.

Nilai keluarga kerap berbeda dengan nilai yang ditemui remaja di luar rumah. Di sinilah pendekatan “berbagi keputusan” menjadi penting, karena memadukan prinsip keluarga dengan kepentingan terbaik bagi keselamatan anak. Orang tua dapat menyatakan nilai yang dipegang misalnya tentang penundaan aktivitas seksual seraya tetap membuka ruang untuk membahas rencana aman jika remaja menghadapi tekanan yang tidak bisa dihindari. Pelibatan ayah, kakek-nenek, atau pengasuh lain memperkuat jejaring protektif, khususnya di keluarga orang tua tunggal atau keluarga pekerja dengan waktu terbatas. Keluarga yang mampu mempertahankan dukungan meski berbeda pendapat memberi pesan kuat bahwa keselamatan remaja adalah prioritas yang tidak dinegosiasikan.

3. Peran teman sebaya dalam peer education

Teman sebaya memiliki pengaruh yang khas karena kedekatan pengalaman. Peer education bekerja efektif ketika remaja belajar dari remaja lain yang terlatih, menggunakan bahasa yang relevan, contoh yang membumi, dan saluran komunikasi yang mereka sukai. Program yang sukses biasanya menyeleksi pendidik sebaya bukan semata karena popularitas, melainkan karena kematangan, empati, dan komitmen menjaga kerahasiaan. Mereka dibekali pelatihan tentang pengetahuan kesehatan reproduksi yang akurat, keterampilan fasilitasi diskusi, teknik menangani pertanyaan sensitif, dan prosedur rujukan ke layanan profesional bila menemui kasus di luar kewenangan.

Ruang peer education tidak berhenti di kelas tatap muka. Grup percakapan yang terkelola dengan baik, kanal media sosial yang kurasi kontennya ketat, hingga siaran langsung tematik dapat memperluas jangkauan, asalkan ada moderasi yang menjaga akurasi informasi dan etika interaksi. Pendampingan orang dewasa guru, konselor, atau tenaga kesehatan dibutuhkan sebagai “pagar” yang memastikan keselamatan, sekaligus sebagai rujukan saat muncul isu seperti kekerasan seksual, perundungan siber, atau kebutuhan kontrasepsi darurat. Ketika jaringan teman sebaya mempromosikan norma positif mengapresiasi penundaan, menghormati persetujuan, dan menormalisasi pencarian bantuan maka tekanan untuk mengambil risiko menurun, dan keputusan aman menjadi bagian dari identitas kelompok.

4. Peran tokoh masyarakat dan organisasi pemuda

Suara tokoh masyarakat pemuka agama, ketua RT/RW, kader kesehatan, dan figur publik local membentuk iklim normatif yang menentukan apakah remaja merasa didukung atau distigma. Ketika tokoh menyampaikan pesan yang konsisten tentang persetujuan, kesetaraan gender, dan penolakan kekerasan, komunitas mendapatkan kompas moral yang jelas. Khotbah, pertemuan warga, dan kegiatan keagamaan atau adat dapat menjadi kanal untuk menegaskan bahwa menjaga kesehatan dan keselamatan remaja adalah tanggung jawab kolektif. Pesan akan lebih kuat bila disampaikan dengan bahasa budaya setempat, tanpa menghilangkan pijakan ilmiah, sehingga tidak terasa sebagai wacana “dari luar” yang memaksakan nilai.

Organisasi pemuda karang taruna, OSIS, pramuka, remaja masjid, komunitas kreatif dapat menjadi laboratorium kepemimpinan dan ruang aman bagi remaja untuk berlatih keterampilan hidup. Program yang relevan biasanya menggabungkan kegiatan menarik olahraga, seni, teknologi, kewirausahaan dengan sisipan edukasi kesehatan reproduksi, literasi digital, dan kampanye anti-kekerasan. Kolaborasi dengan puskesmas menghadirkan pojok konseling keliling, sementara kemitraan dengan sekolah memudahkan rujukan timbal balik. Kebijakan tingkat desa atau kelurahan seperti regulasi ruang publik ramah remaja, dukungan logistik untuk kegiatan positif, dan mekanisme pelaporan kekerasan yang mudah diakses mengubah pesan menjadi struktur yang melindungi. Bila tokoh dan organisasi pemuda bergerak seirama, komunitas menjadi ekosistem yang menguatkan pilihan aman remaja, bukan sekadar menuntut mereka “menjauhi risiko” tanpa menyediakan alternatif yang realistis.

F. Akses terhadap Layanan Kesehatan Reproduksi Ramah Remaja

Layanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja bertumpu pada prinsip aksesibilitas, keterjangkauan, kerahasiaan, non-diskriminasi, dan efektivitas klinis. Remaja datang dengan kebutuhan yang majemuk informasi yang akurat, tempat bertanya tanpa dihakimi, dukungan psikososial, serta pilihan layanan yang nyata dan aman. Karena itu, desain layanan tidak cukup hanya menyediakan ruang pemeriksaan; yang lebih penting ialah menciptakan pengalaman yang membuat remaja merasa diterima, dipercaya, dan mampu mengambil keputusan yang selaras dengan nilai serta keselamatannya. Pendekatan ini menghubungkan konseling yang berkualitas, ketersediaan kontrasepsi dengan ragam pilihan, keberadaan klinik atau pos remaja yang mudah dijangkau, serta peran multidisiplin tenaga kesehatan yang bekerja dalam satu alur rujukan yang jelas.

1. Konseling kesehatan reproduksi

Konseling yang efektif dimulai dari penegasan kerahasiaan dan penjelasan batas-batasnya sejak awal bahwa percakapan akan dijaga privat kecuali jika ada risiko serius terhadap keselamatan diri atau orang lain. Dengan landasan ini, tenaga kesehatan membangun hubungan yang setara, memfasilitasi remaja mengekspresikan pertanyaan, kekhawatiran, dan nilai-nilai pribadinya tanpa takut disalahkan. Wawancara dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan netral, serta memanfaatkan pendekatan penilaian psikososial yang menyeluruh seperti kerangka HEADSSS (riwayat rumah dan keluarga, pendidikan dan pekerjaan, aktivitas, penggunaan zat, seksualitas, kesehatan mental, dan keamanan). Pendekatan ini membantu mengungkap konteks yang kerap tersembunyi misalnya tekanan teman sebaya, relasi yang tidak setara, perundungan siber, atau pengalaman kekerasan yang semuanya memengaruhi pilihan dan risiko reproduksi.

Isi konseling harus menyeimbangkan informasi faktual dengan keterampilan praktis. Remaja membutuhkan penjelasan yang akurat tentang pubertas, persetujuan dalam relasi, pencegahan infeksi menular seksual, dan pilihan kontrasepsi beserta efektivitas, cara pakai, efek samping, dan tanda bahaya yang harus diwaspadai. Namun pengetahuan saja tidak cukup; konselor menuntun latihan komunikasi asertif, strategi menolak ajakan yang tidak aman, dan perencanaan rute bantuan bila terjadi keadaan darurat. Konseling juga berperspektif trauma: ketika remaja mengungkapkan pengalaman kekerasan, respon harus menenangkan, tidak menyalahkan korban, dan segera mengaktifkan jalur rujukan medis, psikologis, serta perlindungan sosial sesuai protokol setempat. Keberlanjutan menjadi kunci; sesi tindak lanjut terjadwal, pesan pengingat yang menjaga privasi, dan saluran telehealth untuk pertanyaan mendesak memastikan remaja tidak terputus dari dukungan di luar kunjungan tatap muka.

2. Penyediaan layanan kontrasepsi ramah remaja

Kontrasepsi yang ramah remaja berlandaskan konseling yang tidak menggurui, menghormati pilihan remaja, dan netral terhadap metode. Tenaga kesehatan memaparkan method mix yang luas mulai dari kondom, pil, suntik, implan, hingga IUD dengan penjelasan jujur mengenai efektivitas, cara penggunaan yang benar, kemungkinan efek samping, serta bagaimana mengatasinya. Prinsip “perlindungan ganda” ditekankan: kombinasi kondom untuk mencegah infeksi menular seksual bersama metode efektif untuk mencegah kehamilan. Kontrasepsi darurat diperkenalkan sebagai opsi penanganan segera setelah hubungan berisiko, dengan penjelasan jangka waktu penggunaan yang aman dan pentingnya tindak lanjut agar tidak disalahartikan sebagai pengganti metode rutin.

Agar benar-benar ramah remaja, layanan tidak mensyaratkan status perkawinan, tidak mewajibkan pendampingan pasangan, dan meminimalkan hambatan administrative tentu dengan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku di daerah setempat. Biaya dibuat transparan dan, sejauh mungkin, terjangkau atau ditanggung skema pembiayaan kesehatan. Jam layanan fleksibel mengikuti jadwal sekolah, dan stok alat serta obat dikelola untuk mencegah kekosongan. Ruang tindakan menjaga privasi, sementara alur pelayanan memisahkan registrasi dari ruang tunggu umum bila memungkinkan, sehingga remaja tidak khawatir bertemu orang yang dikenalnya. Keberhasilan layanan diukur bukan hanya dari jumlah metode yang dipilih, melainkan juga dari tingkat keberlanjutan pemakaian, alasan penghentian, dan kepuasan remaja indikator yang memberi sinyal bagian mana yang perlu diperbaiki, apakah pada kualitas konseling, manajemen efek samping, atau akses tindak lanjut.

3. Klinik remaja dan posyandu remaja

Klinik remaja baik sebagai unit khusus di puskesmas maupun sebagai youth corner berfungsi sebagai "satu pintu" layanan kesehatan yang menyatukan isu reproduksi dengan kebutuhan perkembangan lainnya. Desain ruang membuat remaja betah: signage yang ramah, materi edukasi yang relevan, tempat tunggu yang tidak memojokkan, serta staf resepsionis yang terlatih menyambut tanpa menginterogasi. Jadwal pelayanan dirancang setelah jam sekolah atau di akhir pekan, dengan opsi kunjungan tanpa janji untuk kasus mendesak. Di dalamnya, remaja bisa mendapatkan konseling, tes dan pengobatan infeksi menular seksual, imunisasi sesuai usia, skrining anemia dan status gizi, dukungan kesehatan mental, serta rujukan sosial bila ditemukan masalah perlindungan.

Posyandu remaja memperluas jangkauan layanan hingga ke tingkat komunitas, memanfaatkan kader muda yang dilatih untuk edukasi sebaya, deteksi dini masalah kesehatan, dan penguatan norma positif. Kegiatan tidak melulu bermuatan medis; klub keterampilan hidup, kelas literasi media, hingga career talk membuat posyandu menjadi ruang berkegiatan yang bernilai bagi remaja laki-laki maupun perempuan. Keterhubungan dengan sekolah dan organisasi pemuda memudahkan mobilisasi peserta, sementara kemitraan dengan puskesmas menjamin ketersediaan petugas dan logistik. Sistem rujukan dibuat lugas: hasil skrining yang mengkhawatirkan langsung diarahkan ke tenaga profesional, dengan pendampingan kader agar remaja tidak "hilang di jalan".

4. Peran bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lain

Bidan dan perawat menjadi ujung tombak karena kedekatannya dengan keluarga dan komunitas. Mereka memadukan kompetensi klinis misalnya pemasangan dan pencabutan metode kontrasepsi jangka panjang,

penatalaksanaan efek samping ringan, skrining infeksi menular seksual dengan keahlian komunikasi yang hangat dan menghargai pilihan remaja. Dalam setiap pertemuan, mereka mengintegrasikan edukasi singkat yang relevan, mengulas kembali pemahaman remaja, dan memastikan adanya rencana tindak lanjut yang realistis. Ketika menemukan tanda kekerasan, bidan dan perawat mengaktifkan protokol perlindungan: mencatat secara aman, memberikan pertolongan pertama psikologis, serta merujuk ke layanan medis lanjutan, psikolog, dan pendampingan hukum sesuai jalur resmi.

Dokter memberikan dukungan klinis untuk kasus kompleks, melakukan penilaian dan tata laksana lanjut, serta memastikan standar mutu medis dipenuhi. Apoteker berkontribusi pada edukasi penggunaan obat yang benar, interaksi, dan manajemen efek samping, sekaligus menjaga ketersediaan logistik kontrasepsi. Psikolog dan konselor kesehatan mental menangani kecemasan, depresi, trauma, atau konflik relasi yang mempengaruhi keputusan reproduksi. Pekerja sosial menghubungkan remaja dan keluarganya dengan dukungan sosial dan ekonomi yang dibutuhkan agar rencana kesehatan yang disepakati dapat dijalankan. Di tingkat komunitas, kader kesehatan dan pendidik sebaya memperkuat jembatan antara layanan formal dan kehidupan sehari-hari remaja, memastikan pesan sampai dan dukungan berlanjut setelah kunjungan klinik.

G. Kebijakan dan Regulasi dalam Pencegahan Kehamilan Remaja

Kerangka kebijakan dan regulasi adalah “rel kereta” yang memastikan seluruh upaya pencegahan kehamilan remaja berjalan terarah, berkesinambungan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa rel yang jelas, program pendidikan, konseling, dan layanan klinis mudah tersendat oleh stigma, tafsir yang berbeda-beda, bahkan hambatan administratif di lapangan. Indonesia telah membangun landasan normatif yang semakin menegaskan hak kesehatan reproduksi, menaikkan usia minimum perkawinan, memperkuat perlindungan dari kekerasan seksual, dan mendorong integrasi layanan ramah remaja di puskesmas, sekolah, serta komunitas. Bagian ini menguraikan bagaimana regulasi nasional bekerja, bagaimana ia melindungi remaja, dan bagaimana implementasinya dioperasionalkan melalui program pemerintah dan sinergi lintas sektor.

1. Kebijakan nasional terkait kesehatan reproduksi remaja

Dalam tingkat nasional, hak kesehatan reproduksi ditegaskan melalui Undang-Undang Kesehatan yang mutakhir serta peraturan turunan yang lebih teknis mengenai layanan reproduksi. Undang-Undang Kesehatan mengafirmasi hak setiap orang termasuk remaja atas informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang bermutu, aman, dan berkeadilan, sembari menugaskan

pemerintah pusat dan daerah menyelenggarakan upaya kesehatan yang berorientasi pada siklus kehidupan dan kebutuhan kelompok khusus. Prinsip ini menjadi pijakan bagi penyediaan layanan yang menjaga kerahasiaan, non-diskriminasi, dan akses yang terjangkau bagi remaja. Di tingkat teknis, Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi mengatur ruang lingkup pelayanan, termasuk pelayanan kesehatan reproduksi remaja sebagai satu kesatuan kegiatan untuk menjaga kesehatan dan mencegah risiko dari edukasi, konseling, hingga layanan klinis yang sesuai standar. Dengan kombinasi payung hak dan pedoman operasional, fasilitas layanan primer seperti puskesmas punya dasar kuat untuk membuka klinik atau pojok remaja, menata alur rujukan, dan melatih tenaga kesehatan agar sensitif terhadap kebutuhan remaja.

2. Peraturan tentang usia pernikahan dan perlindungan anak

Pencegahan kehamilan remaja sangat bergantung pada perlindungan hukum terhadap perkawinan usia anak dan kekerasan berbasis gender. Revisi Undang-Undang Perkawinan menaikkan batas usia minimum perkawinan bagi perempuan sehingga setara dengan laki-laki, yaitu 19 tahun, sekaligus memberi sinyal kuat bahwa negara mendorong pendewasaan usia kawin sebagai strategi kesehatan dan pembangunan manusia. Kebijakan ini berjalan beriringan dengan penguatan perlindungan korban melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menyediakan definisi, jenis tindak pidana, serta mekanisme pemulihan dan akses layanan bagi penyintas, termasuk remaja. Di lingkungan pendidikan, regulasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan mempertegas kewajiban sekolah membangun ekosistem aman dengan prosedur pelaporan, perlindungan saksi/korban, dan rujukan sehingga remaja terlindungi dari kekerasan yang sering menjadi pintu masuk kehamilan tidak diinginkan. Dengan kombinasi norma usia minimum perkawinan, perlindungan pidana terhadap kekerasan seksual, dan standar sekolah aman, ruang tumbuh remaja menjadi lebih terlindungi dari pemaksaan relasi dan praktik yang berisiko.

3. Implementasi program pemerintah (BKKBN, Puskesmas, sekolah)

Pada tataran implementasi, pencegahan kehamilan remaja ditopang oleh tiga pilar program: kependudukan dan keluarga berencana, layanan kesehatan primer, serta lingkungan sekolah. Di ranah kependudukan, BKKBN menjalankan program Bangga Kencana sebagai payung besar dan menggerakkan Program Generasi Berencana (GenRe), termasuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M). Melalui jejaring PIK-R dan Forum GenRe, remaja mendapat akses informasi kredibel, konseling sebaya, keterampilan hidup, serta kampanye penundaan usia perkawinan dan perencanaan kehidupan berkeluarga.

Infrastruktur data dan kelembagaan BKKBN memperkuat pembinaan sampai ke daerah, sehingga pesan dan layanan menjangkau komunitas luas.

Di layanan primer, Kementerian Kesehatan menstandarisasi Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) sehingga puskesmas mampu menyediakan konseling, skrining risiko, layanan kontrasepsi yang ramah remaja, serta rujukan kesehatan mental dengan menjaga privasi. Pedoman PKPR dan pengembangan skenario layanan di luar gedung melalui kunjungan ke sekolah, pos remaja, atau kegiatan komunitas memperluas jangkauan bagi remaja yang enggan datang ke fasilitas kesehatan. Posyandu remaja melengkapi ekosistem ini di tingkat komunitas: kader muda dan petugas kesehatan menyelenggarakan edukasi, deteksi dini anemia dan masalah gizi, pencegahan NAPZA, serta promosi aktivitas fisik dalam format yang menarik bagi remaja.

Di lingkungan sekolah, program UKS/M (Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah) dikuatkan melalui peraturan bersama lintas kementerian sebagai platform pembinaan lingkungan belajar yang sehat. UKS/M memadukan pendidikan kesehatan, pelayanan dasar, dan penciptaan lingkungan sekolah yang kondusif menjadi kanal penting untuk menyampaikan literasi kesehatan reproduksi, membangun norma persetujuan, serta menghubungkan siswa ke PKPR puskesmas ketika dibutuhkan. Dengan mandat regulatif yang jelas, sekolah tidak berjalan sendiri, melainkan dalam kemitraan formal dengan dinas kesehatan, puskesmas, dan orang tua.

4. Sinergi lintas sektor: kesehatan, pendidikan, sosial, agama

Efektivitas pencegahan ditentukan oleh kemampuan lintas sektor untuk bekerja sebagai satu orkestrasi. Sektor kesehatan menyediakan standar klinis, sarana, dan pelatihan; sektor pendidikan memastikan materi dan pengalaman belajar yang komprehensif sekaligus aman dari kekerasan; sektor sosial menghubungkan keluarga rentan dengan bantuan dan perlindungan; sementara otoritas keagamaan dan tokoh masyarakat membantu menerjemahkan pesan kesehatan publik ke dalam bahasa nilai yang dihormati komunitas. Contoh sinergi yang sudah dilembagakan terlihat pada kerangka UKS/M lintas kementerian yang menyatukan kebijakan, peran, serta alur koordinasi dari pusat hingga sekolah, serta pada aturan pendidikan tentang pencegahan kekerasan di satuan pendidikan yang menautkan protokol sekolah dengan layanan kesehatan dan aparat perlindungan ketika terjadi kasus. Dengan pilar-pilar tersebut, remaja mendapatkan pengalaman yang konsisten: pesan yang sama di rumah dan sekolah, akses layanan yang jelas di puskesmas, dan dukungan sosial-kultural yang memungkinkan mereka menunda usia kawin, menolak paksaan, serta mencari bantuan tanpa takut distigma.

H. Pemanfaatan Teknologi dan Media dalam Pencegahan

Teknologi digital membuka jalur baru untuk mencegah kehamilan tidak diinginkan pada remaja dengan cara yang lebih dekat, cepat, dan relevan dengan keseharian mereka. Di ruang ini, informasi tidak lagi hanya datang dari buku teks atau ruang kelas, tetapi hadir di genggaman melalui gawai, media sosial, aplikasi, dan layanan daring. Tantangannya adalah memastikan semua kanal tersebut menyajikan pengetahuan yang akurat, aman, dan menghormati martabat remaja, sekaligus menghubungkan mereka ke layanan kesehatan yang nyata. Bagian ini mengulas bagaimana media sosial, aplikasi mobile, dan kampanye digital dapat dimanfaatkan secara strategis, serta etika dan risiko yang harus diantisipasi agar pemanfaatannya benar-benar melindungi, bukan menjerumuskan.

1. Edukasi kesehatan reproduksi melalui media sosial

Media sosial adalah etalase terbesar tempat remaja mencari jawaban dan membangun identitas. Edukasi kesehatan reproduksi yang efektif di platform ini berangkat dari pemahaman bahwa atensi remaja singkat, konten harus ringkas, visual kuat, dan bahasanya relevan. Materi yang sulit seperti persetujuan dalam relasi, kesetaraan gender, serta efektivitas kontrasepsi dapat diurai melalui video pendek, ilustrasi, cerita berformat komik, atau cuplikan tanya jawab yang memecah konsep menjadi potongan mudah dicerna. Kredibilitas menjadi kunci; akun yang dikelola tenaga kesehatan, organisasi profesional, atau kolaborasi

dengan pendidik sebaya memberi jaminan bahwa informasi tidak bermuatan mitos. Agar tidak berhenti pada pengetahuan, setiap konten sebaiknya diakhiri dengan ajakan bertindak yang jelas, misalnya tautan menuju klinik remaja terdekat, jadwal konsultasi daring, atau panduan langkah mengakses layanan rahasia.

Interaksi dua arah membuat pembelajaran lebih hidup. Sesi siaran langsung bersama bidan, perawat, atau konselor memberi ruang aman untuk bertanya, sementara fitur pesan pribadi memungkinkan remaja berkonsultasi tanpa takut disorot. Pengelola kanal perlu menyiapkan pedoman moderasi yang melindungi penanya dari perundungan dan komentar yang mempermalukan, serta menapis misinformasi yang beredar di kolom komentar. Di samping itu, literasi media harus disisipkan secara konsisten: remaja diajak memeriksa sumber informasi, membedakan pengalaman pribadi dari bukti ilmiah, dan memahami bahwa algoritma cenderung mengulang konten serupa sehingga pandangan bisa bias. Dengan cara ini, media sosial bukan hanya “panggung informasi,” melainkan laboratorium kecil untuk membentuk kebiasaan berpikir kritis yang akan mereka bawa ke luar layar.

2. Aplikasi mobile kesehatan reproduksi

Aplikasi mobile menawarkan pengalaman belajar dan dukungan yang lebih personal karena dapat menyimpan preferensi, mencatat progres, dan mengirim pengingat pada waktu yang tepat. Dalam konteks pencegahan kehamilan remaja, aplikasi yang baik menggabungkan materi edukasi berbasis bukti dengan alat praktis, seperti kalkulator efektivitas metode kontrasepsi, panduan langkah menggunakan kondom, pencatat gejala yang mengingatkan kapan harus mencari bantuan, serta direktori layanan ramah remaja berikut jam operasional dan opsi konsultasi jarak jauh. Fitur percakapan aman dengan konselor bersertifikat memberi jembatan antara pengetahuan dan keputusan nyata, sementara notifikasi yang dirancang hati-hati (tanpa menyebut topik sensitif di layar kunci) menjaga kerahasiaan pengguna.

Desain aplikasi harus inklusif. Antarmuka yang sederhana, bahasa yang jelas, dan opsi mode hemat data penting untuk remaja di wilayah dengan koneksi terbatas. Konten disajikan bertahap, menghindari jargon, dan memberi opsi audio atau ilustrasi bagi pengguna dengan literasi baca yang beragam. Di sisi perlindungan, kebijakan privasi yang mudah dipahami, pengelolaan persetujuan penggunaan data, serta penyimpanan lokal yang terenkripsi menjadi keharusan. Aplikasi tidak boleh mendorong praktik berisiko atau menjanjikan hasil medis instan; perannya adalah memberi informasi, membantu perencanaan, dan mengantarkan remaja ke layanan profesional ketika dibutuhkan. Dengan kombinasi

desain yang empatik dan perlindungan data yang kuat, aplikasi menjadi kawan yang setia dan aman dalam perjalanan remaja mengambil keputusan yang sehat.

3. Kampanye digital untuk remaja

Kampanye digital yang efektif tidak hanya menumpuk konten, melainkan menenun narasi yang menyentuh tujuan hidup remaja: menjaga kesehatan agar dapat menyelesaikan sekolah, mengejar cita-cita, dan membangun relasi yang saling menghormati. Narasi semacam ini menggeser pesan dari sekadar larangan menjadi tawaran nilai yang bermakna. Strateginya memadukan beberapa elemen. Pertama, segmentasi audiens: pesan untuk remaja awal tentu berbeda dengan remaja akhir, begitu pula antara mereka yang tinggal di kota dan di desa. Kedua, format multi-kanal: video pendek untuk menarik perhatian, artikel blog atau carousel untuk pendalaman, dan forum tanya jawab untuk klarifikasi. Ketiga, kolaborasi dengan figur tepercaya pendidik sebaya, atlet sekolah, musisi lokal, atau konten kreator yang dikenal santun agar pesan terasa dekat tanpa terjebak kultus selebritas.

Pengukuran dampak menjadi bagian integral dari kampanye. Indikator tidak berhenti pada jumlah tayangan atau suka, tetapi bergerak ke metrik yang lebih “bermakna,” seperti peningkatan kunjungan ke klinik remaja, jumlah konsultasi yang terjadi setelah kampanye, atau kenaikan permintaan informasi kontrasepsi. Uji A/B membantu memurnikan pesan: apakah pendekatan humor lebih efektif daripada pendekatan informatif, atau apakah video berdurasi satu menit menghasilkan lebih banyak konsultasi dibandingkan video tiga puluh detik. Pada saat yang sama, kampanye harus peka budaya dan agama, menghindari bahasa yang menyudutkan remaja, serta mengangkat teladan yang realistis agar tidak terasa menggurui. Bila semua elemen ini terhubung, kampanye digital bukan sekadar tempelan promosi, melainkan mesin perubahan perilaku yang terukur dan berkelanjutan.

4. Tantangan dan etika penggunaan teknologi

Pemanfaatan teknologi juga menyimpan risiko yang tidak bisa diabaikan. Isu privasi dan keamanan data berada di garis depan. Remaja adalah kelompok yang sangat sensitif terhadap kebocoran informasi; notifikasi yang mencolok, log aktivitas yang mudah diakses orang lain, atau pengumpulan data yang berlebihan dapat merusak kepercayaan dan bahkan membahayakan keselamatan. Karena itu, setiap program digital harus menjelaskan dengan gamblang data apa yang dikumpulkan, untuk tujuan apa, berapa lama disimpan, dan kepada siapa dapat dibagikan. Persetujuan harus bermakna, bukan sekadar kotak centang yang panjang dan sulit dipahami. Di sisi teknis, enkripsi, autentikasi berlapis, serta minimisasi data menjadi standar, bukan fasilitas tambahan.

Misinformasi merupakan tantangan lain. Platform yang sama yang memudahkan akses informasi juga mempercepat penyebaran klaim keliru tentang kontrasepsi, persetujuan, atau mitos kehamilan. Tim pengelola perlu menyiapkan sistem peninjauan konten, kemitraan dengan pakar, serta respons cepat untuk meluruskan informasi tanpa memperlakukan penanya. Dalam ranah etika, usia pengguna dan konteks sosial tidak boleh diabaikan. Desain yang sengaja memicu kecanduan, gamifikasi yang mendorong kompetisi tidak sehat, atau penyajian gambar yang sensasional demi “klik” bertentangan dengan tujuan kesehatan publik. Moderasi harus melindungi korban kekerasan, mencegah pelecehan, dan memberi jalur pelaporan yang mudah diakses. Terakhir, inklusivitas wajib diperhatikan: teknologi harus dapat diakses remaja dengan disabilitas, tersedia dalam bahasa yang mereka pahami, dan sensitif terhadap pengalaman beragam, baik remaja perempuan maupun laki-laki.

I. Peran Masyarakat dan Lembaga Swadaya

Peran masyarakat dan lembaga swadaya dalam penguatan derajat kesehatan dan kesejahteraan remaja berangkat dari sebuah gagasan sederhana: remaja tumbuh di dalam ekosistem sosial tertentu, sehingga intervensi yang paling efektif adalah intervensi yang memanfaatkan kekuatan ekosistem itu sendiri. Keluarga, tokoh masyarakat, sekolah, puskesmas, karang taruna, komunitas keagamaan, hingga pelaku usaha lokal memiliki modal sosial, jejaring kepercayaan, dan pengetahuan kontekstual yang tidak dimiliki oleh lembaga eksternal. Ketika modal ini dipadukan dengan keahlian teknis, pendanaan, serta metodologi yang dibawa oleh lembaga swadaya, universitas, dan mitra riset, terbentuklah kolaborasi yang mampu menghasilkan program yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan menumbuhkan kemandirian remaja.

Program pemberdayaan remaja di masyarakat pada dasarnya bertujuan menumbuhkan agensi rasa mampu dan hak untuk membuat keputusan yang memengaruhi hidupnya serta membangun kapasitas untuk mempraktikkan perilaku sehat dan produktif. Program yang baik selalu dimulai dari pemetaan aset, bukan hanya daftar masalah. Fasilitator bersama remaja dan para pemangku kepentingan mengidentifikasi sumber daya lokal: ruang aman untuk berkegiatan, relawan yang bersedia menjadi pendamping sebaya, dukungan orang tua, keberadaan posyandu remaja, layanan puskesmas, serta kanal komunikasi seperti grup pesan singkat atau radio komunitas. Tahap ini dilanjutkan dengan dialog partisipatif diskusi terarah dan lokakarya kreatif agar remaja sendiri mendefinisikan prioritas: misalnya literasi kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan berbasis gender, kesehatan mental, keterampilan hidup (life skills), kewirausahaan sosial, atau literasi digital. Dari

prioritas tersebut, kurikulum kegiatan disusun secara bertahap: pelatihan pendidik sebaya; kelas keterampilan yang praktikal (komunikasi asertif, negosiasi, pengambilan keputusan, manajemen emosi); kampanye yang dirancang dan dieksekusi oleh remaja; serta praktik nyata seperti klub minat bakat, klinik konseling sebaya yang terhubung dengan tenaga profesional, dan proyek mikro berbasis kebutuhan lokal. Keberhasilan program tampak pada indikator yang tidak sekadar kuantitatif (jumlah peserta, cakupan kegiatan), tetapi juga kualitatif seperti meningkatnya rasa percaya diri, kemampuan menyuarakan pendapat di forum desa, berkurangnya stigma terhadap isu sensitif, serta terbentuknya jejaring dukungan di antara remaja, orang tua, dan layanan formal. Agar tidak berumur pendek, program memasukkan strategi keberlanjutan sejak awal: regenerasi pendidik sebaya, mekanisme iuran sukarela atau dukungan anggaran desa, kemitraan dengan pelaku usaha lokal, dan integrasi agenda remaja dalam rencana pembangunan wilayah.

Dukungan organisasi non-pemerintah (LSM/NGO) berfungsi sebagai pengungkit yang memperkuat infrastruktur sosial yang sudah ada. LSM membawa beberapa kontribusi kunci. Pertama, penguatan kapasitas: pelatihan fasilitator, modul berbasis bukti, mekanisme manajemen kasus untuk isu kompleks, hingga kebijakan perlindungan anak dan remaja agar lingkungan program aman secara fisik dan psikososial. Kedua, dukungan sumber daya: akses pendanaan, material edukasi yang terstandarisasi, serta peralatan untuk kampanye dan kegiatan kreatif. Ketiga, advokasi dan jejaring: kemampuan membangun aliansi dengan pemerintah daerah, institusi layanan, dan sektor swasta, sehingga isu remaja tidak berjalan sendiri, tetapi masuk dalam arus kebijakan dan anggaran. Keempat, tata kelola dan akuntabilitas: sistem pemantauan dan evaluasi, pelaporan yang transparan, serta mekanisme umpan balik dari peserta program agar suara remaja benar-benar memengaruhi perbaikan program. LSM yang efektif tidak “menggantikan” peran masyarakat, tetapi memperkuatnya; tidak memaksakan program baku, melainkan ikut merancang bersama remaja dan para pemangku kepentingan setempat; tidak hanya mengejar output jangka pendek, tapi membangun struktur lokal yang mampu bertahan setelah proyek formal selesai.

Kolaborasi dengan universitas dan lembaga riset menambahkan lapisan mutu yang penting: ketepatan desain intervensi, ketelitian pemantauan, serta kekuatan bukti untuk memengaruhi kebijakan. Universitas dapat terlibat sejak tahap asesmen kebutuhan melalui survei dasar, wawancara mendalam, atau pemetaan partisipatif, sehingga program tidak bertumpu pada asumsi. Keterlibatan sivitas akademika melalui KKN, magang berbasis proyek, atau mata kuliah berbasis layanan memungkinkan transfer pengetahuan dua arah: mahasiswa belajar konteks nyata dan masyarakat memperoleh tenaga segar yang terarah. Peneliti berkontribusi pada

pengembangan instrumen yang peka budaya dan usia, rancangan evaluasi yang mampu menangkap dampak perilaku maupun perubahan norma sosial, serta analisis yang memperhatikan keadilan dan inklusi misalnya, apakah program menjangkau remaja putus sekolah, penyandang disabilitas, atau remaja yang tinggal di daerah terpencil. Selain menghasilkan artikel ilmiah, universitas diharapkan memproduksi bahan ajar populer, panduan praktis untuk kader dan guru, serta ringkasan kebijakan yang mudah dipahami oleh pemerintah daerah. Lebih jauh, kemitraan ini dapat membuka akses ke inovasi: aplikasi konseling anonim yang terhubung ke layanan profesional, materi interaktif berbasis permainan untuk literasi kesehatan, atau model kewirausahaan sosial yang diuji kelayakannya sebelum direplikasi di wilayah lain. Dalam semua itu, etika penelitian persetujuan berinformasi, kerahasiaan data, dan prinsip “do no harm” menjadi pagar yang tidak boleh ditawar.

Pendekatan berbasis komunitas menjadi bingkai yang menyatukan semua unsur di atas. Prinsip utamanya adalah partisipasi bermakna dan kepemilikan lokal: remaja bukan objek, melainkan subjek yang merancang, menjalankan, dan mengevaluasi programnya sendiri. Pendekatan ini memanfaatkan kekuatan yang sudah ada (asset-based), bukan sekadar mengatasi kekurangan (needs-based), sehingga warga merasa dihargai dan termotivasi. Dalam praktik, prosesnya dimulai dengan “masuk” yang sensitif konteks: membangun hubungan dengan tokoh formal dan informal, mendengar harapan orang tua, mengidentifikasi ruang aman yang disetujui bersama, dan memetakan waktu kegiatan yang tidak bertabrakan dengan kewajiban sekolah atau pekerjaan. Selanjutnya, komunitas dilibatkan dalam perencanaan bersama yang konkret—menentukan tujuan yang dapat diukur dan dirasakan, membagi peran secara jelas, menetapkan mekanisme perlindungan dan rujukan untuk kasus-kasus berisiko, serta menyepakati cara memantau kemajuan. Implementasi berjalan secara berlapis: di tingkat mikro, ada kelompok pertemuan rutin, klinik konseling sebaya, dan aktivitas kreatif; di tingkat meso, dibentuk forum lintas-sektor yang mempertemukan remaja, guru, bidan/perawat puskesmas, perangkat desa, dan pelaku usaha; di tingkat makro, hasil pembelajaran diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kota sehingga memperoleh dasar pendanaan yang lebih stabil. Dalam konteks keberagaman budaya dan keyakinan, pendekatan ini mengedepankan dialog: materi sensitif dikemas dengan bahasa yang menghormati nilai lokal, tokoh keagamaan dan adat dilibatkan sebagai mitra edukasi, dan perbedaan pandangan diolah menjadi kesempatan belajar, bukan sumber konflik. Dimensi inklusi menjadi perhatian khusus: ruang dan jadwal yang ramah disabilitas, saluran aduan yang

aman bagi korban kekerasan, serta strategi jemput bola untuk menjangkau remaja yang paling terpinggirkan.

Keempat unsur pemberdayaan remaja, dukungan LSM, kolaborasi akademik, dan pendekatan berbasis komunitas akan saling menguatkan ketika diikat oleh tata kelola yang jelas. Sebuah “model logika” program membantu semua pihak memahami hubungan antara input, kegiatan, hasil, dan dampak; indikator disepakati sejak awal untuk menghindari bias “sekadar ramai kegiatan”; dan sistem data sederhana tapi disiplin memastikan keputusan berbasis fakta. Di saat yang sama, fleksibilitas tetap dijaga: program harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lokal, misalnya perubahan kalender sekolah, musim panen, atau munculnya isu baru di media sosial. Komunikasi publik yang baik melalui pameran karya remaja, panggung dialog warga, atau publikasi singkat menjadi sarana akuntabilitas sekaligus perayaan pencapaian. Terakhir, keberlanjutan finansial dan kelembagaan tidak boleh bergantung pada satu sumber; kombinasi dukungan pemerintah daerah, skema dana desa, kontribusi mitra swasta melalui tanggung jawab sosial perusahaan, dan inisiatif kewirausahaan sosial yang dikelola remaja akan membangun ketahanan program.

J. Simpulan

Kehamilan tidak diinginkan pada remaja adalah persoalan ekologi risiko—hasil pertautan kekurangan literasi kesehatan reproduksi, norma sosial-budaya yang tidak setara, ketimpangan gender serta kekerasan, dinamika psikologis remaja, dan akses layanan yang belum ramah remaja. Dampaknya berlapis: meningkatkan risiko kesehatan ibu dan bayi, mengganggu tugas perkembangan psikologis, memutus jalur pendidikan dan kesempatan kerja, serta menimbulkan konsekuensi antargenerasi pada kualitas tumbuh kembang anak dan kesejahteraan keluarga.

Karena itu, pencegahan tidak bisa bersandar pada satu aktor atau pesan larangan semata. Ia menuntut pendekatan holistik yang berpusat pada hak, kesetaraan gender, dan keselamatan: komunikasi hangat orang tua–remaja; pendidikan kesehatan reproduksi komprehensif di sekolah yang menguatkan keterampilan hidup, literasi digital, dan kemampuan menolak secara asertif; layanan kesehatan ramah remaja yang menjaga kerahasiaan serta menyediakan pilihan kontrasepsi yang adil dan informatif; penguatan jejaring teman sebaya; dan ekosistem komunitas yang menyediakan ruang aman dan norma positif. Teknologi dan media menjadi pengungkit untuk edukasi dan rujukan, namun wajib dikelola dengan etika, privasi, dan kurasi informasi yang ketat.

Keberhasilan bertumpu pada tata kelola yang jelas dan kolaborasi lintas sector kesehatan, pendidikan, sosial, dan keagamaan yang ditopang kerangka regulasi

(pendewasaan usia perkawinan, perlindungan dari kekerasan seksual, sekolah aman dan mekanisme kembali bersekolah). Peran lembaga swadaya, universitas, dan pemerintah daerah saling melengkapi: memperkuat kapasitas, memastikan program berbasis bukti, memantau perubahan perilaku dan norma, serta merancang keberlanjutan melalui pendanaan campuran dan kepemilikan lokal. Dengan orkestrasi ini, remaja tidak sekadar “dilindungi”, melainkan berdaya sebagai subjek yang mampu mengambil keputusan sehat membuka jalan pemutusan siklus kemiskinan, memperbaiki derajat kesehatan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

K. Daftar Pustaka

- Ayuandini, S., Habito, M., Ellis, S., Kennedy, E., Akiyama, M., Binder, G., ... Hennegan, J. (2023). Contemporary pathways to adolescent pregnancy in Indonesia: A qualitative investigation with adolescent girls in West Java and Central Sulawesi. *PLOS Global Public Health*, 3(10), e0001700. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0001700>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Pedoman Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR). <https://www.rsudkotamakassar.or.id/books/buku-pedoman-standar-nasional-pelayanan-kesehatan-peduli-remaja-pkpr/>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Agama RI, & Kementerian Dalam Negeri RI. (2014). Peraturan Bersama Nomor 6/X/PB/2014; Nomor 73 Tahun 2014; Nomor 41 Tahun 2014; Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS/M. <https://jdih.bandung.go.id/index.php/media/2643>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2021). Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/188450/permendikbud-no-30-tahun-2021>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/346470/Permendikbudristek%2046%20Tahun%202023.pdf>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2024). Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

<https://lldikti3.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2024/10/Salinan-Permendikbudristek-Nomor-55-Tahun-2024-PPKPT.pdf>

Nelson, H. D., Darney, B. G., Ahrens, K., et al. (2022). Associations of unintended pregnancy with maternal and infant health outcomes: A systematic review and meta-analysis. *JAMA*, 328(17), 1714–1729. <https://doi.org/10.1001/jama.2022.19097>

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/FullText/2014/61TAHUN2014PPPenjel.pdf>

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/113523/UU%20Nomor%2016%20Tahun%202019.pdf>

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>

Waller, D., Bailey, J., Zolfaghari, E., Ho, N., Feuerlicht, L., Ross, N., & Steinbeck, K. (2023). Psychosocial assessment of adolescents and young adults in paediatric hospital settings: Patient and staff perspectives on implementation of the e-HEEADSSS. *BMC Health Services Research*, 23, 683. (Detail artikel dirangkum dari ringkasan publik)

World Health Organization. (2018). WHO recommendations on adolescent sexual and reproductive health and rights. <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/275374/9789241514606-eng.pdf>

World Health Organization. (2022). Family planning: A global handbook for providers (4th ed.). WHO & Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health/CCP. <https://www.who.int/publications/m/item/family-planning--a-global-handbook-for-providers--4th-ed>

L. Glosarium

Akses layanan ramah remaja — Kemudahan remaja mendapatkan informasi, konseling, dan layanan kesehatan reproduksi yang terjangkau, menjaga kerahasiaan, dan bebas diskriminasi.

Algoritma media sosial — Mekanisme platform yang menayangkan konten serupa berulang, dapat membiasakan persepsi risiko bila tanpa literasi media.

Dampak antargenerasi — Rangkaian efek jangka panjang yang menurun ke anak (gizi, tumbuh kembang, pendidikan) bila kehamilan remaja tidak ditangani komprehensif.

Debut seksual — Pengalaman seksual pertama; bila terjadi tanpa kesiapan pengetahuan/keterampilan, berisiko rendahnya perlindungan.

Edukasi sebaya (peer education) — Pembelajaran oleh remaja terlatih untuk remaja lain dengan bahasa dan kanal yang relevan, disertai jalur rujukan.

Ekologi risiko — Jalinan faktor individu, keluarga, teman sebaya, budaya, ekonomi, media, dan kebijakan yang bersama-sama memengaruhi perilaku dan risiko kehamilan.

Evaluasi program (monitoring & evaluasi) — Pemantauan capaian dan mutu pelaksanaan (indikator perilaku, norma, kepuasan, keberlanjutan) untuk perbaikan berkelanjutan.

HEADSSS — Kerangka asesmen psikososial remaja: rumah/keluarga, pendidikan/pekerjaan, aktivitas, penggunaan zat, seksualitas, kesehatan mental, dan keamanan.

Jejak digital — Rekam jejak aktivitas daring yang dapat berdampak pada privasi, keamanan, dan reputasi remaja.

Kampanye digital — Rangkaian konten multi-kanal bertujuan perubahan perilaku (diukur dengan indikator bermakna seperti kunjungan layanan/ konsultasi).

Kekerasan berbasis gender — Kekerasan yang berakar pada ketimpangan gender (offline/online), termasuk penyebaran konten intim tanpa persetujuan.

Kekerasan seksual — Paksaan/ pemaksaan aktivitas seksual (fisik/digital), membutuhkan penanganan medis, psikologis, hukum, dan perlindungan.

Keluarga berdaya — Pola pendampingan orang tua yang hangat, konsisten, dan non-menghakimi untuk membantu pengambilan keputusan aman.

Kembali bersekolah (re-entry) — Mekanisme sekolah yang memungkinkan remaja hamil atau pascapersalinan melanjutkan pendidikan tanpa stigma.

Kerahasiaan (privasi layanan) — Hak remaja atas perlindungan informasi pribadi selama konseling/ pelayanan kesehatan.

Keterampilan hidup (life skills) — Keterampilan praktis (pengambilan keputusan, regulasi emosi, komunikasi asertif, negosiasi batas, meminta bantuan) untuk menerjemahkan pengetahuan menjadi perilaku aman.

Ketidaksetaraan gender — Ketimpangan peran dan kuasa yang menghambat negosiasi perlindungan dan meningkatkan risiko kehamilan tidak diinginkan.

Klinik remaja/ youth corner — Layanan satu pintu di puskesmas/ fasilitas setempat yang mengintegrasikan kesehatan reproduksi, gizi, mental, dan rujukan sosial.

Kontrasepsi darurat — Metode untuk mencegah kehamilan setelah hubungan berisiko; memerlukan penjelasan jangka waktu dan tindak lanjut.

Kurikulum kesehatan reproduksi komprehensif — Materi berjenjang yang memadukan biologi, persetujuan, kesetaraan gender, pencegahan kekerasan, kontrasepsi, dan keterampilan hidup.

Literasi kesehatan reproduksi — Pemahaman akurat tentang proses reproduksi, masa subur, risiko kehamilan, infeksi menular seksual, dan pilihan kontrasepsi.

Literasi media — Kemampuan menilai kredibilitas informasi, memahami bias algoritma, dan mengelola privasi/ keamanan digital.

Model logika program — Peta hubungan input–kegiatan–hasil–dampak yang memandu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.

Norma teman sebaya — Standar perilaku dalam kelompok remaja yang dapat menekan atau justru memperkuat keputusan aman.

Pendekatan berbasis aset (asset-based) — Perencanaan program dengan bertolak dari kekuatan/ modal sosial lokal (kader, ruang aman, dukungan orang tua), bukan semata daftar masalah.

Pendekatan berperspektif trauma — Cara layanan/ pendidikan yang meminimalkan pemicu trauma, tidak menyalahkan korban, dan mengutamakan keselamatan.

Pendewasaan usia perkawinan — Kebijakan menaikkan usia minimal perkawinan untuk melindungi pendidikan, kesehatan, dan hak remaja.

Penguatan kapasitas — Upaya pelatihan/ pendampingan bagi pendidik sebaya, kader, guru, dan tenaga kesehatan agar program aman, terbukti, dan akuntabel.

Perlindungan ganda — Penggunaan kondom untuk pencegahan infeksi menular seksual plus metode kontrasepsi efektif untuk mencegah kehamilan.

Persetujuan dalam relasi (consent) — Persetujuan sadar, sukarela, dan setara sebelum aktivitas intim; dapat ditarik kapan saja.

PIK-R/ Program GenRe — Pusat Informasi dan Konseling Remaja dalam kerangka Generasi Berencana: akses informasi, konseling, dan kegiatan pengembangan remaja.

PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) — Standar layanan primer yang ramah remaja mencakup konseling, skrining risiko, kontrasepsi, rujukan kesehatan mental, dan perlindungan.

Posyandu remaja — Kegiatan komunitas yang menggabungkan edukasi, deteksi dini (mis. anemia/gizi), promosi aktivitas fisik, serta rujukan ke tenaga profesional.

Ruang aman (safe space) — Lingkungan luring/daring yang melindungi remaja dari stigma dan kekerasan untuk belajar, berdiskusi, dan mencari bantuan.

Rujukan terintegrasi — Alur jelas dan cepat antara sekolah, puskesmas, layanan sosial/hukum saat ditemukan risiko atau kasus kekerasan.

Sekolah ramah remaja/ UKS/M — Ekosistem sekolah yang sehat dan aman yang memadukan pendidikan kesehatan, layanan dasar, serta keterhubungan dengan layanan kesehatan.

Self-efficacy — Keyakinan remaja bahwa ia mampu menjalankan perilaku aman (misalnya menolak ajakan berisiko atau mengakses layanan).

Sexting — Pertukaran pesan/gambar intim secara digital; berisiko bila tanpa persetujuan atau bocor.

Sextortion — Pemerasan seksual berbasis materi intim untuk mengendalikan/ mengancam korban.

Stigma — Pelabelan negatif yang menghambat remaja mencari dukungan/ layanan dan memperburuk kesehatan mental.

Uji A/B (kampanye digital) — Metode membandingkan dua versi pesan/konten untuk memilih yang paling efektif mendorong aksi bermakna.

CHAPTER 3

INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS) PADA REMAJA

Bd. Indah Yani Br. Tambunan, S. Tr. Keb. M. Kes

A. Pendahuluan/Prolog

Infeksi Menular Seksual (IMS) merupakan salah satu masalah kesehatan serius yang harus menjadi perhatian khusus, terutama di kalangan remaja. Masa remaja merupakan periode penting dalam kehidupan seseorang yang ditandai dengan rasa ingin tahu yang tinggi, eksplorasi identitas diri, termasuk identitas seksual, serta mulai munculnya ketertarikan untuk menjalin hubungan interpersonal yang intim. Namun, perkembangan dan perubahan ini tidak selalu diiringi dengan informasi yang cukup dan akurat mengenai risiko-risiko yang terkait dengan perilaku seksual, terutama risiko terkena IMS. Oleh karena itu, membangun kesadaran remaja terhadap IMS sangat penting untuk melindungi kesehatan mereka secara jangka panjang.

Kesadaran tentang IMS sangat diperlukan karena remaja sering kali berada dalam posisi rentan, baik karena kurangnya pengetahuan tentang perilaku seksual yang aman maupun karena tekanan sosial yang menyebabkan mereka terlibat dalam hubungan seksual yang tidak aman. Remaja yang kurang memiliki kesadaran dan pemahaman tentang IMS lebih mungkin melakukan hubungan seksual tanpa perlindungan seperti penggunaan kondom, yang merupakan cara paling sederhana dan efektif untuk mencegah penularan IMS. Kurangnya edukasi yang komprehensif mengenai IMS menyebabkan remaja sering kali tidak mampu mengenali tanda-tanda awal infeksi, sehingga penanganan terlambat dan risiko komplikasi kesehatan jangka panjang meningkat.

Di samping itu, remaja juga sering memiliki anggapan yang keliru terkait risiko IMS. Banyak remaja yang masih percaya pada berbagai mitos yang berkembang di masyarakat, seperti anggapan bahwa IMS hanya dialami oleh orang-orang tertentu saja atau bahwa IMS tidak mungkin terjadi pada hubungan seksual yang dilakukan untuk pertama kalinya. Persepsi-persepsi yang salah ini menyebabkan rendahnya kewaspadaan terhadap IMS, sehingga mereka mengabaikan pentingnya langkah-

langkah preventif. Oleh sebab itu, penting untuk terus menanamkan kesadaran yang tinggi pada remaja tentang risiko IMS dan bagaimana cara melindungi diri mereka sendiri serta pasangan.

Dalam konteks global maupun nasional saat ini, tren dan prevalensi IMS di kalangan remaja semakin menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa jumlah remaja yang mengalami IMS terus meningkat setiap tahun, khususnya di kalangan remaja usia 15 hingga 24 tahun. Data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa lebih dari separuh kasus baru IMS di dunia dialami oleh remaja dan dewasa muda. IMS yang sering ditemui di kalangan remaja antara lain gonore, klamidia, herpes genital, sifilis, human papillomavirus (HPV), serta HIV/AIDS.

Di Indonesia sendiri, prevalensi IMS di kalangan remaja juga menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa sebagian besar kasus IMS terjadi pada remaja yang aktif secara seksual namun memiliki pengetahuan terbatas mengenai seksualitas dan kesehatan reproduksi. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa perilaku seksual berisiko, seperti berganti-ganti pasangan tanpa menggunakan kondom secara konsisten, menjadi salah satu faktor utama meningkatnya angka IMS di kalangan remaja.

Tren ini diperburuk oleh semakin terbukanya akses informasi yang tidak akurat dan menyesatkan melalui media sosial maupun internet. Remaja sering mendapatkan informasi yang keliru tentang seksualitas, perilaku seksual, maupun IMS dari media digital yang tidak kredibel. Akibatnya, remaja memiliki persepsi yang kurang tepat mengenai risiko kesehatan seksual, sehingga mereka menjadi rentan terhadap IMS.

Selain itu, peningkatan prevalensi IMS pada remaja juga disebabkan oleh minimnya diskusi terbuka tentang seksualitas di lingkungan keluarga dan pendidikan formal. Banyak keluarga di Indonesia masih enggan membicarakan topik seksualitas dengan anak-anak mereka secara terbuka, karena masih dianggap tabu. Hal ini menyebabkan remaja mencari sumber informasi sendiri yang belum tentu tepat. Di sekolah, kurikulum pendidikan seksual yang masih terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali juga semakin memperparah situasi, karena remaja tidak mendapatkan bekal pengetahuan yang cukup untuk menghadapi tantangan terkait IMS.

Secara umum, kondisi ini menggambarkan bahwa remaja sangat memerlukan intervensi berupa edukasi dan kesadaran yang tinggi mengenai IMS sejak dini. Pendidikan seksual yang komprehensif dan akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang ramah remaja menjadi hal yang sangat penting. Upaya-upaya ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah terjadinya IMS, tetapi juga

memberikan remaja kemampuan untuk mengambil keputusan seksual yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Dengan meningkatnya kesadaran remaja terhadap IMS, diharapkan prevalensi IMS dapat ditekan secara signifikan, sekaligus melindungi masa depan generasi muda dari berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyakit menular seksual.

B. Konsep Dasar Infeksi Menular Seksual (IMS)

Infeksi Menular Seksual (IMS) atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Sexually Transmitted Infections (STIs) merupakan infeksi yang penularannya terjadi melalui hubungan seksual, baik hubungan seksual secara vaginal, oral, maupun anal. Secara lebih luas, IMS didefinisikan sebagai sekumpulan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, parasit, atau jamur, yang ditularkan melalui aktivitas seksual tanpa menggunakan perlindungan atau melalui kontak langsung dengan cairan tubuh orang yang telah terinfeksi. Penularan IMS tidak hanya terbatas pada hubungan seksual secara langsung, tetapi juga dapat terjadi melalui penggunaan jarum suntik bersama-sama, transfusi darah, ataupun dari ibu yang terinfeksi kepada bayi selama proses kehamilan, persalinan, maupun menyusui.

Infeksi Menular Seksual diklasifikasikan menjadi beberapa kategori berdasarkan agen penyebabnya. IMS yang disebabkan oleh bakteri, misalnya gonore, klamidia, dan sifilis, umumnya dapat diobati secara efektif menggunakan antibiotik jika segera dideteksi dan ditangani dengan tepat. Sementara itu, IMS yang disebabkan oleh virus seperti Human Immunodeficiency Virus (HIV), Human Papillomavirus (HPV), herpes genital, serta hepatitis B dan C, cenderung bersifat kronis dan sulit disembuhkan secara total, sehingga pengobatan lebih diarahkan pada pengendalian gejala dan pencegahan komplikasi lebih lanjut. Di samping itu, ada pula IMS yang disebabkan oleh parasit dan jamur, seperti trikomoniasis dan kandidiasis genital, yang juga memerlukan penanganan medis yang sesuai untuk mencegah penyebaran dan kekambuhan.

Pada kalangan remaja, terdapat beberapa jenis IMS yang paling sering terjadi dan perlu mendapatkan perhatian khusus karena dampaknya yang signifikan terhadap kesehatan reproduksi remaja maupun kehidupan sosial dan emosional mereka. Jenis IMS yang paling sering ditemukan pada remaja antara lain gonore, klamidia, herpes genital, sifilis, HPV, dan HIV/AIDS.

Gonore adalah IMS yang disebabkan oleh bakteri *Neisseria gonorrhoeae*. Infeksi ini sangat umum terjadi pada remaja yang aktif secara seksual dan dapat menyebabkan gejala berupa nyeri atau sensasi terbakar saat buang air kecil, keluarnya cairan abnormal dari alat kelamin, atau bahkan tidak menunjukkan gejala sama sekali pada beberapa kasus. Jika tidak segera ditangani, gonore dapat

menyebabkan komplikasi serius seperti penyakit radang panggul pada perempuan, yang dapat mengakibatkan infertilitas atau ketidaksuburan.

Klamidia, yang disebabkan oleh bakteri *Chlamydia trachomatis*, merupakan IMS yang sering kali tidak menunjukkan gejala jelas pada tahap awal infeksi, sehingga sering disebut sebagai "silent infection". Infeksi ini dapat menimbulkan komplikasi serius seperti penyakit radang panggul pada perempuan atau radang epididimis pada laki-laki jika dibiarkan tanpa pengobatan yang tepat. Remaja yang terinfeksi klamidia dan tidak mengetahui status infeksi mereka berisiko tinggi menularkan kepada pasangan seksualnya.

Herpes genital, disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 (HSV-2), juga termasuk dalam IMS yang sering dialami oleh remaja. Infeksi ini ditandai oleh munculnya lepuhan atau luka kecil yang terasa nyeri pada area genital, anus, atau sekitarnya. Herpes genital bersifat kronis dan dapat kambuh secara periodik. Meskipun pengobatan antiviral dapat membantu mengurangi gejala dan frekuensi kekambuhan, infeksi herpes genital tidak dapat disembuhkan secara total.

Sifilis adalah IMS lain yang disebabkan oleh bakteri *Treponema pallidum*. Infeksi sifilis memiliki beberapa tahap, dimulai dari munculnya luka yang tidak nyeri di area genital (sifilis primer), kemudian berkembang menjadi ruam di tubuh (sifilis sekunder), hingga akhirnya berkembang menjadi komplikasi yang serius pada sistem saraf, jantung, dan organ-organ vital lainnya jika tidak diobati dengan tepat (sifilis tersier). Sifilis sangat berbahaya, terutama karena dapat ditularkan dari ibu hamil ke janin dan menyebabkan gangguan kehaman, cacat bawaan, atau bahkan kematian bayi.

Human Papillomavirus (HPV) adalah virus yang sangat umum ditemukan pada remaja dan dewasa muda yang aktif secara seksual. HPV memiliki banyak tipe, beberapa di antaranya bertanggung jawab atas munculnya kutil kelamin dan tipe lain yang berisiko tinggi dapat menyebabkan kanker serviks pada perempuan serta kanker lainnya pada organ genital dan tenggorokan. Meskipun ada vaksin HPV yang tersedia, remaja masih rentan terinfeksi jika mereka melakukan aktivitas seksual tanpa proteksi.

Human Immunodeficiency Virus (HIV), yang dapat berkembang menjadi Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS), adalah IMS yang paling ditakuti karena belum ditemukan obat penyembuhnya secara total. HIV menyerang sistem kekebalan tubuh dan membuat individu rentan terhadap infeksi serius dan berbagai penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Remaja yang aktif secara seksual tanpa perlindungan, pengguna jarum suntik bersama-sama, atau memiliki banyak pasangan seksual, berada dalam risiko tinggi tertular HIV.

Selain memahami jenis-jenis IMS yang sering terjadi, remaja juga perlu mengetahui berbagai faktor risiko yang menyebabkan mereka lebih rentan terkena IMS. Salah satu faktor risiko yang dominan adalah perilaku seksual berisiko, seperti berganti-ganti pasangan seksual tanpa menggunakan kondom atau pelindung lainnya. Remaja yang kurang memiliki informasi tentang risiko IMS cenderung meremehkan penggunaan alat pelindung seksual seperti kondom, yang terbukti efektif dalam mencegah penularan IMS.

Faktor risiko berikutnya adalah kurangnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan seksual yang ramah remaja. Banyak remaja yang enggan atau tidak nyaman untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan tentang kesehatan seksual mereka karena takut stigma, penghakiman, atau rasa malu. Akibatnya, IMS yang mereka alami sering kali tidak terdeteksi lebih awal, yang menyebabkan penularan ke pasangan lain dan komplikasi kesehatan yang lebih parah.

Selain itu, rendahnya tingkat edukasi seksual di keluarga, sekolah, dan komunitas juga menjadi faktor risiko utama. Keluarga yang tidak terbuka dalam membahas isu-isu seksualitas, pendidikan seksual yang kurang komprehensif di sekolah, serta norma-norma sosial yang konservatif membuat remaja mencari informasi sendiri yang belum tentu tepat atau akurat. Informasi yang keliru ini menyebabkan mereka tidak memahami cara melindungi diri dari IMS.

Di samping itu, tekanan dari lingkungan teman sebaya juga merupakan faktor risiko yang besar. Remaja yang merasa terdorong untuk mengikuti perilaku seksual teman sebayanya yang tidak aman berisiko tinggi tertular IMS. Remaja juga sering tidak mampu mengelola tekanan dari pasangan untuk melakukan hubungan seksual tanpa perlindungan, yang meningkatkan peluang mereka terkena IMS.

C. Tanda, Gejala, dan Komplikasi IMS pada Remaja

Identifikasi dini terhadap tanda dan gejala Infeksi Menular Seksual (IMS) merupakan langkah kritis dalam mencegah komplikasi kesehatan yang serius pada remaja. Sayangnya, banyak remaja tidak menyadari bahwa mereka telah terinfeksi IMS karena gejala awal yang muncul sering kali ringan, samar, atau bahkan sama sekali tidak terasa. Kondisi ini menyebabkan IMS lebih sulit dideteksi secara dini dan meningkatkan risiko penyebaran infeksi kepada pasangan seksual lainnya.

Meskipun demikian, terdapat beberapa tanda dan gejala umum IMS yang perlu dikenali oleh remaja agar dapat segera mencari pengobatan. Beberapa tanda dan gejala umum tersebut meliputi keluarnya cairan abnormal dari alat kelamin yang sering kali disertai bau tidak sedap atau warna yang tidak lazim, sensasi nyeri atau rasa terbakar saat buang air kecil, munculnya luka atau benjolan di area genital atau anus, gatal-gatal yang intens pada area genital, serta rasa nyeri selama hubungan

seksual. Pada perempuan, IMS juga dapat menimbulkan gejala tambahan seperti perdarahan di luar siklus menstruasi atau nyeri panggul yang tidak biasa. Pada beberapa kasus, IMS seperti herpes genital juga dapat disertai dengan gejala sistemik seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, dan pembengkakan kelenjar getah bening di sekitar panggul atau lipat paha.

IMS tertentu, seperti klamidia atau gonore, sering kali tidak menampilkan gejala sama sekali pada tahap awal infeksi, khususnya pada perempuan. Hal ini menjadi sangat penting diperhatikan karena meskipun gejala tidak muncul, infeksi tetap dapat menyebar dan menyebabkan kerusakan serius pada sistem reproduksi. Oleh sebab itu, remaja yang aktif secara seksual disarankan untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan seksual, terutama jika mereka memiliki banyak pasangan seksual atau terlibat dalam aktivitas seksual tanpa perlindungan yang memadai.

Selain gejala fisik yang dapat segera dikenali, IMS juga membawa dampak kesehatan yang signifikan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, IMS dapat menimbulkan ketidaknyamanan fisik seperti nyeri, gatal, rasa terbakar, atau perdarahan yang membuat aktivitas sehari-hari terganggu. Remaja yang mengalami gejala ini cenderung kehilangan konsentrasi dalam belajar, merasa malu, atau bahkan menarik diri dari aktivitas sosial karena merasa tidak nyaman dengan kondisi fisik yang dialaminya.

Dampak jangka panjang dari IMS jauh lebih serius dan dapat berdampak permanen terhadap kesehatan remaja. IMS yang tidak ditangani dengan tepat dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius, seperti penyakit radang panggul (pelvic inflammatory disease/PID) pada perempuan, yang berisiko tinggi menyebabkan infertilitas (ketidaksuburan), kehamilan ektopik, atau nyeri panggul kronis yang sulit disembuhkan. Pada laki-laki, IMS yang tidak ditangani dapat mengakibatkan radang epididimis atau epididimitis yang juga berpotensi menyebabkan infertilitas. Infeksi HPV yang berisiko tinggi bahkan dapat memicu munculnya kanker serviks pada perempuan di masa depan, sedangkan infeksi sifilis yang tidak diobati dapat berkembang menjadi sifilis tersier yang menyerang jantung, sistem saraf, hingga organ-organ vital lainnya.

Komplikasi serius lainnya yang tidak kalah penting adalah infeksi HIV yang bisa berkembang menjadi AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome). HIV melemahkan sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh kehilangan kemampuan melawan berbagai infeksi lain, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian. Remaja yang mengidap IMS lainnya juga memiliki risiko lebih tinggi untuk tertular HIV, terutama jika luka atau radang yang diakibatkan oleh IMS menjadi pintu masuk virus ke dalam tubuh.

Di samping komplikasi kesehatan fisik, IMS juga berdampak besar terhadap kesehatan psikologis remaja. Remaja yang terinfeksi IMS sering mengalami tekanan emosional seperti kecemasan, rasa bersalah, malu, hingga depresi. Stigma sosial yang melekat pada IMS sering kali membuat remaja merasa terisolasi, takut dijauhi oleh teman atau keluarga, atau bahkan mengalami kesulitan dalam hubungan interpersonalnya. Beban emosional ini bisa sangat berat, terutama jika mereka merasa tidak memiliki dukungan yang memadai atau tidak dapat berbicara terbuka mengenai kondisi mereka karena takut dihakimi atau mendapatkan stigma negatif dari masyarakat.

Ketika remaja mengalami komplikasi psikologis seperti depresi atau kecemasan berlebihan, hal ini juga dapat berakibat buruk pada prestasi akademik, kehidupan sosial, hingga kemampuan mereka dalam menjalin hubungan interpersonal yang sehat. Remaja yang terisolasi secara sosial akibat stigma IMS juga lebih rentan terhadap perilaku berisiko lainnya, seperti penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang, yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi kesehatan fisik maupun mental mereka.

Secara keseluruhan, identifikasi dini terhadap tanda dan gejala IMS serta pemahaman tentang dampak jangka pendek maupun jangka panjangnya sangat penting bagi remaja. Dengan mengenali gejala awal IMS, remaja akan mampu segera mencari bantuan medis yang diperlukan, sehingga mengurangi risiko komplikasi serius yang bisa mengancam kesehatan reproduksi, kesehatan fisik secara umum, maupun kesejahteraan psikologis mereka. Oleh karena itu, edukasi yang berkelanjutan dan pemeriksaan rutin kesehatan seksual perlu digalakkan agar remaja lebih peduli terhadap kesehatan seksualnya, serta lebih siap dalam menghadapi berbagai situasi yang berkaitan dengan IMS secara bertanggung jawab.

D. Pencegahan Infeksi Menular Seksual (IMS) pada Remaja

Pencegahan Infeksi Menular Seksual (IMS) pada remaja merupakan aspek penting yang perlu mendapat perhatian serius karena remaja berada pada fase yang penuh rasa ingin tahu dan cenderung rentan terhadap berbagai risiko perilaku seksual. Untuk itu, diperlukan pendekatan preventif yang komprehensif agar remaja memiliki pemahaman yang jelas, sikap yang tepat, serta keterampilan yang memadai dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab terkait kesehatan seksual mereka.

Salah satu cara yang paling efektif dalam mencegah IMS di kalangan remaja adalah melalui pendidikan seksual yang komprehensif dan sesuai usia. Pendidikan seksual komprehensif bukan hanya menyangkut aspek biologis atau anatomi

reproduksi semata, tetapi juga mencakup aspek emosional, sosial, dan etika yang relevan dengan kehidupan remaja sehari-hari. Melalui pendekatan ini, remaja tidak hanya diajarkan tentang risiko IMS serta metode pencegahannya, tetapi juga dilatih untuk mengembangkan keterampilan interpersonal, seperti komunikasi efektif dengan pasangan, bagaimana membuat keputusan seksual yang sehat dan bertanggung jawab, serta bagaimana menegosiasikan penggunaan metode pencegahan seperti kondom. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan seksual komprehensif tidak mendorong aktivitas seksual yang lebih dini, tetapi justru meningkatkan pemahaman dan tanggung jawab remaja, sehingga menurunkan insiden IMS serta kehamilan tidak direncanakan secara signifikan.

Di antara berbagai metode pencegahan IMS, penggunaan kondom secara benar dan konsisten merupakan metode paling efektif dan mudah diakses oleh remaja. Kondom bertindak sebagai penghalang fisik yang mencegah kontak langsung antara cairan tubuh yang terinfeksi (seperti sperma atau cairan vagina) dengan kulit atau membran mukosa yang sehat, sehingga secara efektif mengurangi risiko penularan IMS seperti gonore, klamidia, sifilis, herpes genital, HPV, dan terutama HIV. Meskipun kondom sangat efektif dalam menurunkan risiko IMS, masih banyak remaja yang enggan menggunakannya karena berbagai alasan, mulai dari ketidaknyamanan, rasa malu untuk membelinya, atau anggapan keliru bahwa penggunaan kondom dapat mengurangi kepuasan seksual. Oleh karena itu, edukasi terkait penggunaan kondom harus disertai dengan pemberian informasi yang jelas mengenai efektivitas kondom dalam mencegah IMS, serta pelatihan cara penggunaannya yang benar agar remaja mampu menggunakan metode ini secara optimal dan konsisten.

Selain kondom, metode lain yang sangat efektif untuk mencegah IMS adalah abstinensi atau menunda aktivitas seksual hingga seseorang benar-benar siap secara fisik, emosional, maupun sosial. Abstinensi adalah pilihan yang ideal bagi remaja karena sepenuhnya menghilangkan risiko IMS dan kehamilan yang tidak direncanakan. Namun demikian, promosi abstinensi saja tanpa disertai informasi yang jelas dan realistis mengenai pilihan lain seperti penggunaan kondom atau perilaku seksual aman sering kali tidak efektif dalam jangka panjang. Remaja perlu diberikan pemahaman realistis bahwa jika mereka memilih aktif secara seksual, mereka wajib bertanggung jawab dengan melakukan tindakan preventif seperti menggunakan kondom dan menjaga perilaku seksual yang aman, seperti setia pada satu pasangan seksual yang diketahui sehat, serta melakukan pemeriksaan kesehatan seksual secara rutin.

Strategi untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku sehat terkait IMS di kalangan remaja juga membutuhkan pendekatan multi-dimensi yang melibatkan

berbagai pihak, mulai dari keluarga, sekolah, komunitas, hingga media sosial. Keluarga sebagai lingkungan terdekat memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk persepsi dan sikap remaja terhadap seksualitas. Orang tua harus didorong untuk melakukan komunikasi terbuka, jujur, serta non-judgmental mengenai seksualitas dengan anak-anak mereka, sehingga remaja merasa nyaman untuk bertanya dan mendapatkan informasi yang benar. Orang tua yang bersikap suportif dapat membantu remaja memahami pentingnya menjaga kesehatan seksual serta mengurangi risiko perilaku seksual berisiko.

Di lingkungan pendidikan formal, sekolah memiliki peran yang signifikan dalam menyediakan pendidikan seksual yang terstruktur dan terintegrasi ke dalam kurikulum. Guru-guru yang terlatih dengan baik mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan terbuka, sehingga remaja merasa nyaman untuk membahas isu-isu sensitif mengenai seksualitas, serta lebih mampu menginternalisasi pesan-pesan tentang pencegahan IMS yang disampaikan. Selain itu, program pendidikan seksual di sekolah perlu dilengkapi dengan layanan konseling kesehatan reproduksi remaja, sehingga remaja memiliki tempat yang aman dan nyaman untuk mendiskusikan berbagai permasalahan seksual yang mereka hadapi.

Peran komunitas dan media sosial juga menjadi aspek penting lainnya dalam meningkatkan kesadaran remaja mengenai IMS. Kampanye publik melalui komunitas lokal dapat membantu mengurangi stigma sosial tentang IMS, sehingga remaja lebih berani untuk mencari informasi dan layanan kesehatan seksual secara terbuka tanpa takut dihakimi. Kampanye ini juga harus melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, serta pemimpin lokal agar pesan edukasi diterima lebih luas dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas tersebut.

Dalam era digital saat ini, pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi juga menjadi strategi efektif dalam menjangkau remaja. Kampanye digital melalui platform seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan Twitter dapat menyampaikan informasi tentang IMS dengan cara yang menarik, relevan, dan sesuai dengan gaya komunikasi remaja. Konten edukasi seksual yang disajikan secara visual, ringan, serta interaktif cenderung lebih diminati remaja, sehingga pesan tentang pencegahan IMS lebih mudah dipahami dan diingat. Selain itu, penggunaan aplikasi kesehatan seksual juga bisa menjadi media alternatif dalam memberikan informasi serta layanan konseling secara anonim kepada remaja, sehingga mereka lebih merasa aman dalam mengakses bantuan terkait kesehatan seksualnya.

E. Diagnosis dan Pengobatan IMS pada Remaja

Proses diagnosis Infeksi Menular Seksual (IMS) pada remaja merupakan langkah penting yang harus dilakukan secara tepat dan teliti untuk memastikan bahwa setiap remaja mendapatkan pengobatan yang akurat dan efektif. Diagnosis IMS tidak hanya bergantung pada gejala klinis yang muncul, tetapi juga perlu dilengkapi dengan serangkaian pemeriksaan medis yang sesuai untuk menegakkan diagnosis secara pasti. Proses ini harus dilakukan dengan memperhatikan aspek medis, psikologis, serta sosial yang spesifik pada kelompok usia remaja.

Pemeriksaan IMS biasanya dimulai dengan wawancara atau anamnesis mendalam antara tenaga kesehatan dengan remaja yang dicurigai memiliki IMS. Pada tahap ini, tenaga kesehatan akan menanyakan riwayat seksual remaja, gejala-gejala yang dirasakan, serta berbagai faktor risiko yang mungkin terlibat, seperti aktivitas seksual tanpa kondom, banyak pasangan seksual, atau riwayat kontak dengan seseorang yang diketahui mengalami IMS. Penting bagi tenaga kesehatan untuk menciptakan suasana yang nyaman, terbuka, dan tanpa stigma, sehingga remaja merasa aman dan tidak malu untuk memberikan informasi yang jujur. Sikap non-judgmental dari tenaga kesehatan sangat esensial karena remaja cenderung menutup diri jika merasa takut dihakimi atau mendapat stigma negatif dari lingkungan sekitarnya.

Setelah proses wawancara dilakukan, tenaga kesehatan akan melanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik pada remaja dengan dugaan IMS mencakup pemeriksaan secara menyeluruh pada daerah genital, anus, dan mulut—area yang umum menjadi tempat terjadinya IMS. Beberapa tanda fisik yang sering ditemukan dalam pemeriksaan tersebut misalnya adalah lesi atau luka terbuka pada alat kelamin, ruam, adanya keputihan atau cairan abnormal, kemerahan, bengkak, atau nyeri saat pemeriksaan dilakukan. Akan tetapi, tidak semua IMS menunjukkan gejala yang jelas, sehingga pemeriksaan laboratorium biasanya sangat diperlukan.

Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan untuk diagnosis IMS melibatkan pengambilan sampel darah, urin, atau cairan dari alat kelamin untuk pemeriksaan lebih lanjut. Metode diagnostik yang paling umum digunakan antara lain tes serologi untuk sifilis, tes kultur atau PCR untuk mendeteksi infeksi bakteri seperti gonore dan klamidia, serta tes cepat atau ELISA untuk mendeteksi infeksi HIV dan hepatitis. Hasil pemeriksaan laboratorium ini merupakan dasar penting dalam menentukan diagnosis IMS yang spesifik, sehingga pengobatan dapat disesuaikan secara tepat dengan jenis IMS yang diderita oleh remaja tersebut.

Setelah diagnosis IMS ditegakkan, langkah berikutnya adalah pemberian pengobatan medis yang tepat dan efektif. Pengobatan IMS pada remaja umumnya melibatkan terapi farmakologis menggunakan antibiotik, antivirus, atau antijamur,

tergantung pada jenis IMS yang ditemukan. Sebagai contoh, gonore dan klamidia biasanya ditangani dengan pemberian antibiotik spesifik seperti ceftriaxone atau azitromisin. IMS akibat virus seperti herpes genital atau HIV memerlukan terapi antivirus jangka panjang yang bertujuan mengendalikan gejala serta memperlambat progresivitas penyakit. Selain pengobatan farmakologis, remaja juga perlu diberikan edukasi tambahan tentang pentingnya menyelesaikan pengobatan sesuai resep dokter, tidak melakukan hubungan seksual selama masa pengobatan, serta pentingnya melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan infeksi telah benar-benar sembuh.

Dalam beberapa kasus IMS seperti HPV atau herpes genital, meskipun terapi antivirus dapat membantu mengurangi gejala dan risiko penularan, virus tersebut mungkin tetap berada dalam tubuh untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, pendekatan holistik dalam pengobatan juga penting, termasuk dukungan psikososial untuk membantu remaja menghadapi dampak emosional serta sosial akibat diagnosis IMS. Konseling tentang dampak jangka panjang serta strategi pencegahan penularan kepada pasangan sangat penting dilakukan secara bersamaan dengan pengobatan medis.

Namun demikian, proses pengobatan IMS pada remaja sering kali menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari aspek medis, psikologis, maupun sosial. Salah satu tantangan utama adalah stigma sosial yang masih melekat kuat terhadap remaja yang didiagnosis memiliki IMS. Rasa malu dan ketakutan terhadap stigma dari keluarga, teman, maupun komunitas seringkali menyebabkan remaja enggan atau bahkan menolak melakukan pemeriksaan lanjutan, serta enggan menyelesaikan pengobatan secara tuntas. Stigma ini juga membuat remaja kurang terbuka dalam menginformasikan pasangan seksualnya untuk ikut diperiksa dan mendapatkan pengobatan, sehingga risiko penularan IMS terus berlanjut.

Tantangan lain dalam pengobatan IMS adalah rendahnya tingkat kepatuhan remaja dalam mengonsumsi obat yang diresepkan. Remaja sering kali kurang memahami pentingnya menyelesaikan seluruh rangkaian terapi pengobatan, terutama jika gejala telah hilang. Akibatnya, risiko kegagalan pengobatan meningkat, infeksi dapat kembali muncul, bahkan risiko resistensi terhadap antibiotik juga bisa meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, edukasi tentang pentingnya kepatuhan pada terapi menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan oleh tenaga kesehatan dalam menangani IMS pada remaja.

Faktor keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan yang ramah remaja juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengobatan IMS. Tidak semua layanan kesehatan menyediakan tenaga profesional yang memahami kondisi psikologis remaja serta mampu memberikan pelayanan secara ramah remaja. Remaja yang

merasa tidak nyaman, dihakimi, atau kurang didukung secara emosional oleh petugas medis cenderung menghindari kunjungan ulang untuk kontrol maupun pengobatan lanjutan. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas layanan kesehatan reproduksi remaja yang ramah, sensitif, dan bebas stigma menjadi hal yang sangat penting untuk membantu remaja menjalani pengobatan IMS secara optimal.

Dalam upaya mengatasi berbagai tantangan tersebut, pendekatan multidisiplin yang melibatkan tenaga kesehatan, konselor, keluarga, komunitas, serta sistem pendidikan menjadi sangat penting. Remaja membutuhkan dukungan holistik, baik dari aspek medis maupun psikososial, agar mampu mengatasi hambatan dalam proses diagnosis dan pengobatan IMS. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, remaja diharapkan dapat menyelesaikan pengobatan secara efektif, meminimalisir risiko komplikasi kesehatan jangka panjang, serta meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan di masa depan.

F. Aspek Psikososial pada Remaja dengan IMS

Infeksi Menular Seksual (IMS) tidak hanya berdampak pada aspek fisik semata, tetapi juga membawa dampak psikososial yang cukup besar, terutama bagi kelompok remaja yang sedang berada dalam masa transisi perkembangan yang sensitif. Masa remaja adalah periode penting dalam pembentukan identitas, di mana remaja berusaha untuk mendapatkan penerimaan sosial dan membangun kepercayaan diri. Oleh sebab itu, diagnosis IMS sering kali menyebabkan berbagai dampak psikologis seperti perasaan malu, takut, rendah diri, hingga depresi, serta membawa konsekuensi sosial berupa stigma, diskriminasi, dan isolasi dari lingkungan sekitar.

Stigma sosial yang melekat pada remaja dengan IMS sering kali berasal dari pemahaman masyarakat yang keliru atau kurang informasi tentang IMS itu sendiri. Banyak orang menganggap bahwa remaja yang mengalami IMS adalah mereka yang memiliki perilaku seksual tidak bermoral atau tidak bertanggung jawab. Persepsi ini menciptakan stereotip negatif yang menyulitkan remaja untuk secara terbuka mencari bantuan medis maupun psikologis yang diperlukan. Akibatnya, stigma ini semakin memperparah kondisi emosional mereka. Remaja mungkin akan merasa malu, bersalah, dan takut jika diagnosis mereka diketahui oleh teman sebaya, keluarga, maupun komunitas di sekitarnya. Rasa takut terhadap pengucilan dan pandangan negatif dari lingkungan membuat remaja cenderung menyembunyikan kondisi kesehatan mereka, menghindari interaksi sosial, serta menarik diri dari pergaulan. Kondisi ini dapat berkembang menjadi isolasi sosial yang memperparah dampak psikologis yang mereka rasakan.

Selain stigma, remaja yang mengalami IMS juga cenderung mengalami tingkat stres yang tinggi. Stres ini berasal dari berbagai sumber, mulai dari rasa takut akan penolakan sosial, ketidakpastian tentang masa depan mereka, hingga kecemasan mengenai dampak jangka panjang penyakit tersebut terhadap kesehatan mereka. Dalam beberapa kasus, tingkat stres yang tinggi bisa berkembang menjadi gangguan kecemasan atau depresi, yang jika tidak segera ditangani dapat berdampak serius pada kesehatan mental dan emosional remaja. Oleh karena itu, pengelolaan aspek psikologis pada remaja dengan IMS harus menjadi bagian integral dalam penanganan medis yang diberikan kepada mereka.

Dalam konteks ini, peran dukungan sosial menjadi sangat penting dalam proses pemulihan psikososial remaja yang mengalami IMS. Dukungan sosial, baik dari keluarga, teman, maupun komunitas, merupakan faktor yang sangat signifikan dalam membantu remaja menghadapi berbagai tekanan emosional yang muncul akibat diagnosis IMS. Remaja yang mendapat dukungan sosial yang kuat terbukti lebih mampu mengatasi stres, mempercepat proses pemulihan emosional, serta lebih memiliki motivasi untuk menjalani pengobatan secara disiplin dan efektif. Dukungan dari keluarga misalnya, dapat memberikan rasa aman bagi remaja, membantu mereka menerima kondisi yang mereka alami, serta mengurangi rasa bersalah dan malu yang mereka rasakan. Dalam hal ini, keluarga yang menerima, mendukung, dan tidak memberikan penghakiman negatif sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan emosional dan mental remaja.

Di samping dukungan sosial dari keluarga dan teman, peran konseling profesional juga menjadi komponen penting dalam proses pemulihan remaja dengan IMS. Konseling psikososial yang diberikan oleh tenaga profesional seperti psikolog, konselor, atau pekerja sosial dapat membantu remaja mengelola perasaan negatif mereka seperti rasa malu, cemas, dan bersalah. Melalui sesi konseling, remaja dapat belajar strategi adaptasi emosional yang lebih baik, meningkatkan kepercayaan diri, serta mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk menghadapi tekanan stigma dan diskriminasi di lingkungan mereka. Konseling juga berfungsi sebagai ruang aman bagi remaja untuk membicarakan kekhawatiran mereka tanpa takut dihakimi, serta mendapatkan arahan profesional mengenai bagaimana cara menghadapi berbagai tantangan emosional dan sosial yang mereka alami.

Selain peran konseling, strategi khusus juga perlu dikembangkan untuk membantu remaja menghadapi stigma dan diskriminasi yang seringkali muncul akibat diagnosis IMS. Salah satu strategi efektif adalah dengan pemberian edukasi yang komprehensif kepada masyarakat luas, khususnya komunitas tempat remaja tinggal atau beraktivitas. Edukasi ini bertujuan untuk memperbaiki pemahaman

masyarakat tentang IMS, termasuk bagaimana IMS dapat terjadi, cara penularannya, serta pentingnya dukungan sosial bagi penderita IMS dalam proses pemulihan mereka. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang IMS, stigma negatif dapat berkurang secara signifikan. Remaja yang mengalami IMS kemudian akan merasa lebih nyaman dan aman dalam lingkungan sosial mereka, sehingga lebih terbuka untuk mencari bantuan serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial tanpa takut dikucilkan atau dihakimi.

Di tingkat individu, strategi menghadapi stigma juga dapat mencakup keterampilan seperti pembentukan self-esteem atau harga diri yang positif. Melalui bimbingan dari konselor atau tenaga profesional, remaja diajarkan untuk memahami bahwa memiliki IMS bukanlah sesuatu yang menentukan nilai atau moralitas mereka sebagai individu. Mereka dibantu untuk memahami bahwa kondisi ini adalah bagian dari tantangan kehidupan yang bisa diatasi, bukan sesuatu yang harus terus menerus disalahkan atau menjadi sumber rasa malu yang permanen. Strategi ini membantu remaja untuk memisahkan identitas diri mereka dari kondisi IMS yang dialami, sehingga dapat mengurangi beban psikologis dan emosional yang mereka rasakan.

Di samping itu, strategi pengembangan keterampilan komunikasi yang efektif juga penting untuk diajarkan kepada remaja. Remaja yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik lebih mampu untuk menghadapi situasi sulit seperti diskriminasi atau perlakuan negatif dari lingkungan. Mereka mampu mengomunikasikan kebutuhan dan perasaan mereka secara jelas, tegas, serta tanpa konfrontasi yang berlebihan. Keterampilan komunikasi juga akan membantu mereka dalam mencari dan mendapatkan dukungan sosial yang diperlukan dalam proses pemulihan mereka dari IMS.

G. Peran Orang Tua, Guru, dan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanganan IMS pada Remaja

Pencegahan dan penanganan Infeksi Menular Seksual (IMS) di kalangan remaja membutuhkan pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai pihak secara aktif. Orang tua, guru, serta masyarakat luas memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung remaja agar terhindar dari risiko IMS, sekaligus memastikan mereka mendapat penanganan tepat jika terinfeksi. Pendekatan multidimensi ini penting karena remaja tidak hanya hidup di lingkungan keluarga atau sekolah, tetapi juga merupakan bagian dari komunitas yang lebih besar. Oleh karena itu, dukungan yang menyeluruh dari seluruh elemen ini menjadi kunci keberhasilan upaya pencegahan dan penanganan IMS.

Orang tua merupakan lingkungan pertama dan paling dekat bagi remaja. Oleh sebab itu, mereka memainkan peran yang sangat vital dalam upaya pencegahan IMS melalui pendidikan seksual awal di rumah. Keluarga yang terbuka dalam membicarakan isu seksualitas secara terbuka, jujur, dan sesuai dengan tahap perkembangan anak dapat membantu remaja membangun pemahaman yang benar tentang seksualitas, hubungan interpersonal, serta risiko IMS. Keterbukaan ini sangat penting karena membantu remaja merasa nyaman bertanya dan mendiskusikan berbagai persoalan seksual secara terbuka, tanpa rasa takut atau malu. Orang tua juga bertanggung jawab dalam mengajarkan nilai-nilai moral serta prinsip-prinsip perilaku seksual yang bertanggung jawab, sehingga remaja memiliki panduan yang jelas dalam mengambil keputusan terkait kehidupan seksual mereka.

Selain pendidikan seksual, orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan rumah yang suportif dan non-judgemental bagi remaja yang mengalami IMS. Remaja yang terinfeksi IMS sering kali mengalami tekanan psikologis berupa rasa malu, takut, dan isolasi. Dalam situasi ini, keluarga harus mampu memberikan dukungan emosional yang kuat dan tidak menghakimi. Dukungan keluarga yang hangat dan menerima sangat penting bagi remaja dalam menghadapi tekanan psikologis akibat diagnosis IMS. Orang tua yang mampu memberikan dukungan emosional dan mendampingi remaja dalam menjalani pengobatan, secara signifikan meningkatkan peluang remaja untuk sembuh lebih cepat, baik secara fisik maupun emosional.

Di sisi lain, guru dan sekolah sebagai lingkungan pendidikan formal juga memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan IMS pada remaja. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang memiliki akses luas kepada remaja, sehingga menjadi tempat yang ideal untuk menyampaikan edukasi seksual yang komprehensif dan akurat. Guru sebagai fasilitator pendidikan berperan penting dalam memastikan bahwa remaja mendapatkan informasi yang tepat, objektif, dan sesuai dengan usia mereka. Informasi yang diberikan harus mencakup berbagai aspek seksualitas, mulai dari anatomi dan fisiologi reproduksi, cara penularan IMS, tanda dan gejala IMS, hingga berbagai metode pencegahan yang efektif. Guru juga berperan penting dalam membimbing remaja agar mampu membuat keputusan seksual yang bertanggung jawab, serta mengajarkan keterampilan sosial untuk menolak tekanan teman sebaya yang mungkin mendorong perilaku seksual berisiko.

Namun, peran guru tidak hanya terbatas pada pemberian informasi saja. Guru juga bertanggung jawab menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung, inklusif, dan aman bagi semua siswa, termasuk siswa yang mengalami IMS. Penting bagi guru untuk memahami bahwa siswa yang terinfeksi IMS memerlukan dukungan emosional dan sosial dari lingkungan sekolah. Guru perlu membangun kepercayaan

dengan siswa agar siswa merasa aman untuk berkonsultasi dan mencari bantuan jika mereka mengalami gejala IMS atau menghadapi tekanan sosial terkait masalah ini. Dengan pendekatan yang suportif dan non-diskriminatif dari guru, remaja akan merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam mengelola kondisi mereka, serta lebih cepat untuk mencari pertolongan medis yang tepat.

Selain peran keluarga dan sekolah, masyarakat secara keseluruhan juga memiliki peran yang tak kalah penting dalam pencegahan dan penanganan IMS pada remaja. Masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, pemimpin lokal, serta berbagai lembaga kesehatan dan sosial, perlu dilibatkan dalam upaya ini untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi remaja agar terhindar dari risiko IMS. Masyarakat yang paham tentang pentingnya kesehatan seksual dan reproduksi dapat menciptakan suasana terbuka, sehingga remaja lebih mudah untuk mengakses layanan kesehatan reproduksi serta informasi yang akurat mengenai IMS. Kampanye edukasi publik yang dilakukan secara teratur oleh berbagai pihak di masyarakat, misalnya melalui media massa, media sosial, kegiatan komunitas, atau kampanye kesehatan di tingkat desa atau kelurahan, merupakan salah satu bentuk keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pencegahan IMS.

Pelibatan tokoh masyarakat dan pemuka agama juga memiliki dampak yang sangat positif. Mengingat bahwa pembicaraan tentang seksualitas dan IMS di beberapa komunitas sering dianggap tabu atau sensitif, peran tokoh agama atau tokoh masyarakat sangat strategis dalam mengatasi resistensi dan stigma yang muncul. Dengan dukungan tokoh-tokoh ini, pesan-pesan edukasi tentang seksualitas dan IMS dapat disampaikan dengan lebih diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Tokoh agama, misalnya, dapat membantu dalam menyampaikan bahwa edukasi seksual tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, melainkan justru bertujuan melindungi generasi muda dari berbagai risiko kesehatan dan psikologis.

Masyarakat juga dapat berperan aktif dengan menyediakan berbagai fasilitas kesehatan reproduksi yang ramah remaja. Adanya layanan kesehatan khusus remaja di tingkat komunitas seperti puskesmas remaja, klinik konseling, atau layanan kesehatan remaja lainnya, merupakan bentuk nyata dukungan masyarakat dalam penanganan IMS. Layanan-layanan ini tidak hanya menyediakan pemeriksaan medis dan pengobatan, tetapi juga konseling dan edukasi yang diperlukan remaja dalam mengatasi berbagai persoalan psikososial yang muncul akibat IMS.

Di samping itu, masyarakat perlu menciptakan lingkungan sosial yang suportif dan bebas diskriminasi terhadap remaja dengan IMS. Upaya ini dapat dilakukan melalui edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran bahwa IMS dapat terjadi pada siapa saja, bukan hanya pada individu dengan perilaku seksual tertentu. Masyarakat yang lebih teredukasi tentang IMS akan cenderung lebih menerima dan

mendukung remaja yang mengalami kondisi ini, sehingga mengurangi dampak psikologis berupa stigma dan isolasi sosial.

peran keluarga, guru, serta masyarakat luas merupakan pilar penting dalam upaya pencegahan dan penanganan IMS pada remaja. Sinergi yang kuat antara ketiga pihak ini akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi remaja untuk tumbuh menjadi individu yang sehat, bertanggung jawab secara seksual, serta memiliki pemahaman yang matang tentang bagaimana melindungi diri mereka sendiri dari IMS. Secara keseluruhan, pendekatan kolaboratif ini sangat esensial untuk mencapai keberhasilan dalam menurunkan prevalensi IMS di kalangan remaja dan menciptakan generasi muda yang lebih sehat secara fisik, emosional, maupun sosial.

H. Tantangan dalam Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Menular Seksual (IMS) di Kalangan Remaja

Pencegahan dan pengendalian Infeksi Menular Seksual (IMS) pada remaja merupakan upaya kompleks yang dihadapkan pada sejumlah tantangan signifikan. Tantangan-tantangan ini melibatkan berbagai aspek sosial, budaya, agama, serta masalah teknis dalam akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Memahami hambatan ini secara mendalam sangat penting untuk merancang strategi efektif dalam mengatasi berbagai kendala dalam implementasi program pencegahan IMS di kalangan remaja.

Salah satu tantangan utama dalam pencegahan IMS adalah adanya stigma yang melekat kuat terhadap topik seksualitas dan IMS di berbagai komunitas. Banyak masyarakat menganggap isu ini tabu dan tidak pantas dibicarakan secara terbuka, terutama kepada remaja. Stigma semacam ini dapat menyebabkan remaja takut atau malu untuk mencari informasi yang akurat, bertanya kepada orang dewasa, atau bahkan mengakses layanan kesehatan seksual. Akibatnya, remaja cenderung mendapatkan informasi yang keliru atau tidak lengkap, yang pada akhirnya meningkatkan risiko perilaku seksual yang tidak aman. Selain itu, stigma juga menyebabkan remaja yang terinfeksi IMS seringkali merasa malu, takut, dan enggan mencari bantuan medis, sehingga memperburuk kondisi kesehatan mereka.

Selain stigma, norma sosial yang konservatif di berbagai masyarakat juga menjadi hambatan signifikan dalam edukasi dan pencegahan IMS. Norma sosial ini sering kali menganggap bahwa memberikan pendidikan seksual kepada remaja merupakan hal yang tidak pantas atau bahkan dapat mendorong remaja untuk melakukan aktivitas seksual secara dini. Persepsi yang keliru ini menyebabkan banyak keluarga dan komunitas enggan untuk mendukung program pendidikan seksual komprehensif. Kondisi ini semakin menyulitkan upaya pencegahan IMS

karena remaja kehilangan kesempatan mendapatkan informasi penting yang dapat melindungi mereka dari risiko IMS.

Hambatan serupa juga muncul dari aspek agama, di mana sebagian kalangan agama atau tokoh agama tertentu memiliki pandangan yang konservatif mengenai pendidikan seksualitas. Pendidikan seksual sering kali dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama atau moralitas yang diyakini masyarakat tertentu. Pandangan semacam ini menciptakan resistensi yang signifikan, terutama saat program pencegahan IMS diselenggarakan di sekolah atau komunitas dengan latar belakang keagamaan yang kuat. Akibatnya, program edukasi seksualitas dan pencegahan IMS sulit diimplementasikan secara terbuka dan komprehensif, menyebabkan upaya pencegahan menjadi parsial dan tidak efektif secara optimal.

Selain tantangan sosial dan budaya, hambatan yang serius juga ditemukan dalam akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang ramah remaja. Banyak layanan kesehatan seksual tidak tersedia secara luas, terutama di daerah pedesaan atau terpencil. Kalaupun tersedia, layanan tersebut seringkali tidak ramah remaja karena kurangnya tenaga kesehatan yang memiliki pelatihan khusus dalam memberikan layanan kepada kelompok usia ini. Akibatnya, remaja merasa tidak nyaman atau bahkan takut untuk mengakses layanan kesehatan reproduksi, termasuk pemeriksaan, diagnosis, dan pengobatan IMS. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya jaminan privasi dan kerahasiaan dalam layanan kesehatan yang ada, yang membuat remaja enggan mencari bantuan medis karena takut informasi pribadi mereka tersebar.

Hambatan lain dalam akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi adalah keterbatasan pengetahuan remaja tentang hak mereka terkait layanan tersebut. Banyak remaja tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang aman, terjangkau, dan bersifat konfidensial. Ketidaktahuan ini menyebabkan mereka tidak memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia meskipun mereka membutuhkannya. Selain itu, ketergantungan ekonomi terhadap orang tua atau keluarga juga menjadi tantangan tambahan, karena remaja seringkali harus mendapat izin atau pendampingan orang tua dalam mengakses layanan kesehatan seksual, yang tentunya memperbesar kemungkinan mereka memilih untuk tidak mencari bantuan.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi holistik yang melibatkan berbagai pihak secara aktif. Salah satu strategi utama adalah mengembangkan dialog terbuka dan berkelanjutan dengan para tokoh agama, pemuka adat, serta tokoh masyarakat untuk menjelaskan pentingnya edukasi seksualitas dan pencegahan IMS bagi remaja. Dialog ini bertujuan mengurangi resistensi, stigma, serta persepsi negatif yang berkembang di tengah masyarakat.

Dengan keterlibatan aktif tokoh-tokoh masyarakat yang dihormati, pesan tentang pentingnya edukasi seksual dapat lebih diterima secara luas, sehingga remaja mendapatkan akses lebih baik terhadap informasi akurat dan layanan yang dibutuhkan.

Selain dialog dengan tokoh masyarakat dan agama, diperlukan juga upaya edukasi publik secara masif dan konsisten. Kampanye publik melalui media massa, media sosial, serta kegiatan berbasis komunitas menjadi cara efektif untuk meningkatkan kesadaran tentang IMS dan pentingnya pendidikan seksual komprehensif. Melalui edukasi ini, masyarakat dapat memahami bahwa memberikan informasi seksual kepada remaja tidak mendorong aktivitas seksual dini, melainkan justru membantu mereka membuat keputusan yang bertanggung jawab dan aman secara seksual.

Dari segi layanan kesehatan, diperlukan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan agar mampu memberikan layanan yang benar-benar ramah remaja. Pelatihan khusus bagi tenaga kesehatan perlu dilakukan secara rutin agar mereka memiliki keterampilan komunikasi, pendekatan non-judgemental, serta mampu menjaga privasi dan kerahasiaan pasien remaja. Selain itu, pengembangan layanan kesehatan seksual yang mudah diakses oleh remaja, seperti klinik remaja atau layanan konsultasi daring, juga menjadi strategi penting untuk mengatasi hambatan akses fisik yang seringkali dialami oleh remaja, terutama di daerah terpencil atau tertinggal.

Strategi lain adalah memberdayakan remaja itu sendiri untuk terlibat aktif dalam perancangan dan pelaksanaan program pencegahan IMS. Dengan melibatkan remaja secara langsung, program yang dirancang akan lebih relevan dengan kebutuhan nyata remaja dan memiliki peluang sukses yang lebih tinggi. Selain itu, keterlibatan remaja akan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap program tersebut, sehingga mereka menjadi lebih aktif dalam mendukung implementasi serta menyebarluaskan informasi yang benar kepada teman sebaya.

Melalui berbagai upaya ini, diharapkan tantangan-tantangan dalam pencegahan dan pengendalian IMS di kalangan remaja dapat diminimalkan secara signifikan. Pendekatan yang melibatkan berbagai elemen sosial, budaya, dan teknis ini penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung remaja dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang mereka perlukan. Dengan demikian, program pencegahan IMS dapat mencapai hasil optimal dalam melindungi remaja dari risiko IMS serta memastikan masa depan generasi muda yang lebih sehat, aman, dan bertanggung jawab secara seksual.

I. Evaluasi Program Pencegahan dan Penanganan Infeksi Menular Seksual (IMS) pada Remaja

Evaluasi merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanganan Infeksi Menular Seksual (IMS) pada remaja. Evaluasi berfungsi sebagai alat untuk mengukur keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang telah dirancang sebelumnya, sekaligus membantu mengidentifikasi berbagai kelemahan atau tantangan yang muncul selama proses implementasi. Dengan demikian, evaluasi yang terstruktur dan terencana secara matang sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar efektif dan berdampak positif terhadap kesehatan seksual dan reproduksi remaja.

Dalam melaksanakan evaluasi, diperlukan indikator keberhasilan yang jelas dan terukur. Indikator-indikator ini harus relevan dengan tujuan program yang ingin dicapai, seperti peningkatan pengetahuan dan kesadaran remaja tentang IMS, perubahan sikap remaja terhadap perilaku seksual yang aman, peningkatan akses remaja terhadap layanan kesehatan seksual, hingga penurunan prevalensi kasus IMS di kalangan remaja. Misalnya, indikator utama yang sering digunakan dalam evaluasi program pencegahan IMS adalah meningkatnya jumlah remaja yang memiliki pengetahuan benar tentang jenis-jenis IMS, cara penularannya, metode pencegahan yang efektif seperti penggunaan kondom, dan pentingnya perilaku seksual yang aman.

Indikator lain yang penting dalam mengukur keberhasilan program adalah terjadinya perubahan perilaku pada remaja, seperti peningkatan penggunaan kondom secara konsisten, penurunan jumlah pasangan seksual yang berganti-ganti, serta peningkatan kunjungan remaja ke fasilitas layanan kesehatan seksual dan reproduksi untuk melakukan pemeriksaan rutin atau pengobatan. Di tingkat populasi, indikator keberhasilan jangka panjang yang lebih luas adalah terjadinya penurunan angka kejadian IMS secara signifikan di kelompok usia remaja di wilayah atau komunitas tempat program dilaksanakan. Selain itu, indikator tambahan yang sering digunakan adalah peningkatan jumlah remaja yang bersedia berbicara terbuka tentang kesehatan seksual dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan edukasi IMS yang diselenggarakan.

Untuk memastikan evaluasi program pencegahan IMS berjalan optimal, berbagai metode evaluasi yang tepat harus digunakan. Salah satu metode evaluasi yang paling umum digunakan adalah survei kuantitatif. Metode ini dilakukan dengan memberikan kuesioner terstruktur kepada remaja sebelum dan sesudah mengikuti program edukasi atau intervensi tertentu. Kuesioner ini biasanya berisi pertanyaan terkait pengetahuan remaja tentang IMS, sikap terhadap perilaku seksual yang aman, praktik penggunaan alat pencegah IMS seperti kondom, dan

perilaku kesehatan seksual lainnya. Data dari survei kuantitatif ini kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi perubahan yang signifikan setelah program intervensi dilakukan.

Selain survei kuantitatif, metode evaluasi lain yang efektif adalah wawancara mendalam (in-depth interview). Metode ini memungkinkan evaluator untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana remaja memahami dan mengaplikasikan materi edukasi yang diterima. Melalui wawancara mendalam, evaluator dapat mengeksplorasi lebih lanjut mengenai persepsi remaja terhadap program, pengalaman pribadi mereka, tantangan yang mereka hadapi dalam mengubah perilaku, serta saran atau masukan untuk perbaikan program di masa depan.

Metode lain yang juga penting dalam evaluasi program pencegahan IMS adalah Focus Group Discussion (FGD). Dalam diskusi kelompok ini, remaja secara aktif berpartisipasi menyampaikan pandangan, kesan, dan pengalaman mereka selama mengikuti program. FGD sangat bermanfaat untuk mengevaluasi aspek sosial dan psikologis dari program, misalnya sejauh mana materi edukasi yang disampaikan dianggap relevan dan mudah dipahami, bagaimana remaja merasakan manfaat program tersebut, serta apakah metode penyampaian materi sudah cukup efektif dalam mendorong perubahan perilaku yang diharapkan.

Selain metode kualitatif dan kuantitatif, evaluasi juga dapat dilengkapi dengan observasi lapangan secara langsung. Observasi ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana interaksi antara fasilitator atau pendidik dengan remaja selama pelaksanaan program, tingkat partisipasi remaja dalam kegiatan, serta efektivitas metode edukasi yang digunakan. Observasi langsung ini juga berguna untuk mengevaluasi bagaimana reaksi remaja terhadap pesan-pesan edukasi yang disampaikan, serta untuk mengidentifikasi secara nyata tantangan yang mungkin muncul di lapangan.

Selain penggunaan indikator dan metode evaluasi tersebut, studi kasus tentang keberhasilan implementasi program pencegahan dan pengendalian IMS merupakan bagian penting dalam evaluasi yang bersifat lebih mendalam dan komprehensif. Studi kasus biasanya dilakukan di wilayah atau sekolah tertentu yang dianggap berhasil dalam menurunkan angka prevalensi IMS di kalangan remaja setelah menerapkan intervensi tertentu. Dalam studi kasus ini, proses dokumentasi dilakukan secara rinci mengenai bagaimana program dirancang, strategi apa yang digunakan, bagaimana pelibatan berbagai pihak seperti guru, orang tua, masyarakat, dan tenaga kesehatan dilakukan, serta bagaimana tantangan selama pelaksanaan program berhasil diatasi.

Salah satu contoh studi kasus yang dapat dijadikan rujukan adalah pelaksanaan program pendidikan seksual komprehensif berbasis sekolah di suatu wilayah perkotaan. Program ini berhasil meningkatkan secara signifikan kesadaran siswa tentang risiko IMS, meningkatkan penggunaan kondom secara konsisten, serta menurunkan angka kejadian IMS di kalangan siswa selama periode tertentu. Dalam dokumentasi studi kasus tersebut, dijelaskan secara lengkap mengenai pendekatan yang digunakan, materi edukasi yang diberikan, serta hasil evaluasi kuantitatif maupun kualitatif yang dilakukan secara berkala. Keberhasilan studi kasus ini menjadi bukti kuat bahwa intervensi yang dijalankan memiliki dampak nyata, serta menjadi acuan berharga bagi program serupa di wilayah atau komunitas lain.

Studi kasus lainnya dapat berupa keberhasilan program berbasis komunitas di wilayah pedesaan yang awalnya menghadapi tantangan stigma dan hambatan akses layanan kesehatan. Dengan menggunakan pendekatan dialog berbasis budaya lokal, melibatkan tokoh masyarakat dan agama, serta mendirikan layanan konseling remaja yang ramah, program ini berhasil meraih dukungan luas dari komunitas setempat. Hasil evaluasi menunjukkan penurunan angka kejadian IMS, peningkatan kunjungan remaja ke layanan kesehatan seksual, serta perubahan positif dalam persepsi masyarakat terhadap pentingnya edukasi seksual. Studi kasus semacam ini memperkaya evaluasi dengan menghadirkan contoh nyata yang bisa dijadikan model bagi program-program lain yang menghadapi tantangan serupa.

evaluasi yang dilakukan secara cermat dan menyeluruh akan memberikan gambaran jelas mengenai efektivitas program pencegahan dan penanganan IMS pada remaja. Evaluasi ini tidak hanya menjadi alat ukur keberhasilan semata, tetapi juga sebagai bahan refleksi untuk terus melakukan perbaikan dan pengembangan program di masa depan. Melalui evaluasi yang baik, pengelola program dapat memastikan bahwa tujuan akhir dari program tersebut—yaitu terciptanya remaja yang memiliki pengetahuan luas tentang IMS, perilaku seksual yang bertanggung jawab, dan kualitas hidup seksual yang sehat—benar-benar tercapai secara maksimal.

J. Simpulan

Infeksi Menular Seksual (IMS) merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang memerlukan perhatian serius, terutama di kalangan remaja. Masa remaja adalah masa kritis yang ditandai oleh rasa ingin tahu tinggi dan eksplorasi seksual, sehingga menempatkan mereka pada posisi rentan terhadap IMS. Kesadaran yang rendah, kurangnya informasi yang akurat, serta berbagai mitos keliru tentang IMS turut berperan dalam meningkatnya prevalensi IMS pada kelompok ini.

IMS seperti gonore, klamidia, sifilis, herpes genital, HPV, dan HIV/AIDS merupakan jenis yang sering ditemui di kalangan remaja, dengan dampak serius terhadap kesehatan fisik dan psikologis. Gejala-gejala IMS sering kali tidak disadari oleh remaja karena bisa muncul secara samar atau bahkan tanpa gejala, menyebabkan keterlambatan diagnosis dan penanganan. Akibatnya, komplikasi serius seperti infertilitas, radang panggul, hingga risiko kanker serviks dan AIDS dapat terjadi.

Pencegahan IMS yang efektif pada remaja menekankan pentingnya pendidikan seksual yang komprehensif sejak dini, yang mencakup informasi tentang cara penularan, penggunaan kondom secara konsisten, abstinensi seksual, dan praktik perilaku seksual yang aman. Pendidikan seksual ini harus melibatkan keluarga, guru, dan komunitas secara luas untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi remaja dalam memahami dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab terkait seksualitas mereka.

Dalam diagnosis dan pengobatan IMS, pendekatan medis yang ramah remaja dan berorientasi pada privasi merupakan hal yang esensial. Namun demikian, tantangan seperti stigma sosial, hambatan budaya, norma konservatif, serta akses layanan kesehatan reproduksi yang terbatas masih menjadi kendala besar yang perlu diatasi. Dukungan sosial, konseling psikososial, serta keterlibatan aktif remaja dalam setiap langkah pencegahan dan penanganan IMS juga menjadi kunci penting dalam meningkatkan efektivitas program.

Evaluasi berkala terhadap program pencegahan dan penanganan IMS sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan program tercapai dengan maksimal. Melalui evaluasi yang terstruktur dan menyeluruh, keberhasilan program dapat diukur secara jelas, kelemahan dapat diidentifikasi, dan perbaikan program dapat dilakukan secara berkelanjutan.

pendekatan terpadu yang melibatkan orang tua, guru, tenaga kesehatan, dan masyarakat luas sangat diperlukan untuk menurunkan prevalensi IMS secara signifikan di kalangan remaja. Dengan upaya bersama yang efektif, diharapkan remaja mampu melewati masa perkembangan mereka dengan sehat, bertanggung jawab, dan terlindungi dari berbagai risiko IMS di masa depan.

K. Daftar Pustaka

- Advocates for Youth. (2018). Rights, respect, responsibility: A K-12 sexuality education curriculum. Advocates for Youth.
- Bearinger, L. H., Sieving, R. E., Ferguson, J., & Sharma, V. (2007). Global perspectives on the sexual and reproductive health of adolescents: Patterns, prevention, and potential. *The Lancet*, 369(9568), 1220–1231. <https://doi.org/10.1016/S0140->

- Centers for Disease Control and Prevention. (2023). Sexually transmitted infections in adolescents and young adults. CDC. <https://www.cdc.gov/std/statistics/adolescents.htm>
- Fonner, V. A., Armstrong, K. S., Kennedy, C. E., O'Reilly, K. R., & Sweat, M. D. (2014). School-based sex education and HIV prevention in low- and middle-income countries: A systematic review and meta-analysis. *PLoS ONE*, 9(3), e89692. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0089692>
- Kirby, D. (2007). *Emerging answers 2007: Research findings on programs to reduce teen pregnancy and sexually transmitted diseases*. National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy.
- Santelli, J. S., Kantor, L. M., Grilo, S. A., Speizer, I. S., Lindberg, L. D., Heitel, J., ... Ott, M. A. (2017). Abstinence-only-until-marriage: An updated review of U.S. policies and programs and their impact. *Journal of Adolescent Health*, 61(3), 273–280. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2017.05.031>
- World Health Organization. (2018). WHO recommendations on adolescent sexual and reproductive health and rights. Author. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241514606>
- World Health Organization. (2021). *Adolescents: Health risks and solutions*. In WHO World Health Statistics 2021. World Health Organization. <https://www.who.int/data/gho/publications/world-health-statistics>

L. Glosarium

Abstinensi

Pilihan untuk tidak melakukan hubungan seksual dengan tujuan mencegah kehamilan maupun IMS.

Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)

Tahap lanjutan infeksi HIV yang menyebabkan penurunan drastis fungsi sistem kekebalan tubuh.

Edukasi Seksual Komprehensif

Pendidikan yang mencakup aspek biologis, emosional, sosial, dan etika terkait seksualitas, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku seksual yang bertanggung jawab.

Gonore

Penyakit IMS yang disebabkan oleh bakteri *Neisseria gonorrhoeae*, ditandai oleh keluarnya cairan abnormal dari alat kelamin dan nyeri saat buang air kecil.

Herpes Genital

IMS yang disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 (HSV-2), menyebabkan lepuhan atau luka nyeri pada area genital, anus, atau sekitarnya.

Human Immunodeficiency Virus (HIV)

Virus yang menyerang dan melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia, berpotensi berkembang menjadi AIDS.

Human Papillomavirus (HPV)

Virus penyebab IMS yang bisa menyebabkan kutil kelamin dan kanker serviks serta kanker lainnya pada organ genital dan tenggorokan.

Infeksi Menular Seksual (IMS)

Infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, atau jamur, yang ditularkan melalui hubungan seksual tanpa perlindungan atau kontak dengan cairan tubuh orang terinfeksi.

Klamidia

IMS yang disebabkan oleh bakteri *Chlamydia trachomatis*, sering tanpa gejala awal, namun dapat menyebabkan komplikasi serius seperti penyakit radang panggul.

Kondo

Alat kontrasepsi berbentuk selubung yang terbuat dari lateks atau bahan lain, digunakan untuk mencegah kehamilan dan penularan IMS.

Penyakit Radang Panggul (Pelvic Inflammatory Disease - PID)

Komplikasi serius dari IMS, berupa radang pada organ reproduksi perempuan yang dapat menyebabkan infertilitas atau kehamilan ektopik.

Prevalensi

Jumlah atau proporsi kasus penyakit tertentu dalam populasi pada periode waktu tertentu.

Silent Infection

Infeksi yang tidak menunjukkan gejala jelas pada tahap awal, sehingga penderitanya tidak menyadari bahwa dirinya terinfeksi.

Sifilis

IMS yang disebabkan oleh bakteri *Treponema pallidum*, memiliki beberapa tahap yang bisa berkembang menjadi komplikasi serius bila tidak ditangani.

Stigma Sosial

andangan negatif atau diskriminatif yang melekat pada individu atau kelompok tertentu karena kondisi atau karakteristik tertentu, termasuk IMS.

Tes Serologi

Pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi antibodi dalam darah yang menunjukkan adanya infeksi tertentu, misalnya sifilis atau HIV.

Trikomoniasis

IMS yang disebabkan oleh parasit *Trichomonas vaginalis*, biasanya menyebabkan keputihan abnormal, gatal, dan nyeri pada area genital.

Vaksin HPV

Vaksin untuk mencegah infeksi oleh Human Papillomavirus (HPV), bertujuan menurunkan risiko kanker serviks dan kutil kelamin.

Virus Hepatitis B dan C

Virus yang dapat menular secara seksual, menyebabkan radang hati kronis yang berpotensi menjadi penyakit hati berat.

Vulnerabilitas Remaja

Kondisi remaja yang lebih rentan terhadap risiko kesehatan seksual, akibat kurangnya informasi, tekanan sosial, dan ketidakmatangan dalam mengambil keputusan seksual.

CHAPTER 4

MENSTRUASI DAN PERMASALAHAN TERKAIT PADA REMAJA

Bd. Nur Hidayah Afnas, S.ST, M.Biomed

A. Pendahuluan/Prolog

1. Pengertian menstruasi pada remaja

Menstruasi merupakan suatu proses biologis alami yang menandai kemampuan reproduksi seorang perempuan. Pada remaja, menstruasi biasanya dimulai ketika terjadi menarke, yaitu menstruasi pertama yang muncul sebagai hasil dari kematangan sistem reproduksi. Secara fisiologis, menstruasi merupakan hasil dari perubahan siklus hormonal yang melibatkan interaksi kompleks antara otak, kelenjar hipofisis, dan ovarium. Pada fase remaja, proses ini terjadi dalam konteks tubuh yang sedang berkembang pesat, baik secara fisik maupun hormonal. Menstruasi pada remaja tidak selalu langsung teratur; sering kali siklusnya masih anovulasi atau tidak disertai pelepasan sel telur karena poros hormon belum stabil sepenuhnya. Oleh karena itu, remaja dapat mengalami variasi siklus, baik dalam hal panjang, volume darah, maupun gejala yang menyertainya. Hal ini dianggap normal pada fase awal perkembangan, meskipun bisa menimbulkan kekhawatiran bila kurang dipahami.

2. Pentingnya memahami masalah menstruasi di usia remaja

Pemahaman mengenai menstruasi di usia remaja menjadi sangat penting karena fase ini merupakan masa transisi menuju kedewasaan reproduksi. Pada masa ini, remaja kerap menghadapi tantangan besar dalam menerima perubahan tubuh sekaligus penyesuaian psikologis yang menyertainya. Jika remaja tidak mendapatkan informasi yang benar, mereka rentan mempercayai mitos atau informasi keliru yang diperoleh dari teman sebaya atau media sosial. Hal tersebut dapat berakibat pada sikap negatif terhadap menstruasi, bahkan memunculkan rasa malu, takut, atau cemas yang berlebihan. Selain itu, minimnya pemahaman dapat membuat remaja kesulitan membedakan antara kondisi menstruasi yang normal dengan masalah yang memerlukan perhatian medis, seperti perdarahan berlebihan, nyeri yang ekstrem, atau gangguan siklus. Dengan demikian, pendidikan tentang menstruasi tidak hanya berfungsi memberikan pengetahuan

biologis, tetapi juga membekali remaja dengan keterampilan hidup, seperti menjaga kebersihan diri, mengelola nyeri, dan memahami kapan harus mencari pertolongan tenaga kesehatan.

3. Dampak kesehatan reproduksi dan kualitas hidup

Masalah menstruasi yang tidak dipahami atau tidak tertangani dengan baik dapat berdampak luas pada kesehatan reproduksi dan kualitas hidup remaja. Dari sisi kesehatan fisik, remaja yang mengalami perdarahan berlebih berisiko menderita anemia yang memengaruhi konsentrasi belajar dan daya tahan tubuh. Nyeri haid yang berat atau dismenore dapat menyebabkan ketidakhadiran di sekolah, menurunkan prestasi akademik, dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Dari aspek psikologis, stigma dan rasa malu yang terkait dengan menstruasi sering membuat remaja menarik diri dari lingkungan sosial, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Sementara dari perspektif jangka panjang, gangguan menstruasi yang berulang dan tidak mendapat perhatian medis bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan reproduksi yang lebih serius, misalnya sindrom ovarium polikistik atau gangguan hormonal lainnya.

Dengan memahami menstruasi dan permasalahannya secara komprehensif, remaja dapat mengelola kesehatannya dengan lebih baik. Mereka akan lebih siap menjaga kebersihan, mengatur pola makan dan aktivitas fisik, serta mampu mengenali tanda bahaya yang memerlukan perhatian medis. Pada akhirnya, pemahaman yang baik tentang menstruasi berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup remaja, baik dalam hal kesehatan, pendidikan, maupun hubungan sosialnya.

B. Fisiologi Menstruasi pada Remaja

1. Anatomi dan fisiologi organ reproduksi perempuan

Organ reproduksi perempuan terdiri dari struktur internal dan eksternal yang memiliki peran penting dalam proses menstruasi. Organ internal meliputi ovarium, tuba falopi, uterus, dan vagina. Ovarium berfungsi sebagai tempat pematangan sel telur sekaligus penghasil hormon estrogen dan progesteron. Tuba falopi merupakan saluran penghubung antara ovarium dan uterus yang menjadi tempat terjadinya pembuahan. Uterus atau rahim adalah organ berbentuk pir yang dinding dalamnya dilapisi oleh endometrium, jaringan yang mengalami penebalan setiap siklus untuk mempersiapkan kemungkinan kehamilan. Bila tidak terjadi pembuahan, lapisan endometrium ini akan luruh dan keluar melalui vagina sebagai darah menstruasi. Organ eksternal terdiri dari vulva yang melindungi organ dalam serta berfungsi dalam hubungan seksual. Pada masa remaja, organ-organ ini masih berada dalam tahap pematangan, sehingga

fungsi reproduksi secara penuh belum sepenuhnya stabil. Hal ini menjelaskan mengapa remaja sering mengalami variasi pola menstruasi di awal-awal menarke.

2. Regulasi hormonal (hipotalamus–hipofisis–ovarium–endometrium)

Proses menstruasi diatur oleh interaksi yang sangat kompleks antara otak dan organ reproduksi melalui sumbu hipotalamus–hipofisis–ovarium. Hipotalamus, yang berada di otak, melepaskan hormon gonadotropin-releasing hormone (GnRH) secara pulsatif. GnRH ini menstimulasi kelenjar hipofisis anterior untuk menghasilkan dua hormon utama, yaitu follicle-stimulating hormone (FSH) dan luteinizing hormone (LH). FSH berperan dalam merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel di ovarium, sedangkan LH memicu proses ovulasi, yaitu pelepasan sel telur dari folikel yang matang. Folikel yang berkembang di ovarium menghasilkan hormon estrogen, yang berperan menebalkan lapisan endometrium. Setelah ovulasi, folikel berubah menjadi korpus luteum yang menghasilkan progesteron untuk mempertahankan endometrium agar siap menerima implantasi bila terjadi pembuahan. Bila tidak ada pembuahan, korpus luteum akan mengalami degenerasi, kadar progesteron menurun drastis, dan akhirnya lapisan endometrium luruh menjadi darah menstruasi. Interaksi berjenjang ini menciptakan siklus yang teratur, meski pada remaja sering terjadi ketidakseimbangan akibat belum stabilnya ritme pelepasan GnRH.

3. Siklus menstruasi normal dan variasinya pada masa remaja

Siklus menstruasi normal biasanya berlangsung sekitar 21 hingga 35 hari dengan lama perdarahan 3 sampai 7 hari. Pada fase awal setelah menarke, siklus menstruasi remaja sering kali belum teratur. Hal ini disebabkan oleh sistem hormonal yang masih beradaptasi, sehingga ovulasi tidak selalu terjadi. Akibatnya, remaja bisa mengalami siklus yang lebih panjang (oligomenore), lebih pendek (polimenore), atau bahkan mengalami amenore sementara. Selain itu, volume darah juga bervariasi, dari perdarahan ringan hingga lebih banyak dari normal. Beberapa remaja mungkin mengalami dismenore, yaitu nyeri perut bagian bawah saat menstruasi, yang disebabkan oleh kontraksi rahim akibat pelepasan prostaglandin. Variasi ini pada umumnya masih dianggap fisiologis selama tidak disertai dengan gejala berat yang mengganggu aktivitas sehari-hari atau tanda-tanda penyakit ginekologi. Seiring bertambahnya usia dan kematangan sistem hormonal, siklus menstruasi remaja cenderung menjadi lebih teratur.

Dengan memahami anatomi, regulasi hormonal, dan pola siklus menstruasi pada remaja, tenaga kesehatan maupun orang tua dapat memberikan edukasi yang tepat sehingga remaja mampu mengenali mana kondisi yang normal dan mana yang perlu perhatian medis. Pengetahuan ini penting agar remaja tidak hanya

memahami menstruasi sebagai proses biologis, tetapi juga sebagai bagian integral dari kesehatan reproduksi yang memengaruhi kualitas hidup mereka di masa depan.

C. Karakteristik Menstruasi pada Remaja

1. Pola menstruasi awal (menarke)

Menarke merupakan peristiwa menstruasi pertama yang dialami oleh seorang remaja perempuan, biasanya terjadi pada rentang usia 10 hingga 16 tahun, dengan rata-rata usia sekitar 12–13 tahun. Menarke menjadi salah satu tanda pubertas yang penting, menandai bahwa sistem reproduksi telah mulai berfungsi meskipun belum sepenuhnya matang. Pada fase awal ini, siklus menstruasi cenderung belum teratur karena sistem hormonal hipotalamus–hipofisis–ovarium masih dalam tahap penyesuaian. Beberapa remaja dapat mengalami menstruasi yang datang lebih awal (pubertas dini), sementara yang lain mungkin lebih lambat dari rata-rata, dan hal ini masih dianggap dalam batas fisiologis. Menarke sering kali disertai dengan pengalaman emosional yang beragam; sebagian remaja merasa antusias karena memasuki tahap baru kehidupan, namun tidak sedikit yang merasa cemas atau takut, terutama bila sebelumnya kurang mendapatkan informasi yang memadai tentang proses biologis ini.

2. Variasi panjang siklus dan lama haid

Setelah menarke, pola menstruasi remaja umumnya masih fluktuatif, baik dari segi panjang siklus maupun lama perdarahan. Siklus normal orang dewasa berkisar 21–35 hari, tetapi pada remaja, siklus bisa berlangsung lebih panjang, lebih pendek, atau bahkan tidak konsisten. Hal ini disebabkan oleh seringnya siklus anovulasi, yaitu siklus tanpa pelepasan sel telur. Durasi perdarahan biasanya berkisar antara 3 hingga 7 hari, tetapi pada remaja dapat lebih singkat atau lebih lama. Variasi lain yang kerap terjadi adalah jumlah darah menstruasi, mulai dari sangat sedikit hingga perdarahan yang relatif lebih banyak dari normal. Kondisi seperti ini sering menimbulkan kekhawatiran pada remaja maupun orang tua, meski umumnya masih dalam batas wajar selama tidak menimbulkan gejala berat seperti anemia. Dengan bertambahnya usia dan semakin matangnya sistem reproduksi, siklus menstruasi remaja biasanya akan lebih teratur, mendekati pola normal orang dewasa.

3. Perubahan hormon dan pengaruh psikologis

Perubahan hormon yang terjadi selama siklus menstruasi berpengaruh besar tidak hanya pada tubuh, tetapi juga pada kondisi emosional remaja. Fluktuasi estrogen dan progesteron dapat menimbulkan gejala fisik seperti nyeri perut bawah, payudara terasa tegang, sakit kepala, serta kelelahan. Selain itu,

perubahan hormonal ini dapat memengaruhi kestabilan emosi, sehingga sebagian remaja mengalami mudah marah, sedih, cemas, atau gejala yang dikenal sebagai sindrom pramenstruasi (PMS). Pada sebagian kecil remaja, gejala dapat lebih berat hingga mengganggu aktivitas sekolah maupun interaksi sosial. Perubahan psikologis ini sering diperburuk oleh kurangnya pemahaman, adanya stigma negatif tentang menstruasi, dan rasa malu untuk berdiskusi terbuka. Dukungan keluarga, khususnya orang tua, serta edukasi kesehatan reproduksi di sekolah sangat penting agar remaja tidak merasa sendirian dalam menghadapi perubahan tersebut.

D. Permasalahan Menstruasi pada Remaja

1. Gangguan Siklus Menstruasi

Salah satu masalah yang paling sering ditemui pada remaja adalah gangguan dalam siklus menstruasi. Kondisi ini muncul karena sistem hormonal yang mengatur siklus menstruasi belum sepenuhnya stabil pada masa pubertas. Oligomenore adalah keadaan ketika siklus menstruasi berlangsung lebih panjang dari normal, biasanya lebih dari 35 hari. Pada remaja, hal ini sering terjadi karena siklus anovulasi yang masih umum pada beberapa tahun awal setelah menarke. Polimenore, sebaliknya, terjadi ketika siklus datang terlalu pendek, kurang dari 21 hari, sehingga perdarahan menjadi lebih sering dari biasanya. Kondisi ini bisa menimbulkan rasa khawatir, meski sebagian besar masih bersifat fisiologis pada usia remaja. Adapun amenore dibedakan menjadi primer dan sekunder. Amenore primer adalah kondisi ketika seorang remaja belum pernah mengalami menstruasi hingga usia 15–16 tahun, meskipun tanda-tanda pubertas lain sudah muncul. Sementara amenore sekunder adalah ketika menstruasi yang sebelumnya sudah teratur tiba-tiba berhenti selama lebih dari tiga bulan berturut-turut. Keduanya memerlukan evaluasi medis karena bisa menandakan adanya gangguan hormonal, kelainan anatomis, atau masalah kesehatan serius lainnya.

2. Gangguan Kuantitas dan Durasi

Selain gangguan siklus, remaja juga bisa mengalami masalah terkait jumlah darah menstruasi dan lamanya perdarahan. Menoragia adalah perdarahan haid yang lebih banyak atau lebih lama dari normal, sering kali disertai gumpalan darah besar yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Kondisi ini dapat menyebabkan anemia, kelelahan, dan penurunan konsentrasi belajar. Metroragia adalah perdarahan yang terjadi di luar siklus menstruasi, tidak teratur, dan muncul di antara dua menstruasi. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon, penggunaan kontrasepsi tertentu, atau adanya kelainan pada rahim.

Sementara itu, hipomenore adalah menstruasi dengan jumlah darah yang sedikit, kadang hanya berupa bercak selama beberapa hari. Walaupun pada remaja hipomenore sering kali tidak berbahaya, namun bila berulang dapat mengindikasikan adanya gangguan hormonal atau kelainan endometrium.

3. Gangguan Nyeri Menstruasi

Nyeri saat menstruasi atau dismenore merupakan keluhan paling umum yang dialami remaja. Dismenore primer biasanya mulai muncul beberapa tahun setelah menarke, ditandai dengan nyeri perut bagian bawah akibat kontraksi rahim yang dipicu oleh peningkatan prostaglandin. Kondisi ini umumnya tidak berkaitan dengan kelainan anatomi dan cenderung membaik seiring bertambahnya usia. Sebaliknya, dismenore sekunder biasanya disebabkan oleh adanya masalah organik pada sistem reproduksi, seperti endometriosis atau kelainan bawaan rahim. Nyeri pada dismenore sekunder cenderung lebih berat, lebih lama, dan tidak merespons baik terhadap terapi sederhana seperti obat pereda nyeri atau kompres hangat. Kedua bentuk dismenore ini dapat memengaruhi aktivitas sehari-hari, menyebabkan absensi sekolah, serta menurunkan kualitas hidup remaja.

4. Masalah Lain Terkait Menstruasi

Selain gangguan siklus, kuantitas, dan nyeri, terdapat pula masalah lain yang erat kaitannya dengan menstruasi pada remaja. Sindrom pramenstruasi (PMS) adalah kumpulan gejala fisik dan emosional yang muncul beberapa hari sebelum menstruasi, seperti mudah marah, cemas, nyeri payudara, sakit kepala, dan perubahan nafsu makan. PMS bisa mengganggu konsentrasi belajar maupun interaksi sosial, meskipun umumnya gejalanya akan mereda setelah menstruasi dimulai. Pada sebagian kecil remaja, gejala pramenstruasi dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih berat, yaitu Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD). PMDD ditandai dengan gejala emosional yang parah seperti depresi, iritabilitas ekstrem, dan perubahan suasana hati yang signifikan, sehingga berdampak pada fungsi sehari-hari dan membutuhkan perhatian medis lebih lanjut. Selain itu, terdapat pula masalah infeksi saluran reproduksi yang kadang menimbulkan gejala mirip dengan gangguan menstruasi, misalnya perdarahan tidak normal, nyeri perut, atau keputihan berbau. Infeksi ini dapat memperburuk kondisi menstruasi dan bila tidak ditangani dapat memengaruhi kesehatan reproduksi jangka panjang.

E. Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Menstruasi pada Remaja

1. Faktor biologis (hormonal, gizi, pubertas dini/tertunda)

Faktor biologis memiliki peran besar dalam menentukan pola dan masalah menstruasi pada remaja. Perubahan hormonal yang terjadi pada masa pubertas sering kali belum stabil sehingga dapat menyebabkan siklus anovulasi, keterlambatan datang bulan, atau perdarahan yang tidak teratur. Ketidakseimbangan hormon estrogen dan progesteron dapat memicu gangguan seperti oligomenore, polimenore, bahkan amenore. Selain itu, status gizi juga berpengaruh signifikan. Remaja dengan gizi kurang, misalnya karena pola makan yang tidak seimbang atau gangguan makan, cenderung mengalami menstruasi yang tidak teratur akibat lemak tubuh yang tidak mencukupi untuk produksi hormon reproduksi. Sebaliknya, obesitas juga bisa menimbulkan gangguan hormonal yang mengarah pada menstruasi tidak teratur, bahkan risiko sindrom ovarium polikistik (PCOS). Faktor pubertas dini atau tertunda juga berhubungan erat dengan pola menstruasi; remaja dengan pubertas dini mungkin menghadapi menstruasi lebih awal dengan gejala fisik yang belum siap secara psikologis, sedangkan pubertas tertunda dapat menimbulkan kekhawatiran karena keterlambatan menarke yang dianggap tidak normal.

2. Faktor psikologis (stres, kecemasan, depresi)

Kesehatan mental memiliki dampak langsung terhadap siklus menstruasi remaja. Stres, kecemasan, maupun depresi dapat memengaruhi pelepasan hormon di otak, khususnya hormon gonadotropin-releasing hormone (GnRH) yang berperan mengatur siklus menstruasi. Ketegangan emosional yang terus-menerus dapat menghambat ovulasi, menyebabkan keterlambatan haid atau bahkan amenore sekunder. Selain itu, remaja yang mengalami tekanan psikologis sering melaporkan keluhan dismenore lebih berat, rasa tidak nyaman menjelang menstruasi, dan gejala sindrom pramenstruasi yang lebih intens. Hubungan antara hormon dan psikologis bersifat timbal balik; fluktuasi hormonal dapat memengaruhi emosi, sementara kondisi psikologis juga bisa memperburuk atau memperringan gejala menstruasi. Dukungan keluarga, teman sebaya, dan akses pada konseling psikologis berperan penting dalam membantu remaja mengelola stres agar tidak memperburuk gangguan menstruasi.

3. Faktor sosial dan budaya (mitos menstruasi, pantangan, stigma)

Lingkungan sosial dan budaya sangat menentukan cara remaja memaknai menstruasi. Di banyak komunitas, menstruasi masih dikelilingi oleh mitos, pantangan, dan stigma. Misalnya, sebagian masyarakat percaya bahwa perempuan haid tidak boleh melakukan aktivitas tertentu, makan makanan tertentu, atau dilarang mengikuti kegiatan ibadah. Pantangan semacam ini dapat

menimbulkan rasa malu, isolasi, dan bahkan menghalangi remaja untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah atau sosial. Stigma bahwa menstruasi adalah sesuatu yang “kotor” membuat sebagian remaja enggan membicarakan keluhan menstruasinya, sehingga keterlambatan diagnosis masalah serius menjadi lebih mungkin. Budaya yang menganggap pembicaraan mengenai kesehatan reproduksi tabu juga memperburuk kesenjangan informasi, membuat remaja mencari jawaban dari sumber yang tidak kredibel. Dengan demikian, aspek sosial-budaya dapat memengaruhi tidak hanya sikap remaja terhadap menstruasi, tetapi juga akses mereka terhadap informasi dan layanan kesehatan yang tepat.

4. Faktor gaya hidup (aktivitas fisik, pola makan, penggunaan zat adiktif)

Selain faktor biologis, psikologis, dan budaya, gaya hidup juga berkontribusi pada permasalahan menstruasi. Aktivitas fisik yang terlalu berat, seperti olahraga intensif tanpa keseimbangan nutrisi, dapat menekan produksi hormon reproduksi dan menyebabkan amenore fungsional. Sebaliknya, kurang aktivitas fisik berhubungan dengan obesitas yang dapat memperparah ketidakseimbangan hormonal. Pola makan yang tidak sehat, misalnya terlalu banyak konsumsi makanan cepat saji, kurang serat, dan rendah zat gizi mikro seperti zat besi, kalsium, atau vitamin D, dapat memperburuk keluhan menstruasi seperti dismenore dan kelelahan. Penggunaan zat adiktif, seperti rokok, alkohol, atau narkoba, juga berhubungan dengan ketidakteraturan siklus menstruasi serta peningkatan risiko infeksi pada saluran reproduksi. Gaya hidup sehat dengan olahraga teratur, pola makan seimbang, tidur cukup, dan menjauhi zat adiktif terbukti membantu menjaga keseimbangan hormonal dan memperbaiki kualitas menstruasi remaja.

F. Dampak Permasalahan Menstruasi pada Remaja

1. Dampak kesehatan fisik

Permasalahan menstruasi pada remaja dapat menimbulkan gangguan nyata terhadap kondisi fisik mereka. Misalnya, perdarahan yang terlalu banyak atau berlangsung lama (menoragia) dapat menyebabkan anemia defisiensi besi. Kondisi ini membuat remaja merasa lemas, mudah lelah, pusing, dan sulit berkonsentrasi. Anemia yang tidak ditangani juga meningkatkan kerentanan terhadap penyakit infeksi dan menurunkan daya tahan tubuh secara keseluruhan. Nyeri menstruasi (dismenore), baik primer maupun sekunder, kerap menjadi penyebab utama ketidaknyamanan fisik. Rasa nyeri yang intens di perut bagian bawah, pinggang, bahkan menjalar hingga paha sering kali membuat remaja tidak mampu melakukan aktivitas normal. Pada sebagian remaja, gejala

menstruasi juga dapat disertai sakit kepala, mual, muntah, hingga diare. Akumulasi gangguan ini berpotensi menurunkan kualitas hidup remaja bila tidak ditangani dengan tepat.

2. Dampak psikologis dan emosional

Gangguan menstruasi juga berimplikasi serius terhadap kondisi psikologis remaja. Perubahan hormonal yang tidak seimbang dapat memengaruhi kestabilan emosi, sehingga remaja lebih rentan mengalami kecemasan, mudah tersinggung, atau mengalami depresi ringan. Kondisi seperti sindrom pramenstruasi (PMS) atau bahkan Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD) dapat memperburuk suasana hati, menimbulkan rasa sedih mendalam, hingga memengaruhi hubungan dengan teman sebaya maupun keluarga. Selain itu, stigma sosial yang masih melekat pada menstruasi sering kali membuat remaja merasa malu atau terisolasi. Perasaan tertekan ini diperkuat jika mereka tidak memiliki dukungan emosional yang memadai, baik dari orang tua maupun lingkungan sekolah. Pada remaja dengan masalah menstruasi kronis, tekanan psikologis dapat berkembang menjadi gangguan harga diri, penurunan motivasi, bahkan pikiran untuk menghindar dari lingkungan sosial.

3. Dampak akademik dan sosial (absensi sekolah, isolasi sosial)

Permasalahan menstruasi kerap berdampak langsung terhadap kehadiran dan prestasi akademik remaja. Nyeri menstruasi yang berat menjadi alasan utama ketidakhadiran di sekolah, menyebabkan remaja kehilangan jam pelajaran penting. Anemia akibat perdarahan berlebihan juga menurunkan kemampuan konsentrasi dan daya ingat, sehingga memengaruhi capaian belajar. Dari sisi sosial, menstruasi sering disertai dengan stigma dan pantangan budaya yang membatasi aktivitas remaja perempuan. Ada remaja yang enggan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, olahraga, atau aktivitas kelompok karena merasa tidak nyaman, malu, atau takut diejek. Akibatnya, mereka lebih sering menarik diri dari interaksi sosial. Isolasi sosial semacam ini bisa menghambat perkembangan keterampilan sosial, membatasi kesempatan membangun jaringan pertemanan, dan memperburuk rasa rendah diri.

4. Dampak jangka panjang terhadap kesehatan reproduksi

Gangguan menstruasi yang tidak tertangani sejak remaja berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan reproduksi. Amenore yang berlarut-larut, misalnya, bisa menjadi tanda adanya kelainan hormonal atau sindrom ovarium polikistik (PCOS) yang berimplikasi pada kesuburan di masa dewasa. Perdarahan menstruasi yang tidak normal dapat menjadi gejala awal adanya kelainan endometrium atau gangguan anatomi rahim yang bila tidak didiagnosis akan menimbulkan masalah reproduksi jangka panjang. Infeksi

saluran reproduksi yang tidak dikenali dapat menyebabkan kerusakan organ reproduksi dan meningkatkan risiko infertilitas. Selain itu, pengalaman menstruasi yang penuh stigma dan rasa malu sejak remaja bisa memengaruhi sikap terhadap tubuh sendiri, kehidupan seksual, serta hubungan pasangan ketika dewasa. Oleh karena itu, penanganan dini masalah menstruasi sangat penting tidak hanya untuk menjaga kesehatan jangka pendek, tetapi juga untuk memastikan kesehatan reproduksi dan kualitas hidup yang optimal di masa depan.

G. Upaya Penanganan dan Pencegahan

1. Edukasi kesehatan reproduksi di sekolah dan keluarga

Edukasi kesehatan reproduksi merupakan langkah pertama dan paling fundamental dalam mencegah serta menangani permasalahan menstruasi pada remaja. Di sekolah, pendidikan kesehatan reproduksi sebaiknya diberikan secara komprehensif, bukan hanya menekankan aspek biologis, tetapi juga mencakup pemahaman tentang kebersihan menstruasi, pentingnya menjaga kesehatan mental, serta keterampilan menghadapi perubahan fisik dan emosional. Materi yang diberikan harus sesuai dengan usia, menggunakan bahasa yang sederhana, dan disampaikan dalam suasana yang aman tanpa stigma. Guru dan konselor sekolah dapat menjadi fasilitator yang membantu remaja memahami bahwa menstruasi adalah proses alami, bukan sesuatu yang memalukan. Di tingkat keluarga, peran orang tua tidak kalah penting. Remaja yang dapat berdialog terbuka dengan orang tua, khususnya ibu atau ayah, akan lebih percaya diri dalam menghadapi menstruasi. Komunikasi keluarga yang hangat membantu remaja memahami perbedaan antara menstruasi normal dan kondisi yang membutuhkan perhatian medis.

2. Konseling dan pendekatan psikologis

Selain edukasi, konseling juga merupakan strategi penting untuk membantu remaja mengatasi beban emosional yang sering menyertai menstruasi. Konseling dapat dilakukan secara individual maupun kelompok, dengan tujuan memberikan ruang aman bagi remaja untuk mengekspresikan kekhawatiran, rasa sakit, atau perasaan tertekan yang dialami. Tenaga konselor atau psikolog yang berpengalaman dapat menggunakan pendekatan berperspektif trauma agar remaja yang pernah mengalami kekerasan atau stigma tidak merasa dihakimi. Dukungan psikologis ini sangat penting dalam mengurangi kecemasan, depresi, maupun gejala Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD) yang sering dialami sebagian remaja. Dengan konseling, remaja tidak hanya diberikan informasi, tetapi juga keterampilan regulasi emosi, manajemen stres, serta teknik relaksasi untuk menghadapi nyeri dan perubahan mood yang menyertai siklus menstruasi.

3. Terapi farmakologis (analgesik, terapi hormonal)

Dalam kasus di mana nyeri menstruasi atau perdarahan berlebih mengganggu aktivitas sehari-hari, terapi farmakologis dapat menjadi pilihan. Obat pereda nyeri seperti analgesik golongan non-steroid (misalnya ibuprofen) terbukti efektif mengurangi nyeri dismenore dengan cara menghambat produksi prostaglandin yang memicu kontraksi rahim. Pada kasus perdarahan hebat atau gangguan siklus tertentu, dokter mungkin akan meresepkan terapi hormonal berupa pil kontrasepsi kombinasi atau progesteron untuk menyeimbangkan hormon. Terapi hormonal membantu mengatur siklus menstruasi, mengurangi volume darah, serta menstabilkan gejala PMS. Namun, penggunaan obat-obatan ini harus berada di bawah pengawasan tenaga medis agar tidak menimbulkan efek samping yang merugikan dan tetap sesuai dengan kebutuhan individu.

4. Terapi nonfarmakologis (nutrisi, olahraga, manajemen stres)

Upaya nonfarmakologis juga memiliki peran penting dalam penanganan permasalahan menstruasi. Asupan nutrisi yang seimbang, khususnya makanan kaya zat besi, kalsium, vitamin B, dan magnesium, dapat membantu mengurangi gejala anemia, nyeri haid, serta memperbaiki suasana hati. Olahraga teratur seperti yoga, senam ringan, atau berjalan kaki terbukti efektif menurunkan intensitas dismenore dengan meningkatkan sirkulasi darah dan merangsang produksi endorfin sebagai penghilang rasa sakit alami. Manajemen stres melalui meditasi, teknik pernapasan dalam, atau kegiatan kreatif juga dapat membantu menurunkan ketegangan emosional yang memperburuk keluhan menstruasi. Pendekatan ini relatif mudah dilakukan, aman, dan dapat menjadi rutinitas jangka panjang bagi remaja untuk menjaga kesehatan reproduksi sekaligus kesehatan umum mereka.

5. Layanan kesehatan ramah remaja

Upaya penanganan dan pencegahan permasalahan menstruasi tidak akan berjalan efektif tanpa adanya dukungan layanan kesehatan yang ramah remaja. Layanan semacam ini harus menjamin kerahasiaan, keterjangkauan, serta bebas dari diskriminasi. Puskesmas, klinik remaja, dan posyandu remaja dapat menjadi pusat layanan yang menyediakan konseling, pemeriksaan medis, hingga pemberian terapi sesuai kebutuhan. Petugas kesehatan yang terlatih dalam komunikasi dengan remaja akan mampu menciptakan suasana yang nyaman sehingga remaja tidak segan berkonsultasi mengenai masalah menstruasi yang dialami. Selain itu, layanan kesehatan ramah remaja harus terintegrasi dengan sekolah dan komunitas, misalnya melalui kegiatan penyuluhan, pemeriksaan kesehatan rutin, serta pembentukan kelompok sebaya yang mendukung. Dengan

dukungan ekosistem yang solid, remaja dapat merasa didengar, dihargai, dan dibimbing untuk menjaga kesehatan reproduksi secara mandiri.

H. Peran Orang Tua, Sekolah, dan Tenaga Kesehatan

1. Komunikasi orang tua–remaja

Orang tua memegang peran fundamental dalam membantu remaja memahami dan mengelola menstruasi. Komunikasi yang hangat, terbuka, dan tidak menghakimi menjadi landasan agar remaja merasa aman untuk bertanya dan berbagi pengalaman. Banyak remaja mengalami kebingungan, rasa malu, atau bahkan ketakutan saat pertama kali mengalami menstruasi, terutama bila tidak ada persiapan sebelumnya. Dalam kondisi ini, orang tua, khususnya ibu, sering menjadi sumber informasi utama. Namun, keterlibatan ayah juga tidak kalah penting, karena hal ini dapat memperkuat rasa percaya diri anak perempuan dan mengurangi stigma bahwa menstruasi adalah “urusan perempuan semata.” Dengan komunikasi yang teratur, orang tua dapat memberikan pemahaman bahwa menstruasi adalah proses fisiologis alami, membantu membedakan mana kondisi yang normal dan mana yang perlu perhatian medis, serta mengajarkan keterampilan praktis seperti menjaga kebersihan diri dan mengelola nyeri. Di sisi lain, dukungan emosional orang tua akan mencegah remaja merasa terisolasi atau tertekan akibat stigma sosial seputar menstruasi.

2. Program UKS/M (Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah)

Sekolah merupakan lingkungan kedua setelah keluarga yang memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan pendampingan mengenai menstruasi. Melalui program UKS/M, sekolah dapat menciptakan ekosistem yang mendukung kesehatan reproduksi remaja. UKS/M bukan hanya berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar, tetapi juga menyediakan pendidikan kesehatan yang sistematis, termasuk informasi tentang menstruasi, kebersihan menstruasi, dan keterampilan hidup terkait kesehatan reproduksi. Dengan adanya kolaborasi lintas sektor—antara dinas pendidikan, kesehatan, dan keagamaan—UKS/M dapat menjalankan kegiatan preventif dan promotif, seperti penyuluhan, konseling kelompok, dan pelatihan kader kesehatan remaja. Selain itu, program ini juga berperan sebagai jembatan antara sekolah dan puskesmas, sehingga remaja yang mengalami masalah menstruasi serius dapat segera dirujuk ke layanan kesehatan yang lebih lengkap. Fasilitas seperti ruang UKS yang ramah remaja, ketersediaan pembalut, serta tenaga guru dan konselor yang terlatih akan memperkuat peran sekolah dalam membantu remaja menghadapi permasalahan menstruasi tanpa stigma dan rasa malu.

3. Peran bidan, perawat, dan dokter dalam pelayanan remaja

Tenaga kesehatan menjadi garda terdepan dalam penanganan medis maupun konseling terkait menstruasi pada remaja. Bidan memiliki peran yang sangat dekat dengan masyarakat, terutama di lini pelayanan primer seperti puskesmas dan posyandu remaja. Mereka memberikan edukasi, konseling, dan layanan dasar, termasuk deteksi dini masalah menstruasi, penanganan dismenore, serta penyuluhan tentang kebersihan menstruasi. Perawat berkontribusi dengan pendekatan holistik yang mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial. Mereka mendampingi remaja dalam mengelola nyeri, memberikan dukungan emosional, serta mengajarkan keterampilan perawatan diri sehari-hari. Sementara itu, dokter berperan dalam diagnosis dan penatalaksanaan medis untuk kasus-kasus kompleks, seperti perdarahan abnormal, sindrom ovarium polikistik, atau infeksi reproduksi yang memerlukan terapi lebih lanjut. Kolaborasi antara bidan, perawat, dan dokter memastikan bahwa remaja mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif, mulai dari edukasi preventif hingga terapi kuratif. Ketiganya juga berfungsi sebagai advokat kesehatan reproduksi remaja dengan mendorong layanan yang ramah, menjaga kerahasiaan pasien, dan memastikan akses tanpa diskriminasi.

I. Kebijakan dan Dukungan Lintas Sektor

1. Kebijakan pemerintah tentang kesehatan reproduksi remaja

Pemerintah memiliki peran sentral dalam mengarahkan strategi kesehatan reproduksi remaja melalui kebijakan yang bersifat normatif maupun operasional. Undang-Undang Kesehatan, peraturan pemerintah tentang kesehatan reproduksi, serta regulasi terkait perlindungan anak dan pencegahan kekerasan seksual menegaskan hak remaja untuk memperoleh informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang aman, berkualitas, dan bebas diskriminasi. Kebijakan ini bukan sekadar payung hukum, tetapi juga menjadi dasar alokasi anggaran, penyediaan tenaga kesehatan terlatih, dan penjaminan akses yang merata hingga ke daerah terpencil. Selain itu, revisi Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan bentuk nyata upaya pendewasaan usia perkawinan. Dengan demikian, remaja didorong untuk menunda perkawinan dan kehamilan hingga benar-benar siap secara fisik, psikologis, dan sosial.

2. Program BKKBN, Puskesmas, dan organisasi kepemudaan

Berbagai program lintas sektor telah digerakkan untuk mewujudkan perlindungan dan pendampingan bagi remaja. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjalankan program Generasi Berencana

(GenRe) melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M). Program ini berfokus pada edukasi kesehatan reproduksi, keterampilan hidup, konseling sebaya, dan kampanye penundaan usia perkawinan. Di tingkat layanan kesehatan, Puskesmas melaksanakan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) yang menyediakan konseling, skrining risiko, layanan kontrasepsi ramah remaja, serta rujukan kesehatan mental. Di sisi lain, organisasi kepemudaan seperti karang taruna, OSIS, pramuka, remaja masjid, dan komunitas lokal berperan sebagai ruang sosial yang menguatkan nilai positif, keterampilan hidup, serta menjadi wadah kampanye kreatif seputar kesehatan reproduksi. Sinergi antara BKKBN, puskesmas, dan organisasi pemuda memastikan bahwa remaja tidak hanya mendapat informasi, tetapi juga dukungan nyata di lingkungannya.

3. Integrasi dengan pendidikan formal dan nonformal

Upaya pencegahan permasalahan menstruasi maupun kehamilan remaja akan lebih kuat jika diintegrasikan dengan dunia pendidikan. Pendidikan formal melalui kurikulum sekolah dapat memasukkan materi kesehatan reproduksi yang komprehensif, mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, dan keterampilan hidup. Sekolah juga menjadi ruang strategis bagi program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) yang menghubungkan layanan kesehatan dengan kegiatan belajar mengajar. Sementara itu, pendidikan nonformal seperti posyandu remaja, kelompok belajar, kursus keterampilan, dan program komunitas memberikan alternatif ruang belajar yang lebih fleksibel. Integrasi formal dan nonformal memastikan bahwa edukasi tidak berhenti di kelas, melainkan berlanjut dalam kehidupan sehari-hari remaja. Dengan demikian, remaja memperoleh pengalaman yang konsisten: pesan kesehatan yang sama mereka dengar di sekolah, di komunitas, maupun di rumah.

J. Simpulan

Menstruasi pada remaja merupakan bagian penting dari proses transisi biologis dan psikososial menuju kedewasaan reproduksi. Proses ini ditandai dengan menarke sebagai awal siklus, diikuti oleh berbagai variasi pola menstruasi yang normal terjadi akibat sistem hormonal yang masih dalam tahap pematangan. Pemahaman mengenai anatomi, fisiologi, serta regulasi hormonal sangat diperlukan agar remaja, orang tua, dan tenaga pendidik mampu membedakan kondisi fisiologis dari gangguan yang memerlukan perhatian medis.

Permasalahan menstruasi yang muncul pada remaja, seperti gangguan siklus, perdarahan abnormal, dismenore, PMS, hingga masalah infeksi, tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga memengaruhi aspek psikologis, sosial, akademik, bahkan kualitas hidup jangka panjang. Faktor biologis, psikologis, sosial-

budaya, serta gaya hidup berkontribusi dalam menentukan apakah menstruasi berjalan normal atau disertai permasalahan. Karena itu, pendekatan yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan maupun penanganan.

Upaya untuk mengatasi permasalahan menstruasi pada remaja tidak dapat dilakukan secara parsial. Edukasi kesehatan reproduksi di sekolah dan keluarga harus berjalan seiring dengan konseling, pendekatan psikologis, serta intervensi medis baik farmakologis maupun nonfarmakologis. Layanan kesehatan yang ramah remaja berperan penting dalam menciptakan rasa aman, menjaga kerahasiaan, serta memberikan akses terhadap pemeriksaan dan terapi yang sesuai.

Selain itu, peran orang tua, sekolah, dan tenaga kesehatan sangat menentukan. Komunikasi keluarga yang terbuka mengurangi stigma dan meningkatkan kepercayaan diri remaja. Program UKS/M di sekolah memberikan ruang sistematis untuk edukasi dan rujukan, sementara bidan, perawat, dan dokter berkolaborasi dalam deteksi dini, penanganan kasus, hingga penyuluhan. Dukungan kebijakan publik, program BKKBN, peran puskesmas, serta keterlibatan organisasi kepemudaan semakin memperkuat ekosistem perlindungan remaja. Integrasi dengan pendidikan formal dan nonformal memastikan pesan yang konsisten dan dukungan yang berkelanjutan.

Dengan sinergi lintas sektor, pemahaman yang tepat, serta dukungan keluarga dan komunitas, remaja diharapkan mampu menghadapi menstruasi dengan lebih sehat, percaya diri, dan produktif. Langkah ini bukan hanya meningkatkan kualitas hidup individu remaja, tetapi juga menjadi investasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan berdaya saing di masa depan.

K. Daftar Pustaka

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2020). Pedoman Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). Jakarta: BKKBN.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Pedoman Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR). Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Hillard, P. A., Deitch, H. R., & Rosenfield, R. L. (2019). Menstruation in adolescents: What's normal, what's not. *Pediatrics in Review*, 40(4), 189–201.
- Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2021). *Wong's essentials of pediatric nursing* (11th ed.). St. Louis, MO: Elsevier.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2014). Peraturan Bersama tentang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M). Jakarta: Kemendikbud.

Nelson, H. D., Darney, B. G., & Ahrens, K. (2022). Associations of unintended pregnancy with maternal and infant health outcomes: A systematic review and meta-analysis. *Journal of the American Medical Association*, 328(17), 1714–1729.

Santrock, J. W. (2021). *Adolescence* (17th ed.). New York, NY: McGraw-Hill Education.

World Health Organization. (2018). *WHO recommendations on adolescent sexual and reproductive health and rights*. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization. (2022). *Family planning: A global handbook for providers* (4th ed.). Geneva: WHO & Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

World Health Organization. (2024). *Adolescent pregnancy: Fact sheet*. Geneva: World Health Organization.

L. Glosarium

Amenore

Kondisi tidak terjadinya menstruasi. Dibedakan menjadi amenore primer (remaja belum pernah haid hingga usia ≥ 15 –16 tahun) dan amenore sekunder (menstruasi berhenti ≥ 3 bulan setelah sebelumnya teratur).

Anemia

Kondisi kurang darah, biasanya akibat perdarahan haid berlebih (menoragia), ditandai lemas, pucat, pusing, dan konsentrasi menurun.

Anovulasi

Siklus menstruasi tanpa pelepasan sel telur. Umum terjadi pada remaja karena sistem hormonal belum stabil.

Dismenore

Nyeri haid akibat kontraksi rahim. Dibagi menjadi dismenore primer (tanpa kelainan organ) dan dismenore sekunder (akibat kelainan organ reproduksi, misalnya endometriosis).

Endometrium

Lapisan dalam rahim yang menebal setiap siklus untuk persiapan kehamilan. Bila tidak terjadi pembuahan, lapisan ini luruh menjadi darah menstruasi.

Estrogen

Hormon yang diproduksi ovarium. Berperan menebalkan endometrium dan memengaruhi karakteristik seksual sekunder perempuan.

Follicle-Stimulating Hormone (FSH)

Hormon dari kelenjar hipofisis anterior yang merangsang pertumbuhan folikel di ovarium.

GnRH (Gonadotropin-Releasing Hormone)

Hormon dari hipotalamus yang merangsang hipofisis anterior untuk mengeluarkan FSH dan LH.

Hipomenore

Menstruasi dengan jumlah darah sedikit, sering hanya berupa bercak.

Korpus Luteum

Sisa folikel yang telah melepaskan sel telur. Menghasilkan progesteron untuk mempertahankan endometrium.

Luteinizing Hormone (LH)

Hormon dari hipofisis anterior yang memicu ovulasi (pelepasan sel telur).

Menarke

Menstruasi pertama yang dialami remaja perempuan, biasanya pada usia 10–16 tahun.

Menoragia

Menstruasi dengan perdarahan sangat banyak atau lebih lama dari normal, berisiko menyebabkan anemia.

Metroragia

Perdarahan dari rahim yang terjadi di luar siklus menstruasi normal.

Oligomenore

Menstruasi dengan siklus panjang, lebih dari 35 hari sekali.

Ovarium

Indung telur, organ reproduksi perempuan yang berfungsi memproduksi sel telur, estrogen, dan progesteron.

Polimenore

Menstruasi dengan siklus pendek, kurang dari 21 hari sekali.

Progesteron

Hormon yang dihasilkan korpus luteum. Berfungsi mempertahankan penebalan endometrium agar siap menerima implantasi.

Prostaglandin

Zat kimia tubuh yang merangsang kontraksi rahim. Kadar tinggi dapat menyebabkan nyeri menstruasi (dismenore).

Pubertas

Masa transisi perkembangan fisik dan seksual menuju kematangan reproduksi, ditandai dengan menarke pada perempuan.

Sindrom Premenstruasi (PMS)

Kumpulan gejala fisik dan emosional sebelum haid, misalnya nyeri payudara, mudah marah, cemas, dan sakit kepala.

Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD)

Bentuk lebih berat dari PMS, ditandai depresi, mudah marah ekstrem, dan perubahan mood signifikan yang mengganggu aktivitas sehari-hari.

Siklus Menstruasi

Rangkaian perubahan fisiologis pada sistem reproduksi perempuan yang rata-rata berlangsung 21–35 hari, melibatkan fase folikular, ovulasi, dan luteal.

Stigma Menstruasi

Pandangan negatif dalam masyarakat yang menganggap menstruasi sebagai hal tabu atau kotor, sehingga remaja merasa malu dan enggan membicarakannya.

Uterus (Rahim)

Organ berbentuk pir tempat tumbuhnya janin. Dinding dalamnya dilapisi endometrium yang luruh saat menstruasi bila tidak terjadi pembuahan.

Vulva

Organ reproduksi eksternal perempuan yang meliputi labia, klitoris, dan lubang vagina.

CHAPTER 5

KESEHATAN MENTAL DAN SEKSUALITAS REMAJA

Siti Komariyah, S.SiT,M.Kes

A. Pendahuluan/Prolog

Kesehatan mental dan seksualitas pada remaja merupakan isu yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika perkembangan individu di masa transisi menuju dewasa. Masa remaja sering disebut sebagai periode “storm and stress”, di mana individu menghadapi berbagai tantangan yang kompleks baik secara biologis, psikologis, maupun sosial. Pada tahap ini, remaja mulai membentuk identitas diri, mencari kemandirian, serta mengalami perubahan fisik dan emosional yang signifikan. Oleh karena itu, perhatian terhadap kesehatan mental dan seksualitas remaja menjadi hal yang sangat penting, tidak hanya bagi individu itu sendiri, tetapi juga bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa.

Latar belakang pentingnya kesehatan mental dan seksualitas pada remaja dapat dilihat dari fakta bahwa masa remaja merupakan periode kritis dalam pembentukan pola pikir, perilaku, dan gaya hidup yang akan terbawa hingga dewasa. Remaja yang memiliki kesehatan mental baik cenderung mampu menghadapi tekanan akademik, sosial, maupun emosional dengan lebih efektif. Sebaliknya, gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, atau rendahnya harga diri dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam mengambil keputusan yang sehat, termasuk terkait dengan perilaku seksual. Seksualitas pada remaja sendiri bukan hanya soal hubungan fisik atau reproduksi, tetapi juga menyangkut identitas, peran gender, norma sosial, serta nilai moral yang berkembang dalam masyarakat. Apabila aspek kesehatan mental dan seksualitas ini diabaikan, remaja akan lebih rentan terhadap berbagai risiko, mulai dari perilaku seksual berisiko, kehamilan yang tidak diinginkan, infeksi menular seksual, hingga masalah psikososial yang berdampak jangka panjang.

Hubungan erat antara perkembangan psikologis, sosial, dan biologis remaja menjadikan pembahasan kesehatan mental dan seksualitas semakin kompleks. Secara biologis, remaja mengalami pubertas yang ditandai dengan perubahan hormon, pertumbuhan organ seksual sekunder, dan kematangan sistem reproduksi.

Perubahan biologis ini sering kali menimbulkan rasa ingin tahu yang besar terhadap seksualitas. Sementara itu, dari aspek psikologis, remaja mulai membangun konsep diri dan menghadapi konflik identitas yang berhubungan dengan peran sosial serta orientasi seksual. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan, kegelisahan, bahkan tekanan emosional yang signifikan. Di sisi sosial, remaja hidup dalam lingkungan yang sarat akan pengaruh, baik dari keluarga, teman sebaya, maupun media. Dukungan keluarga yang positif dapat membantu remaja memiliki sikap sehat terhadap seksualitas, sedangkan tekanan dari kelompok sebaya atau paparan media yang tidak sehat justru dapat meningkatkan risiko perilaku seksual berisiko.

Dengan demikian, kesehatan mental dan seksualitas pada remaja tidak dapat dipandang secara terpisah, melainkan harus dilihat sebagai satu kesatuan yang saling memengaruhi. Perubahan biologis dapat memicu dinamika psikologis, sementara kondisi psikologis yang labil dapat diperburuk oleh tekanan sosial. Pemahaman yang komprehensif tentang hubungan ini akan membantu tenaga kesehatan, pendidik, dan orang tua dalam memberikan pendampingan yang tepat bagi remaja agar mereka mampu melewati fase transisi ini dengan sehat, bertanggung jawab, dan bermartabat.

B. Konsep Dasar Kesehatan Mental Remaja

Kesehatan mental pada remaja adalah kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang memungkinkan mereka untuk berpikir jernih, mengendalikan emosi, menjalin hubungan yang sehat, serta mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi berbagai tuntutan kehidupan. Pada fase perkembangan ini, remaja sedang berada dalam periode transisi yang penuh perubahan dan tantangan, sehingga kesehatan mental menjadi salah satu aspek fundamental yang akan menentukan kualitas hidup mereka di masa depan. Definisi kesehatan mental remaja tidak hanya berhubungan dengan ketiadaan gangguan jiwa, tetapi juga mencakup kemampuan remaja dalam mengelola stres, beradaptasi dengan perubahan, dan tetap produktif dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Karakteristik kesehatan mental pada usia remaja dapat dilihat dari cara mereka mengekspresikan perasaan, berinteraksi dengan orang lain, serta menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Remaja yang sehat secara mental biasanya menunjukkan kepercayaan diri yang cukup, memiliki keterampilan sosial yang baik, dan mampu menjaga hubungan yang harmonis dengan keluarga maupun teman sebaya. Mereka juga lebih mampu mengendalikan emosi, tidak mudah putus asa ketika menghadapi kegagalan, serta memiliki motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan. Sebaliknya, remaja dengan kesehatan mental yang terganggu sering kali menunjukkan gejala seperti mudah cemas, murung berkepanjangan, sulit

berkonsentrasi, menarik diri dari lingkungan sosial, atau bahkan menunjukkan perilaku berisiko.

Faktor yang memengaruhi kesehatan mental remaja sangatlah beragam dan saling berkaitan. Secara biologis, perubahan hormon pada masa pubertas berperan besar dalam memengaruhi suasana hati, tingkat energi, dan respons emosional. Remaja yang mengalami pubertas lebih cepat atau lebih lambat dari teman sebayanya kadang menghadapi perasaan tidak nyaman terhadap tubuh mereka, yang dapat memicu masalah harga diri. Dari sisi psikologis, remaja sedang berada dalam tahap pencarian identitas, sehingga mereka lebih rentan terhadap konflik batin, kebingungan peran, dan krisis kepercayaan diri. Faktor psikologis ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil, pola asuh, serta kualitas hubungan dengan orang tua.

Sementara itu, faktor sosial juga memegang peran penting. Hubungan dengan teman sebaya sering menjadi pusat kehidupan remaja. Tekanan untuk diterima dalam kelompok, perundungan (bullying), dan pengaruh pergaulan dapat meningkatkan risiko masalah mental. Dukungan sosial yang kuat dari keluarga dan komunitas dapat menjadi pelindung penting untuk menjaga stabilitas emosional mereka. Dari sisi budaya, nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat turut membentuk cara pandang remaja terhadap kesehatan mental. Misalnya, dalam budaya yang masih menstigma gangguan jiwa, remaja mungkin enggan untuk mencari pertolongan ketika menghadapi masalah psikologis.

Faktor terakhir yang tidak kalah penting adalah lingkungan. Remaja yang tinggal di lingkungan penuh konflik, kemiskinan, atau kekerasan lebih berisiko mengalami stres kronis yang berdampak pada kesehatan mental mereka. Sebaliknya, lingkungan yang mendukung, aman, dan menyediakan akses terhadap fasilitas pendidikan maupun kesehatan dapat membantu remaja berkembang secara optimal. Lingkungan digital dan media sosial yang kini sangat dekat dengan kehidupan remaja juga memiliki pengaruh ganda. Di satu sisi, media sosial dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan diri dan menjalin pertemanan; tetapi di sisi lain, penggunaan berlebihan dapat memicu kecemasan, perasaan terisolasi, atau rendahnya kepercayaan diri akibat perbandingan sosial.

C. Konsep Dasar Seksualitas Remaja

Seksualitas remaja merupakan sebuah konsep yang luas dan kompleks, melampaui sekadar persoalan hubungan fisik atau reproduksi. Dalam perspektif remaja, seksualitas tidak hanya berkaitan dengan dorongan biologis, tetapi juga mencakup identitas, ekspresi diri, hubungan interpersonal, serta nilai-nilai yang mereka anut. Seksualitas adalah bagian dari kehidupan manusia yang melekat sejak

lahir, berkembang seiring waktu, dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Bagi remaja, seksualitas sering kali menjadi ruang pencarian jati diri, di mana mereka mulai menyadari daya tarik fisik, membentuk persepsi tentang tubuh, serta memahami peran gender dan orientasi seksual. Pemahaman seksualitas pada remaja bersifat subjektif, bisa positif ketika didukung dengan edukasi yang tepat, tetapi juga bisa menimbulkan kebingungan atau perilaku berisiko jika tidak dibimbing dengan baik.

Perkembangan seksualitas pada masa pubertas terjadi secara bertahap dan sangat dipengaruhi oleh perubahan biologis. Masa pubertas ditandai dengan aktifnya hormon reproduksi, yang memunculkan perubahan fisik seperti pertumbuhan organ seksual sekunder, perubahan suara, munculnya rambut pada area tertentu, serta menstruasi pada perempuan dan mimpi basah pada laki-laki. Selain perubahan fisik, remaja juga mengalami lonjakan rasa ingin tahu terhadap tubuh mereka sendiri maupun lawan jenis. Hal ini sering diiringi dengan perkembangan emosi baru, seperti ketertarikan romantis, kebutuhan akan kasih sayang, dan eksplorasi hubungan intim. Seksualitas remaja pada tahap ini adalah bagian alami dari perkembangan, namun tanpa informasi yang benar, mereka bisa terseret pada perilaku seksual berisiko yang berdampak serius, seperti kehamilan tidak diinginkan, infeksi menular seksual, dan masalah psikososial. Oleh karena itu, pemahaman yang sehat tentang seksualitas pada masa pubertas menjadi sangat penting untuk membekali remaja dengan keterampilan dalam membuat keputusan yang bertanggung jawab.

Sementara itu, norma, nilai, dan konstruksi sosial memiliki peran yang besar dalam membentuk pandangan remaja terhadap seksualitas. Dalam banyak budaya, pembicaraan tentang seksualitas masih dianggap tabu, sehingga remaja sering kesulitan mendapatkan informasi yang akurat dan sehat. Nilai-nilai keluarga, ajaran agama, serta kebiasaan masyarakat turut menentukan bagaimana remaja memahami, mengekspresikan, dan mengendalikan seksualitas mereka. Di satu sisi, norma yang ketat dapat membantu remaja menunda perilaku seksual yang berisiko. Namun, di sisi lain, sikap yang terlalu mengekang atau menutup akses informasi dapat menimbulkan rasa bersalah, kebingungan, bahkan perilaku tersembunyi yang tidak sehat. Media dan perkembangan teknologi juga menjadi bagian dari konstruksi sosial yang kuat, karena tayangan televisi, internet, dan media sosial sering kali memberikan gambaran seksualitas yang tidak realistis. Hal ini dapat membentuk ekspektasi keliru dan memengaruhi perilaku remaja dalam menjalin hubungan.

D. Isu dan Tantangan Kesehatan Mental Remaja

Masa remaja adalah periode kritis yang penuh dengan dinamika, di mana individu menghadapi beragam tuntutan baik dari dalam dirinya maupun dari lingkungan sekitar. Perubahan biologis yang cepat, pencarian identitas, serta ekspektasi sosial yang tinggi menjadikan remaja rentan terhadap berbagai isu kesehatan mental dan seksualitas. Tantangan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan psikologis, tetapi juga dapat memengaruhi prestasi akademik, hubungan sosial, hingga kualitas hidup jangka panjang.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi remaja adalah stres akademik, bullying, tekanan sosial, dan masalah citra diri. Sistem pendidikan yang kompetitif sering menimbulkan tekanan luar biasa bagi remaja untuk berprestasi. Ketakutan akan kegagalan, tuntutan orang tua, serta persaingan dengan teman sebaya dapat menimbulkan stres kronis. Di sisi lain, bullying—baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun melalui media digital (cyberbullying)—dapat merusak harga diri remaja dan memicu perasaan terisolasi. Masalah citra tubuh juga sering muncul pada masa ini. Paparan standar kecantikan atau maskulinitas yang tidak realistis dari media membuat banyak remaja merasa tidak puas dengan tubuhnya sendiri, sehingga memunculkan kecemasan, diet ekstrem, bahkan gangguan makan.

Selain itu, terdapat risiko gangguan mental yang cukup tinggi pada kelompok usia remaja. Kecemasan dan depresi merupakan dua kondisi yang paling sering ditemukan, yang dapat bermula dari stres berkepanjangan, tekanan akademik, konflik keluarga, atau kesulitan dalam hubungan sosial. Tidak jarang, remaja mencoba melarikan diri dari masalah dengan cara yang tidak sehat, misalnya penyalahgunaan zat seperti alkohol, rokok, atau narkoba. Tindakan ini bukan hanya memperburuk kondisi mental, tetapi juga membahayakan kesehatan fisik dan masa depan mereka.

Media sosial menjadi faktor baru yang memiliki peran ambivalen terhadap kesehatan mental remaja. Di satu sisi, media sosial memberikan ruang bagi remaja untuk berekspresi, membangun relasi, dan mencari informasi. Namun, di sisi lain, media sosial juga menimbulkan tekanan sosial yang besar. Fenomena fear of missing out (FOMO), perbandingan sosial, dan paparan terhadap konten negatif sering kali meningkatkan risiko kecemasan, depresi, bahkan pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Remaja yang menghabiskan terlalu banyak waktu di dunia maya cenderung mengalami kesulitan tidur, penurunan motivasi belajar, dan gangguan interaksi sosial di dunia nyata.

Tantangan remaja tidak hanya sebatas pada kesehatan mental, tetapi juga berkaitan erat dengan seksualitas. Isu yang paling menonjol adalah kehamilan tidak diinginkan dan infeksi menular seksual (IMS/HIV). Minimnya edukasi seksual yang

komprehensif membuat banyak remaja tidak memahami risiko dan cara pencegahan. Akibatnya, mereka rentan melakukan hubungan seksual tanpa perlindungan yang berujung pada kehamilan di luar nikah maupun tertular penyakit menular seksual. Hal ini menimbulkan konsekuensi serius, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, termasuk stigma, putus sekolah, dan terbatasnya kesempatan masa depan.

Selain itu, perilaku seksual berisiko menjadi tantangan tersendiri. Rasa ingin tahu, dorongan biologis, serta pengaruh teman sebaya sering mendorong remaja untuk bereksperimen dengan perilaku seksual tanpa pertimbangan matang. Kurangnya kemampuan dalam mengambil keputusan yang sehat menjadikan remaja lebih mudah terjebak dalam situasi yang berbahaya, misalnya hubungan seksual yang tidak konsensual, penggunaan zat sebelum berhubungan, atau keterlibatan dalam pornografi.

Isu lain yang sangat penting adalah kekerasan berbasis gender dan pelecehan seksual. Remaja, baik perempuan maupun laki-laki, berisiko menjadi korban maupun pelaku kekerasan seksual. Banyak kasus pelecehan yang terjadi dalam lingkup sekolah, lingkungan pergaulan, maupun media digital. Sayangnya, masih banyak remaja yang enggan melapor karena takut disalahkan, distigma, atau tidak dipercaya. Kekerasan berbasis gender tidak hanya merusak fisik, tetapi juga meninggalkan luka psikologis yang mendalam, seperti trauma, kecemasan, atau gangguan stres pascatrauma (PTSD).

E. Hubungan Kesehatan Mental dengan Seksualitas

Kesehatan mental dan seksualitas remaja memiliki keterkaitan yang sangat erat, saling memengaruhi, dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Gangguan pada kesehatan mental dapat berimbas pada cara remaja mengekspresikan seksualitasnya, sementara pengalaman seksual yang dialami juga dapat meninggalkan dampak psikologis yang mendalam. Oleh karena itu, memahami hubungan keduanya menjadi kunci penting dalam membangun strategi pencegahan dan intervensi yang tepat, sehingga remaja dapat tumbuh dengan sehat baik secara emosional maupun seksual.

Dampak gangguan mental terhadap perilaku seksual cukup signifikan. Remaja yang mengalami depresi, kecemasan, atau rendahnya harga diri sering kali memiliki kontrol diri yang lemah dalam mengambil keputusan, termasuk dalam hal perilaku seksual. Beberapa remaja dengan kondisi psikologis yang rapuh cenderung mencari pelarian melalui hubungan seksual sebagai bentuk kompensasi emosional, meskipun dilakukan tanpa pertimbangan risiko. Sebaliknya, ada pula yang mengalami hambatan dalam mengekspresikan seksualitasnya, misalnya karena rasa

takut, rasa bersalah, atau trauma masa lalu. Kondisi ini menunjukkan bahwa gangguan mental dapat memicu perilaku seksual berisiko maupun menghambat perkembangan seksualitas yang sehat.

Selain itu, pengalaman seksual yang dialami remaja juga berdampak besar terhadap kondisi psikologis mereka. Pengalaman seksual yang positif, misalnya hubungan yang sehat, penuh rasa hormat, dan sesuai dengan norma yang berlaku, dapat memberikan rasa percaya diri dan pemahaman yang lebih baik terhadap identitas diri. Namun, tidak sedikit remaja yang mengalami pengalaman seksual negatif, seperti hubungan tanpa konsensus, kehamilan tidak diinginkan, atau tertular infeksi menular seksual. Pengalaman-pengalaman tersebut dapat menimbulkan tekanan emosional yang berat, rasa bersalah, trauma, hingga gangguan psikologis jangka panjang seperti depresi atau gangguan stres pascatrauma (PTSD). Bahkan pengalaman seksual yang terjadi terlalu dini, sebelum remaja memiliki kesiapan emosional, dapat merusak perkembangan psikologis dan mengganggu proses pencarian identitas diri mereka.

Dalam menghadapi dinamika tersebut, peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sangat penting dalam membentuk perilaku sehat remaja. Keluarga yang memberikan komunikasi terbuka, dukungan emosional, dan pendidikan seksualitas yang sehat dapat membantu remaja memahami tubuh dan seksualitasnya secara positif. Sekolah juga berperan melalui kurikulum pendidikan kesehatan reproduksi dan bimbingan konseling yang ramah remaja, sehingga siswa memiliki informasi yang benar dan keterampilan untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab. Lingkungan yang sehat baik komunitas maupun media juga menjadi faktor pelindung yang kuat. Sebaliknya, lingkungan yang penuh stigma, diskriminasi, dan kekerasan justru dapat memperburuk kondisi mental remaja dan mendorong mereka pada perilaku seksual berisiko.

F. Strategi Promotif dan Preventif

Upaya promotif dan preventif dalam menjaga kesehatan mental dan seksualitas remaja merupakan langkah strategis yang harus dilakukan secara komprehensif, berkesinambungan, dan terintegrasi. Remaja adalah aset bangsa yang sedang berada pada tahap perkembangan krusial, sehingga intervensi yang tepat sejak dini akan membawa dampak besar terhadap kualitas hidup mereka di masa depan. Strategi promotif dan preventif ini tidak hanya bertujuan mencegah munculnya masalah, tetapi juga membekali remaja dengan pengetahuan, keterampilan, serta sikap positif untuk menghadapi tantangan kehidupan dengan sehat dan bertanggung jawab.

Edukasi kesehatan mental dan seksual yang ramah remaja menjadi pilar utama dalam strategi ini. Edukasi harus disampaikan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan, bahasa, dan tingkat perkembangan remaja, sehingga mudah dipahami dan diterima. Pendekatan yang ramah remaja berarti membuka ruang dialog yang aman, tidak menghakimi, serta menghargai privasi mereka. Materi edukasi sebaiknya tidak hanya berfokus pada aspek biologis, tetapi juga mencakup keterampilan hidup seperti pengendalian emosi, pengambilan keputusan, keterampilan komunikasi, dan penolakan terhadap perilaku berisiko. Dengan bekal ini, remaja akan lebih siap untuk menjaga kesehatan mentalnya, menolak tekanan negatif dari lingkungan, serta memahami seksualitas secara sehat.

Selanjutnya, program sekolah dan komunitas berperan penting sebagai wadah nyata dalam mendukung upaya promotif dan preventif. Sekolah dapat menjadi pusat edukasi yang sistematis melalui kurikulum kesehatan reproduksi dan konseling psikologis. Guru dan konselor sekolah perlu dilatih agar memiliki sensitivitas terhadap isu kesehatan mental dan seksualitas, sehingga mampu memberikan dukungan kepada siswa secara tepat. Di tingkat komunitas, program berbasis masyarakat seperti posyandu remaja, kelompok diskusi sebaya, dan kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada pengembangan keterampilan hidup dapat menjadi sarana efektif untuk memperkuat ketahanan mental dan membentuk perilaku sehat. Kolaborasi lintas sektor, termasuk organisasi masyarakat, tokoh agama, dan lembaga swadaya masyarakat, akan memperluas jangkauan program sekaligus memperkuat dukungan sosial bagi remaja.

Di era digital, pemanfaatan media digital dan teknologi untuk edukasi tidak bisa diabaikan. Remaja adalah generasi yang sangat dekat dengan teknologi, sehingga media sosial, aplikasi seluler, dan platform daring dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan mental dan seksual. Konten edukasi yang dikemas secara kreatif, interaktif, dan sesuai tren akan lebih menarik perhatian remaja, dibandingkan metode konvensional yang kaku. Misalnya, kampanye digital dengan video singkat, podcast, atau aplikasi edukasi kesehatan dapat membantu remaja memperoleh informasi yang benar dengan cara yang menyenangkan. Namun, perlu juga ada pengawasan dan panduan agar remaja dapat membedakan informasi yang valid dari konten yang menyesatkan. Oleh karena itu, kolaborasi dengan tenaga kesehatan, akademisi, dan influencer yang kredibel sangat penting dalam menciptakan ruang digital yang sehat.

G. Peran Bidan, Perawat, dan Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan, khususnya bidan dan perawat, memegang peranan penting dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan mental serta seksualitas remaja. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan kesehatan, tetapi juga sebagai pendidik, konselor, dan pendamping yang dapat memberikan dukungan emosional maupun informasi yang benar. Peran ini sangat krusial karena remaja sering kali merasa lebih nyaman untuk berbicara dengan tenaga kesehatan dibandingkan dengan orang tua atau guru, terutama terkait isu-isu sensitif seperti kesehatan mental dan seksual.

Pendekatan konseling dan komunikasi efektif menjadi inti dari pelayanan kesehatan bagi remaja. Konseling yang dilakukan harus berlandaskan prinsip ramah remaja, yaitu menciptakan suasana aman, nyaman, dan menghargai privasi mereka. Bidan dan perawat perlu menggunakan keterampilan komunikasi interpersonal yang baik, seperti mendengarkan aktif, empati, serta memberikan umpan balik yang mendukung. Dalam konseling, tenaga kesehatan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membantu remaja mengenali perasaan, memahami risiko, dan menemukan solusi yang sesuai dengan situasi mereka. Pendekatan ini memungkinkan remaja lebih terbuka, percaya diri, dan termotivasi untuk membuat keputusan yang sehat.

Selain itu, kolaborasi interprofesional menjadi kunci keberhasilan dalam upaya mendukung kesehatan mental dan seksual remaja. Masalah yang dihadapi remaja sering kali bersifat multidimensi, sehingga tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak. Bidan, perawat, dokter, psikolog, guru, orang tua, dan tokoh masyarakat perlu bekerja sama dalam sebuah jejaring yang saling mendukung. Misalnya, sekolah dapat menyediakan ruang konseling, keluarga memberikan dukungan emosional, masyarakat menciptakan lingkungan yang aman, sementara tenaga kesehatan memberikan layanan medis dan edukasi yang tepat. Kolaborasi ini memastikan bahwa remaja memperoleh bantuan secara menyeluruh, mulai dari aspek medis, psikologis, sosial, hingga spiritual.

Dalam memberikan layanan, tenaga kesehatan juga harus memperhatikan etika dan sensitivitas budaya. Setiap remaja tumbuh dalam lingkungan dengan nilai, norma, dan kepercayaan yang berbeda. Oleh karena itu, layanan yang diberikan harus menghormati latar belakang budaya dan keyakinan mereka. Misalnya, dalam beberapa komunitas, pembicaraan tentang seksualitas masih dianggap tabu. Dalam situasi seperti ini, tenaga kesehatan perlu mencari pendekatan yang lebih halus, menggunakan bahasa yang tepat, dan melibatkan pihak-pihak yang dipercaya remaja, tanpa mengurangi kualitas informasi yang disampaikan. Prinsip etika seperti

kerahasiaan, otonomi, dan non-diskriminasi harus selalu dijunjung tinggi agar remaja merasa aman dan tidak takut untuk mengakses layanan.

H. Simpulan

Pembahasan mengenai kesehatan mental dan seksualitas remaja menunjukkan bahwa keduanya merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika perkembangan individu pada masa transisi menuju dewasa. Remaja menghadapi perubahan biologis yang pesat, tantangan psikologis dalam membangun identitas diri, serta pengaruh sosial dan budaya yang kompleks. Kesehatan mental yang baik memungkinkan remaja untuk berpikir jernih, mengelola emosi, menjalin hubungan positif, serta membuat keputusan yang sehat, termasuk dalam hal seksualitas. Sebaliknya, gangguan mental dapat memengaruhi kontrol diri dan meningkatkan risiko perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab.

Seksualitas pada remaja bukan hanya menyangkut aspek biologis, tetapi juga melibatkan identitas, peran gender, nilai, serta konstruksi sosial yang membentuk cara mereka memahami tubuh dan hubungan dengan orang lain. Kurangnya pemahaman yang sehat serta minimnya akses terhadap edukasi dapat menjerumuskan remaja pada perilaku seksual berisiko, kehamilan tidak diinginkan, maupun infeksi menular seksual. Tantangan lain yang sering muncul adalah stres akademik, bullying, tekanan sosial, penyalahgunaan zat, hingga kekerasan berbasis gender, yang semakin memperburuk kondisi psikologis remaja.

Untuk itu, strategi promotif dan preventif perlu dijalankan secara terpadu melalui edukasi ramah remaja, program sekolah dan komunitas, serta pemanfaatan teknologi digital yang sesuai dengan karakteristik generasi muda. Keluarga, sekolah, masyarakat, dan tenaga kesehatan memiliki peran yang sama penting dalam memberikan dukungan, membangun komunikasi terbuka, serta menciptakan lingkungan yang aman. Tenaga kesehatan, terutama bidan dan perawat, harus menjalankan layanan dengan pendekatan konseling yang efektif, kolaborasi interprofesional, serta menjunjung tinggi etika dan sensitivitas budaya. Dengan pendekatan yang komprehensif, remaja dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat secara mental, memahami seksualitas secara bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi positif bagi kehidupan sosial maupun masa depan bangsa.

I. Daftar Pustaka

- American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). Washington, DC: APA.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2021). Laporan survei demografi dan kesehatan Indonesia remaja. Jakarta: BKKBN.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Pedoman pelayanan kesehatan remaja di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jakarta: Kemenkes RI.
- Papalia, D. E., Martorell, G., & Feldman, R. D. (2021). Experience human development (15th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Santrock, J. W. (2020). Adolescence (17th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Sawyer, S. M., Azzopardi, P. S., Wickremarathne, D., & Patton, G. C. (2018). The age of adolescence. *The Lancet Child & Adolescent Health*, 2(3), 223–228.
- World Health Organization. (2020). Adolescent mental health: Key facts. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2021). Global status report on preventing violence against children and adolescents. Geneva: WHO.
- Zarocostas, J. (2021). How to fight an infodemic. *The Lancet*, 398(10299), 1210–1211.

J. Glosarium

Adolesens (Remaja)

Masa perkembangan transisi dari anak menuju dewasa yang ditandai dengan perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang signifikan.

Bullying

Tindakan agresif, baik secara fisik, verbal, maupun digital (cyberbullying), yang dilakukan secara berulang dengan tujuan menyakiti atau merendahkan orang lain.

Citra Diri (Body Image)

Pandangan dan penilaian seseorang terhadap tubuhnya sendiri, yang dapat dipengaruhi oleh standar sosial, budaya, maupun media.

Depresi

Gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan perasaan sedih berkepanjangan, kehilangan minat, dan berkurangnya energi untuk beraktivitas.

Edukasi Seksualitas

Proses pemberian informasi, pemahaman, dan keterampilan kepada remaja tentang tubuh, hubungan, nilai, serta tanggung jawab dalam perilaku seksual.

Faktor Psikologis

Aspek kejiwaan yang memengaruhi kesehatan mental remaja, termasuk pencarian identitas, pengendalian emosi, dan kemampuan mengatasi stres.

Gangguan Kesehatan Mental

Kondisi psikologis yang mengganggu fungsi sehari-hari remaja, seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku.

Identitas Diri

Konsep yang dibentuk remaja mengenai siapa dirinya, termasuk peran gender, orientasi seksual, dan nilai-nilai pribadi.

Infeksi Menular Seksual (IMS)

Penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, seperti gonore, sifilis, klamidia, dan HIV.

Kecemasan

Gangguan emosional berupa rasa takut atau khawatir berlebihan terhadap suatu situasi, yang dapat mengganggu fungsi belajar dan sosial.

Kesehatan Mental

Kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang memungkinkan individu berpikir jernih, mengendalikan emosi, dan berinteraksi positif dengan lingkungannya.

Kesehatan Reproduksi Remaja

Keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan proses reproduksi remaja.

Norma Sosial

Aturan atau standar perilaku yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman dalam berperilaku, termasuk dalam hal seksualitas.

Perilaku Seksual Berisiko

Tindakan seksual yang dapat menimbulkan dampak negatif seperti kehamilan tidak diinginkan, penularan IMS, atau masalah psikososial.

Pubertas

Masa perubahan biologis ketika organ reproduksi dan hormon mulai aktif, ditandai dengan menstruasi pada perempuan dan mimpi basah pada laki-laki.

Seksualitas

Aspek biologis, psikologis, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan identitas, peran gender, orientasi seksual, serta cara individu mengekspresikan hubungan dan keintiman.

Stres Akademik

Tekanan emosional yang dirasakan remaja akibat tuntutan pendidikan, seperti beban tugas, ujian, dan persaingan dengan teman sebaya.

Trauma

Reaksi emosional mendalam akibat pengalaman buruk, seperti pelecehan atau kekerasan seksual, yang dapat menimbulkan gangguan psikologis jangka panjang.

“Storm and Stress”

Istilah dalam psikologi perkembangan yang menggambarkan masa remaja sebagai periode penuh gejolak emosi, konflik, dan perubahan cepat.

CHAPTER 6

PERAN STRATEGIS KEBIDANAN DALAM PENINGKATAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

Dr. Bd. Ika Nur Saputri, SST., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

1. Latar belakang pentingnya kesehatan reproduksi remaja

Kesehatan reproduksi remaja merupakan isu penting yang tidak hanya menyangkut aspek biologis, tetapi juga psikologis, sosial, dan bahkan ekonomi. Remaja berada dalam masa transisi dari anak menuju dewasa, sebuah fase yang ditandai dengan perubahan cepat dalam tubuh, pikiran, dan peran sosial. Pada masa inilah remaja mulai membentuk identitas diri sekaligus menghadapi tantangan terkait perilaku seksual, pemahaman mengenai tubuh, serta hubungan dengan lawan jenis. Menstruasi, mimpi basah, serta pertumbuhan organ seksual sekunder adalah tanda-tanda nyata pubertas, namun di balik itu terdapat kebutuhan besar akan informasi yang benar dan pendampingan yang tepat. Tanpa pemahaman memadai, remaja rentan terhadap berbagai risiko, termasuk kehamilan tidak diinginkan, infeksi menular seksual, kekerasan berbasis gender, hingga gangguan kesehatan mental akibat stigma dan tekanan sosial. Karena itu, kesehatan reproduksi remaja harus ditempatkan sebagai bagian integral dari pembangunan kesehatan masyarakat, bukan hanya untuk mencegah penyakit, tetapi juga untuk memastikan mereka tumbuh menjadi generasi produktif dan berdaya.

2. Tantangan global dan nasional terkait kesehatan reproduksi remaja

Secara global, isu kesehatan reproduksi remaja masih menjadi sorotan besar. Menurut data WHO, jutaan remaja setiap tahunnya menghadapi kehamilan yang tidak direncanakan, dan banyak di antaranya terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Tantangan yang dihadapi bukan hanya terbatas pada tingginya angka kehamilan remaja, tetapi juga pada akses layanan kesehatan yang belum ramah remaja, kurangnya literasi digital yang sehat dalam menghadapi banjir informasi di media sosial, serta perbedaan norma budaya

yang kerap menghambat keterbukaan pembahasan mengenai reproduksi. Di Indonesia sendiri, kehamilan usia remaja masih tercatat tinggi dan sering berimplikasi pada putus sekolah, penurunan kualitas kesehatan ibu dan anak, serta lingkaran kemiskinan antargenerasi. Selain itu, perkawinan anak yang masih terjadi di sejumlah daerah menambah kompleksitas persoalan kesehatan reproduksi remaja. Stigma sosial, tabu membicarakan seksualitas, serta terbatasnya pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah memperburuk kondisi ini. Oleh karena itu, tantangan nasional tidak hanya soal medis, tetapi juga mencakup dimensi kebijakan, pendidikan, dan budaya.

1. Peran kebidanan sebagai bagian dari tenaga kesehatan

Dalam menghadapi kompleksitas masalah tersebut, profesi kebidanan memiliki posisi strategis. Bidan tidak hanya berfungsi sebagai tenaga kesehatan yang membantu proses persalinan atau pelayanan ibu hamil, tetapi juga sebagai ujung tombak dalam memberikan edukasi, konseling, dan pelayanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja. Bidan berperan dalam memfasilitasi komunikasi terbuka mengenai menstruasi, kontrasepsi, infeksi menular seksual, serta isu-isu lain yang sering dianggap tabu. Melalui pendekatan yang bersifat holistik dan humanis, bidan dapat menjembatani kesenjangan informasi antara remaja, orang tua, sekolah, dan layanan kesehatan. Selain itu, bidan memiliki akses langsung ke komunitas melalui puskesmas, posyandu remaja, serta program BKKBN, sehingga perannya tidak terbatas di ruang klinis, tetapi juga meluas ke ranah pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan keterampilan konseling, pemahaman budaya, serta keahlian klinis yang dimiliki, bidan mampu menjadi agen perubahan yang membantu remaja memahami, menerima, dan mengelola kesehatan reproduksinya secara bertanggung jawab.

B. Konsep Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja

1. Definisi kesehatan reproduksi remaja menurut WHO dan regulasi nasional

Kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang mencakup kesejahteraan fisik, mental, dan sosial dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. WHO menekankan bahwa kesehatan reproduksi bukan hanya bebas dari penyakit atau gangguan, tetapi juga melibatkan kemampuan individu untuk memiliki kehidupan seksual yang aman, memuaskan, dan bertanggung jawab, serta akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Dalam konteks remaja, definisi ini lebih luas lagi karena mereka sedang berada pada fase perkembangan yang menentukan arah kehidupan reproduksi di masa depan. Indonesia sendiri mengadopsi konsep tersebut melalui Undang-Undang Kesehatan dan regulasi turunannya, seperti Peraturan

Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi dan kebijakan BKKBN mengenai program Generasi Berencana (GenRe). Regulasi ini menegaskan bahwa remaja berhak mendapatkan informasi, edukasi, dan pelayanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja, termasuk upaya pencegahan kehamilan dini, perlindungan dari kekerasan seksual, serta pencegahan infeksi menular seksual.

2. Karakteristik biologis, psikologis, dan sosial remaja

Remaja adalah fase kehidupan yang unik karena ditandai oleh perubahan cepat di berbagai aspek. Secara biologis, mereka mengalami pubertas yang memunculkan tanda-tanda sekunder seperti menstruasi pada perempuan dan mimpi basah pada laki-laki. Hormon seksual seperti estrogen, progesteron, dan testosteron memengaruhi perkembangan organ reproduksi sekaligus berkontribusi pada perubahan mood. Dari sisi psikologis, remaja berada pada tahap pencarian identitas menurut teori perkembangan Erikson. Mereka cenderung ingin diakui, mandiri, dan berusaha memahami nilai-nilai baru, namun sering kali diliputi kebimbangan dan konflik dengan orang tua atau otoritas lain. Secara sosial, remaja sangat dipengaruhi oleh kelompok sebaya. Peran teman menjadi signifikan dalam menentukan perilaku, termasuk dalam hal gaya hidup dan perilaku seksual. Pada masa ini juga, remaja mulai terekspos pada media digital yang menyuguhkan informasi tanpa batas, yang bisa memperkaya wawasan tetapi juga berisiko menyesatkan jika tidak disertai literasi kesehatan yang memadai.

3. Isu-isu utama kesehatan reproduksi remaja (menstruasi, infeksi menular seksual, kehamilan remaja, gizi, kesehatan mental)

Permasalahan kesehatan reproduksi pada remaja sangat beragam dan saling terkait. Menstruasi merupakan isu yang paling awal muncul pada remaja perempuan. Ketidakteraturan siklus, nyeri haid (dismenore), dan minimnya pemahaman sering kali menimbulkan kecemasan. Infeksi menular seksual (IMS) menjadi isu lain yang semakin mengkhawatirkan, terutama di era pergaulan digital yang membuka akses lebih luas terhadap hubungan seksual berisiko. Tanpa pendidikan yang tepat, remaja rentan terhadap IMS seperti klamidia, gonore, hingga HIV/AIDS. Kehamilan remaja juga merupakan masalah besar, tidak hanya menimbulkan risiko medis seperti anemia, preeklamsia, dan komplikasi persalinan, tetapi juga berdampak pada aspek sosial berupa putus sekolah, stigma, dan keterbatasan ekonomi. Masalah gizi juga erat kaitannya dengan kesehatan reproduksi remaja. Kekurangan zat gizi mikro seperti zat besi menyebabkan anemia yang berimbas pada kualitas kesehatan dan konsentrasi belajar, sementara obesitas meningkatkan risiko gangguan hormonal dan sindrom ovarium polikistik (PCOS). Selain itu, kesehatan mental tidak bisa

diabaikan. Stres, kecemasan, depresi, bahkan keinginan untuk menyakiti diri sendiri sering muncul akibat tekanan akademik, sosial, maupun stigma terkait kesehatan reproduksi. Semua isu ini menuntut pendekatan yang integratif, tidak hanya dari tenaga kesehatan, tetapi juga melibatkan keluarga, sekolah, dan komunitas agar remaja mampu menjalani masa transisinya dengan sehat, percaya diri, dan produktif.

C. Kompetensi Bidan dalam Pelayanan Remaja

1. Landasan hukum dan regulasi praktik kebidanan

Pelayanan kebidanan, termasuk pada remaja, memiliki dasar hukum yang kuat baik secara internasional maupun nasional. WHO dan International Confederation of Midwives (ICM) menekankan bahwa bidan bukan hanya tenaga kesehatan yang fokus pada ibu hamil dan persalinan, tetapi juga memiliki kewenangan dalam layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sepanjang siklus kehidupan perempuan, termasuk fase remaja. Di Indonesia, landasan hukum praktik kebidanan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, yang menegaskan bahwa bidan berperan dalam pelayanan kesehatan reproduksi, keluarga berencana, kesehatan ibu, bayi, balita, serta remaja. Selain itu, regulasi turunannya seperti Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan memberikan ruang legal bagi bidan untuk memberikan layanan yang ramah, aman, dan sesuai dengan kebutuhan remaja. Dengan kerangka hukum ini, kompetensi bidan dalam pelayanan remaja menjadi diakui dan terikat tanggung jawab etik, profesional, dan hukum.

2. Kompetensi klinis bidan pada kesehatan reproduksi remaja

Kompetensi klinis merupakan salah satu aspek penting yang harus dimiliki bidan dalam melayani remaja. Bidan dituntut untuk mampu melakukan deteksi dini masalah kesehatan reproduksi remaja, seperti gangguan menstruasi, anemia, infeksi saluran reproduksi, hingga risiko kehamilan dini. Keterampilan klinis meliputi pemeriksaan fisik dasar, pemantauan status gizi, pemeriksaan laboratorium sederhana, serta pemberian terapi awal yang sesuai dengan standar pelayanan. Bidan juga harus menguasai penatalaksanaan awal kasus-kasus reproduksi remaja yang sering terjadi, misalnya dismenore berat, perdarahan abnormal, atau infeksi menular seksual ringan. Selain keterampilan teknis, bidan juga wajib memiliki sensitivitas terhadap perubahan biologis yang khas pada remaja, sehingga dapat memberikan edukasi yang sesuai tahap perkembangan mereka. Kompetensi klinis ini tidak berhenti pada tataran penanganan medis, melainkan juga harus terintegrasi dengan upaya promotif dan preventif, misalnya

melalui penyuluhan gizi seimbang, konseling kesehatan reproduksi, serta rujukan tepat waktu bila ditemukan kasus kompleks.

3. Kompetensi komunikasi, konseling, dan pendekatan berbasis usia

Salah satu tantangan terbesar dalam pelayanan remaja adalah membangun komunikasi yang efektif. Remaja cenderung tertutup dan enggan membicarakan isu reproduksi karena rasa malu, takut dihakimi, atau stigma sosial. Di sinilah kompetensi komunikasi bidan sangat menentukan. Bidan harus mampu menciptakan suasana yang aman, menghargai privasi, serta menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Pendekatan berbasis usia menuntut bidan untuk memahami karakteristik perkembangan psikologis remaja, sehingga konseling yang diberikan tidak hanya informatif, tetapi juga suportif dan memberdayakan. Dalam praktiknya, konseling dapat meliputi pendidikan tentang menstruasi sehat, pencegahan kehamilan tidak diinginkan, penggunaan kontrasepsi yang tepat, hingga isu kesehatan mental yang sering berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Selain itu, kompetensi ini juga menuntut bidan untuk mampu bekerja lintas sektor, misalnya dengan guru, konselor sekolah, orang tua, dan tokoh masyarakat, agar remaja mendapat dukungan yang menyeluruh. Dengan komunikasi yang empatik dan konseling yang tepat, bidan dapat membantu remaja memahami tubuh mereka, membuat keputusan sehat, dan membangun rasa percaya diri dalam menjaga kesehatan reproduksi.

D. Peran Bidan dalam Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja

1. Edukasi kesehatan reproduksi di sekolah dan komunitas

Bidan memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi kesehatan reproduksi kepada remaja, terutama di sekolah dan komunitas. Sekolah merupakan tempat yang paling efektif karena menjangkau sebagian besar remaja dalam suasana formal dan terstruktur. Melalui program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M), bidan dapat berkolaborasi dengan guru dan konselor sekolah untuk memberikan informasi seputar pubertas, menstruasi sehat, pencegahan kehamilan remaja, serta pencegahan infeksi menular seksual. Di komunitas, bidan dapat hadir melalui posyandu remaja, karang taruna, atau forum kepemudaan, yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi remaja untuk bertanya dan berdiskusi. Kehadiran bidan di ranah ini penting untuk mengurangi kesenjangan informasi yang sering diwarnai mitos dan tabu budaya. Dengan pendekatan edukatif yang interaktif, seperti diskusi kelompok, simulasi, atau media digital, bidan dapat membangun kesadaran bahwa kesehatan reproduksi adalah bagian penting dari tumbuh kembang remaja.

2. Pemberdayaan remaja melalui program pendidik sebaya

Salah satu strategi yang terbukti efektif dalam menjangkau remaja adalah program pendidik sebaya (peer educator). Bidan dapat berperan sebagai fasilitator utama dalam melatih remaja yang memiliki minat dan kapasitas untuk menjadi agen informasi di lingkungannya. Remaja sering kali lebih nyaman berbagi pengalaman dan masalah dengan teman sebaya dibandingkan dengan orang dewasa. Dengan adanya pendidik sebaya, pesan-pesan kesehatan reproduksi dapat disampaikan dengan bahasa dan pendekatan yang lebih sesuai dengan dunia remaja. Bidan bertugas memberikan materi, metode komunikasi, serta bimbingan berkelanjutan, sehingga pendidik sebaya tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai teladan dalam membangun perilaku sehat. Melalui model ini, remaja diberdayakan untuk menjadi bagian dari solusi, sekaligus memperkuat kapasitas komunitas dalam menjaga kesehatan reproduksi generasi muda.

3. Penyuluhan berbasis keluarga untuk memperkuat dukungan orang tua

Selain sekolah dan komunitas, keluarga adalah fondasi utama dalam membentuk sikap dan perilaku remaja. Sayangnya, banyak orang tua masih merasa tabu atau canggung membicarakan kesehatan reproduksi dengan anak mereka. Di sinilah peran bidan menjadi penting untuk menjembatani kesenjangan komunikasi tersebut. Melalui penyuluhan berbasis keluarga, bidan dapat mengedukasi orang tua tentang pentingnya mendampingi anak dalam memahami perubahan tubuh dan psikologis yang mereka alami. Bidan dapat memfasilitasi kelas orang tua yang membahas keterampilan komunikasi efektif, cara menjawab pertanyaan sulit dari anak, serta memberikan informasi akurat tentang menstruasi, pubertas, kontrasepsi, hingga kesehatan mental. Dengan demikian, orang tua tidak hanya menjadi penonton, tetapi terlibat aktif sebagai pendukung utama anak mereka. Dukungan keluarga yang kuat terbukti mampu menurunkan risiko perilaku berisiko pada remaja dan meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menjaga kesehatan reproduksi.

E. Peran Bidan dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja

1. Deteksi dini dan pencegahan masalah reproduksi

Salah satu fungsi utama bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja adalah melakukan deteksi dini terhadap potensi masalah. Pada masa remaja, berbagai gangguan kesehatan reproduksi bisa muncul, mulai dari ketidakaturan siklus menstruasi, dismenore berat, infeksi saluran reproduksi, hingga risiko kehamilan dini. Bidan berperan aktif dalam melakukan skrining kesehatan, seperti pemeriksaan status gizi, deteksi anemia dengan tes hemoglobin sederhana, atau pemeriksaan tanda-tanda infeksi. Selain

pemeriksaan fisik, bidan juga mengkaji faktor risiko perilaku, misalnya kebiasaan seksual berisiko, konsumsi zat adiktif, atau pola makan yang tidak sehat. Melalui pendekatan preventif, bidan dapat memberikan intervensi dini berupa edukasi, rujukan, atau konseling. Deteksi dini ini sangat penting karena banyak remaja cenderung menutup diri atau menganggap keluhan yang dialami sebagai sesuatu yang normal, padahal bisa jadi merupakan gejala awal masalah serius.

2. Konseling kontrasepsi dan perencanaan kehidupan berkeluarga

Bidan memiliki kewenangan untuk memberikan konseling kontrasepsi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman remaja. Konseling tidak hanya membahas metode kontrasepsi, tetapi juga meliputi aspek perencanaan kehidupan berkeluarga, pengambilan keputusan yang sehat, serta pemahaman tentang hubungan yang bertanggung jawab. Dalam praktiknya, bidan harus menyampaikan informasi secara netral, menghargai pilihan remaja, dan menjaga kerahasiaan. Prinsip “perlindungan ganda” juga ditekankan, yaitu penggunaan kondom untuk mencegah infeksi menular seksual sekaligus kontrasepsi efektif untuk mencegah kehamilan. Lebih jauh, konseling ini dapat diarahkan untuk membantu remaja memahami pentingnya pendewasaan usia perkawinan dan kesiapan fisik maupun psikologis sebelum berkeluarga. Dengan demikian, bidan berperan sebagai fasilitator yang tidak hanya memberi informasi teknis, tetapi juga membantu remaja merencanakan masa depan reproduksinya secara sehat dan bertanggung jawab.

3. Penanganan masalah menstruasi, anemia, dan kesehatan gizi

Permasalahan menstruasi seperti siklus tidak teratur, perdarahan berlebih, atau nyeri haid adalah keluhan paling sering yang dialami remaja. Bidan dapat memberikan penanganan awal berupa edukasi tentang pola menstruasi normal, manajemen nyeri sederhana dengan teknik nonfarmakologis, serta terapi farmakologis ringan bila diperlukan. Pada kasus perdarahan berlebihan, bidan berperan dalam deteksi anemia melalui pemeriksaan sederhana dan memberikan edukasi mengenai pentingnya asupan zat besi. Masalah gizi, baik kekurangan maupun kelebihan, juga merupakan fokus utama. Bidan dapat memberikan konseling gizi seimbang, menganjurkan konsumsi makanan kaya zat besi, kalsium, dan vitamin D, serta memantau status gizi remaja melalui pengukuran berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh. Upaya ini bukan hanya menurunkan risiko anemia, tetapi juga membantu mempersiapkan kesehatan reproduksi yang optimal hingga masa dewasa.

4. Dukungan kesehatan mental terkait reproduksi

Aspek psikologis sering kali terlupakan dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja, padahal sangat berpengaruh terhadap perilaku dan kesehatan

fisik mereka. Perubahan hormonal dapat memicu fluktuasi emosi, kecemasan, bahkan depresi ringan. Masalah reproduksi seperti dismenore berat, stigma menstruasi, atau kehamilan tidak diinginkan dapat memperburuk kondisi mental remaja. Dalam hal ini, bidan berperan memberikan dukungan psikososial melalui konseling yang empatik, menjaga kerahasiaan, serta membantu remaja menemukan solusi tanpa rasa dihakimi. Bila ditemukan tanda gangguan mental yang lebih serius, bidan memiliki kewajiban untuk merujuk remaja ke tenaga kesehatan jiwa atau psikolog. Selain itu, bidan juga dapat mendorong terbentuknya kelompok dukungan sebaya yang berfungsi sebagai ruang aman bagi remaja untuk berbagi pengalaman. Dengan integrasi pendekatan biologis, psikologis, dan sosial, bidan berkontribusi penting dalam membangun ketahanan mental remaja dalam menghadapi dinamika kesehatan reproduksi mereka.

F. Kolaborasi Bidan dengan Lintas Sektor

1. Peran bidan dalam UKS/M (Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah)

Program UKS/M merupakan salah satu wadah penting dalam meningkatkan kesehatan remaja di lingkungan pendidikan. Bidan berperan aktif sebagai tenaga kesehatan yang bekerja sama dengan guru, konselor, dan pihak sekolah untuk membangun lingkungan belajar yang sehat, aman, dan mendukung perkembangan remaja. Melalui UKS/M, bidan dapat memberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi, kebersihan menstruasi, gizi seimbang, serta pencegahan perilaku berisiko. Tidak hanya dalam bentuk penyuluhan klasikal, bidan juga dapat melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, deteksi dini anemia atau gangguan menstruasi, serta membentuk kader kesehatan remaja di sekolah. Dengan demikian, UKS/M menjadi jembatan antara layanan kesehatan primer dan dunia pendidikan, memastikan remaja tidak hanya memperoleh ilmu akademis, tetapi juga mendapatkan perlindungan dan pendampingan kesehatan yang menyeluruh.

2. Kerjasama dengan puskesmas, BKKBN, organisasi pemuda, dan lembaga pendidikan

Bidan juga menjalankan peran kolaboratif dengan berbagai institusi. Di tingkat layanan primer, puskesmas menjadi pusat koordinasi bagi bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang terintegrasi. Melalui program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), bidan bekerja sama dengan tim puskesmas dalam skrining kesehatan, konseling, dan rujukan kasus remaja. Dengan BKKBN, bidan berperan dalam pelaksanaan program Generasi Berencana (GenRe) yang menysasar remaja melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja

(PIK-R). Kolaborasi ini memungkinkan bidan memberikan edukasi tentang pendewasaan usia perkawinan, perencanaan kehidupan berkeluarga, dan pencegahan kehamilan remaja. Selain itu, organisasi pemuda seperti karang taruna, pramuka, OSIS, dan komunitas lokal menjadi mitra strategis bidan dalam menjangkau remaja melalui kegiatan kreatif yang lebih santai dan kontekstual. Lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, juga membuka ruang bagi bidan untuk terlibat dalam kurikulum pendidikan kesehatan reproduksi, pelatihan guru, dan pembentukan pendidik sebaya.

3. Kolaborasi dengan tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, dan LSM

Di luar institusi formal, kolaborasi dengan tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, dan LSM menjadi kunci dalam memperluas dampak pelayanan bidan. Tokoh masyarakat, seperti kepala desa, ketua RT/RW, atau kader posyandu, berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan reproduksi remaja. Sementara itu, organisasi keagamaan memiliki pengaruh yang besar terhadap norma dan perilaku remaja, sehingga keterlibatan pemuka agama dalam mendukung edukasi kesehatan reproduksi dapat membantu mengurangi stigma dan mengikis tabu budaya. LSM berperan melengkapi dengan sumber daya, pelatihan, advokasi kebijakan, hingga penguatan sistem perlindungan anak. Melalui kolaborasi ini, bidan tidak hanya bekerja pada tataran klinis, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan sosial yang memperjuangkan hak remaja atas kesehatan reproduksi yang holistik, aman, dan berkelanjutan.

G. Inovasi Bidan dalam Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja

1. Pemanfaatan teknologi digital dan media sosial untuk edukasi

Di era digital, bidan memiliki peluang besar untuk menjangkau remaja melalui media yang dekat dengan keseharian mereka, yaitu teknologi digital dan media sosial. Platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, atau aplikasi pesan instan dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi seputar pubertas, menstruasi sehat, kontrasepsi, hingga pencegahan infeksi menular seksual. Keunggulan media sosial adalah sifatnya yang interaktif, cepat, dan dapat disesuaikan dengan bahasa remaja. Bidan dapat memproduksi konten edukatif dalam bentuk video pendek, infografis, atau sesi tanya jawab daring untuk membangun komunikasi dua arah. Selain itu, aplikasi kesehatan reproduksi berbasis mobile juga dapat dikembangkan, misalnya aplikasi pencatat siklus menstruasi yang dilengkapi dengan fitur konseling online. Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya membantu memperluas akses informasi, tetapi juga

memberi ruang aman bagi remaja yang mungkin masih malu untuk bertanya secara langsung.

2. Model layanan ramah remaja di klinik dan komunitas

Inovasi pelayanan kebidanan juga tercermin dari pengembangan model layanan ramah remaja di berbagai fasilitas kesehatan. Layanan ramah remaja ditandai dengan prinsip kerahasiaan, aksesibilitas, keterjangkauan, serta sikap non-diskriminatif dari tenaga kesehatan. Bidan dapat menciptakan ruang pelayanan yang ramah dan nyaman, misalnya ruang konsultasi yang privat, jadwal pelayanan yang menyesuaikan kegiatan sekolah, serta metode konseling yang menggunakan bahasa sederhana. Di komunitas, model ini dapat diwujudkan melalui pojok remaja di puskesmas, posyandu remaja, atau klinik keliling yang mendatangi sekolah dan desa. Dengan adanya model ini, remaja tidak hanya merasa lebih aman untuk mengakses layanan kesehatan reproduksi, tetapi juga lebih terlibat aktif dalam menjaga kesehatannya sendiri. Model layanan ramah remaja juga memfasilitasi integrasi dengan layanan lain seperti konseling gizi, skrining kesehatan mental, hingga deteksi dini anemia, sehingga bersifat holistik dan komprehensif.

3. Kegiatan kreatif berbasis komunitas (peer support group, posyandu remaja)

Selain memanfaatkan teknologi dan klinik formal, bidan juga dapat mengembangkan kegiatan kreatif berbasis komunitas yang melibatkan remaja secara langsung. Salah satunya adalah pembentukan peer support group atau kelompok dukungan sebaya. Dalam kelompok ini, remaja dilatih untuk saling berbagi pengalaman, mendiskusikan isu-isu kesehatan reproduksi, dan memberikan dukungan moral satu sama lain. Kehadiran pendidik sebaya membuat remaja lebih leluasa mengungkapkan masalah karena merasa berada dalam lingkungan yang setara. Di sisi lain, posyandu remaja menjadi inovasi penting yang memadukan layanan kesehatan dengan kegiatan sosial. Posyandu remaja tidak hanya menyediakan layanan medis seperti pemeriksaan kesehatan, pemberian tablet tambah darah, atau konseling, tetapi juga dilengkapi dengan aktivitas menarik seperti lomba, diskusi kreatif, dan pelatihan keterampilan hidup. Pendekatan berbasis komunitas ini memperkuat rasa kepemilikan remaja terhadap program kesehatan, sehingga mereka tidak sekadar menjadi penerima layanan, tetapi juga aktor aktif dalam mempromosikan kesehatan reproduksi di lingkungannya.

H. Tantangan dan Hambatan dalam Peran Kebidanan

1. Keterbatasan akses dan sumber daya

Salah satu tantangan utama dalam optimalisasi peran kebidanan pada kesehatan reproduksi remaja adalah keterbatasan akses dan sumber daya. Tidak semua daerah memiliki fasilitas kesehatan yang memadai atau tenaga kebidanan yang terdistribusi secara merata. Di wilayah pedesaan atau terpencil, remaja sering kesulitan menjangkau layanan kesehatan reproduksi karena jarak, biaya, maupun kurangnya transportasi. Selain itu, ketersediaan sarana pendukung seperti alat kesehatan, ruang konseling privat, serta obat-obatan dan kontrasepsi ramah remaja masih belum merata. Hal ini berdampak pada rendahnya cakupan layanan promotif dan preventif yang seharusnya dapat membantu remaja menghindari masalah serius di kemudian hari. Sementara di perkotaan, meski akses lebih baik, sering kali beban kerja bidan tinggi sehingga waktu untuk konseling mendalam menjadi terbatas.

2. Stigma budaya dan tabu seputar kesehatan reproduksi

Hambatan berikutnya bersumber dari faktor sosial-budaya. Di banyak komunitas, kesehatan reproduksi masih dianggap isu yang tabu untuk dibicarakan, terutama dengan remaja. Pembahasan mengenai menstruasi, kontrasepsi, atau hubungan seksual sering kali diselimuti mitos dan stigma, sehingga remaja tidak memiliki ruang aman untuk bertanya atau mencari informasi. Bidan yang mencoba memberikan edukasi kadang menghadapi resistensi dari orang tua, tokoh masyarakat, atau bahkan lembaga pendidikan yang khawatir topik tersebut “mendorong” perilaku seksual. Padahal, penelitian justru menunjukkan bahwa pendidikan reproduksi yang tepat dapat menunda aktivitas seksual dini. Hambatan budaya ini membuat peran bidan tidak hanya sebatas tenaga kesehatan, tetapi juga agen perubahan sosial yang perlu meyakinkan masyarakat tentang pentingnya keterbukaan dan edukasi berbasis bukti.

3. Kesenjangan pengetahuan antara tenaga kesehatan, remaja, dan keluarga

Selain kendala akses dan stigma, terdapat kesenjangan pengetahuan yang signifikan antara tenaga kesehatan, remaja, dan keluarga. Bidan mungkin sudah memahami konsep kesehatan reproduksi yang komprehensif, tetapi remaja sering kali hanya mengandalkan informasi terbatas dari teman sebaya atau media sosial yang belum tentu valid. Orang tua pun kerap kurang memiliki pemahaman, bahkan ikut memperkuat mitos yang berkembang di masyarakat. Kondisi ini menyebabkan pesan kesehatan yang diterima remaja tidak konsisten,

membbingungkan, dan kadang bertentangan dengan praktik yang dianjurkan. Bagi bidan, situasi ini menjadi tantangan dalam membangun komunikasi efektif karena harus menjembatani perbedaan pemahaman, mengedukasi keluarga agar mendukung, sekaligus mengoreksi informasi salah yang sudah telanjur diyakini remaja. Kesenjangan pengetahuan ini jika tidak ditangani dapat mengurangi efektivitas layanan dan membuat remaja enggan memanfaatkan layanan kebidanan secara optimal.

I. Strategi dan Rekomendasi Penguatan Peran Kebidanan

1. Penguatan kurikulum kebidanan terkait pelayanan remaja

Salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah memperkuat kurikulum pendidikan kebidanan dengan materi khusus mengenai kesehatan reproduksi remaja. Saat ini, fokus pendidikan kebidanan masih dominan pada pelayanan ibu hamil, bersalin, dan nifas. Padahal, fase remaja merupakan pintu masuk penting dalam membangun kesehatan reproduksi jangka panjang. Dengan menambahkan modul khusus yang membahas pubertas, psikologi perkembangan remaja, edukasi reproduksi, dan layanan ramah remaja, calon bidan dapat dipersiapkan untuk memberikan pelayanan yang relevan sesuai kebutuhan. Kurikulum yang diperkuat ini juga perlu menekankan keterampilan komunikasi, konseling, serta pendekatan berbasis usia agar bidan mampu menghadapi kompleksitas dinamika remaja dengan lebih baik.

2. Pelatihan dan sertifikasi konseling remaja

Selain penguatan kurikulum formal, bidan yang sudah bertugas perlu mendapatkan pelatihan berkelanjutan. Program pelatihan ini dapat berfokus pada konseling remaja, teknik komunikasi yang efektif, penanganan kasus sensitif seperti kehamilan tidak diinginkan, infeksi menular seksual, serta isu kesehatan mental. Sertifikasi konseling remaja juga dapat diterapkan untuk memastikan kompetensi bidan dalam memberikan layanan yang aman, empatik, dan profesional. Dengan adanya pelatihan dan sertifikasi, bidan tidak hanya berbekal teori, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat diaplikasikan langsung di lapangan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan remaja terhadap bidan sebagai sumber informasi dan layanan kesehatan.

3. Dukungan kebijakan kesehatan reproduksi ramah remaja

Peran bidan akan lebih kuat bila didukung oleh kebijakan nasional dan daerah yang konsisten. Kebijakan kesehatan reproduksi ramah remaja perlu mengatur standar layanan yang menjamin kerahasiaan, aksesibilitas, dan non-diskriminasi. Pemerintah dapat menetapkan pedoman teknis yang lebih jelas mengenai peran bidan dalam pelayanan remaja, termasuk di sekolah, komunitas,

maupun fasilitas kesehatan. Selain itu, dukungan anggaran, insentif bagi bidan yang aktif dalam program remaja, serta integrasi kebijakan lintas sector kesehatan, pendidikan, dan sosial—akan memastikan keberlanjutan program. Dengan adanya kebijakan yang berpihak, bidan tidak lagi bekerja sendiri, tetapi menjadi bagian dari ekosistem besar yang saling menguatkan.

4. Peningkatan riset dan publikasi tentang kebidanan remaja

Aspek lain yang tak kalah penting adalah riset dan publikasi. Bidan perlu didorong untuk melakukan penelitian terkait isu-isu kesehatan reproduksi remaja, baik dalam skala komunitas kecil maupun regional. Riset ini dapat mengungkap pola masalah menstruasi, faktor risiko kehamilan remaja, hingga efektivitas program pendidikan kesehatan. Hasil penelitian tersebut selanjutnya dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau prosiding agar menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan dan praktik. Dengan budaya riset yang kuat, profesi kebidanan tidak hanya berperan dalam pelayanan langsung, tetapi juga memberi kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu kesehatan reproduksi remaja di tingkat nasional maupun global.

J. Simpulan

Kesehatan reproduksi remaja merupakan aspek penting dalam pembangunan kesehatan masyarakat yang melampaui dimensi biologis semata, melainkan juga menyangkut aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Masa remaja adalah fase transisi yang rawan dengan berbagai risiko seperti kehamilan tidak diinginkan, infeksi menular seksual, gangguan gizi, hingga masalah kesehatan mental akibat stigma dan tekanan sosial. Tantangan global maupun nasional mulai dari tingginya angka kehamilan remaja, keterbatasan layanan ramah remaja, hingga norma budaya yang menghambat keterbukaan menunjukkan bahwa isu ini masih menjadi pekerjaan besar bagi semua pihak.

Dalam konteks inilah, profesi kebidanan memiliki posisi strategis. Bidan tidak hanya berfungsi pada aspek klinis, tetapi juga menjadi pendidik, konselor, dan agen perubahan di sekolah, komunitas, maupun keluarga. Kompetensi bidan mencakup kemampuan klinis, komunikasi, konseling, serta pendekatan berbasis usia yang memungkinkan mereka menjembatani kesenjangan informasi antara remaja, keluarga, dan layanan kesehatan. Lebih dari itu, bidan juga memainkan peran dalam edukasi berbasis sekolah dan keluarga, pemberdayaan melalui pendidik sebaya, pelayanan klinis yang ramah remaja, hingga dukungan kesehatan mental.

Optimalisasi peran bidan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Program UKS/M, kerja sama dengan puskesmas, BKKBN, organisasi kepemudaan, serta dukungan tokoh masyarakat dan LSM membuktikan bahwa sinergi merupakan kunci

keberhasilan. Inovasi juga diperlukan, baik melalui pemanfaatan teknologi digital untuk edukasi, pengembangan model layanan ramah remaja, maupun kegiatan kreatif berbasis komunitas seperti peer support group dan posyandu remaja.

Meski demikian, sejumlah tantangan masih mengemuka, antara lain keterbatasan akses dan sumber daya, stigma budaya, serta kesenjangan pengetahuan antara tenaga kesehatan, remaja, dan keluarga. Untuk itu, strategi penguatan perlu diarahkan pada perbaikan kurikulum kebidanan, pelatihan dan sertifikasi konseling remaja, dukungan kebijakan yang berpihak pada layanan ramah remaja, serta penguatan riset dan publikasi kebidanan remaja.

Dengan landasan tersebut, jelas bahwa bidan memegang peran strategis dalam memastikan remaja mendapatkan haknya atas kesehatan reproduksi yang aman, berkualitas, dan berkesinambungan. Upaya ini bukan hanya investasi kesehatan, tetapi juga investasi sosial dan ekonomi untuk membangun generasi muda yang sehat, produktif, dan berdaya saing di masa depan.

K. Daftar Pustaka

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2020). Pedoman Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M). Jakarta: BKKBN.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Pedoman Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR). Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Hillard, P. A., Deitch, H. R., & Rosenfield, R. L. (2019). Menstruation in adolescents: What's normal, what's not. *Pediatrics in Review*, 40(4), 189–201.
- International Confederation of Midwives. (2021). Essential competencies for midwifery practice. The Hague: ICM.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2014). Peraturan Bersama tentang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M). Jakarta: Kemendikbud.
- Santrock, J. W. (2021). *Adolescence* (17th ed.). New York, NY: McGraw-Hill Education.
- World Health Organization. (2018). WHO recommendations on adolescent sexual and reproductive health and rights. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization. (2020). Adolescent health: Key facts. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization. (2022). Family planning: A global handbook for providers (4th ed.). Geneva: WHO & Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

L. Glosarium

Anemia

Kondisi medis akibat kekurangan sel darah merah atau hemoglobin, sering disebabkan oleh perdarahan menstruasi berlebih atau kekurangan zat besi pada remaja.

Amenore

Gangguan siklus menstruasi berupa tidak adanya menstruasi, dapat bersifat primer (belum pernah menstruasi hingga usia tertentu) atau sekunder (menstruasi berhenti setelah sebelumnya normal).

Bidan

Tenaga kesehatan profesional yang berperan tidak hanya dalam pelayanan ibu hamil dan persalinan, tetapi juga dalam edukasi, konseling, serta pelayanan kesehatan reproduksi remaja yang komprehensif.

Dismenore

Nyeri perut bagian bawah saat menstruasi akibat kontraksi rahim. Dibedakan menjadi dismenore primer (tanpa kelainan organik) dan sekunder (disebabkan kelainan organ reproduksi).

Generasi Berencana (GenRe)

Program BKKBN yang ditujukan untuk remaja agar memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku sehat dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga serta menunda usia perkawinan.

Infeksi Menular Seksual (IMS)

Penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, seperti klamidia, gonore, sifilis, dan HIV/AIDS, yang menjadi salah satu isu utama kesehatan reproduksi remaja.

International Confederation of Midwives (ICM)

Organisasi internasional yang menetapkan standar global mengenai kompetensi dan praktik kebidanan, termasuk peran bidan dalam pelayanan kesehatan remaja.

Kontrasepsi

Metode untuk mencegah kehamilan, baik berupa kondom, pil, suntik, implan, maupun IUD. Pada remaja, konseling kontrasepsi menekankan perlindungan ganda dari kehamilan dan IMS.

Kesehatan Reproduksi Remaja

Keadaan sehat fisik, mental, dan sosial remaja terkait sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Tidak hanya bebas penyakit, tetapi juga mencakup kemampuan menjalani kehidupan seksual yang aman, bertanggung jawab, dan memuaskan.

Menstruasi

Perdarahan bulanan dari uterus sebagai hasil peluruhan lapisan endometrium. Pada remaja, menstruasi sering belum teratur karena sistem hormonal masih dalam tahap penyesuaian.

Peer Educator (Pendidik Sebaya)

Remaja yang dilatih untuk menjadi agen informasi, konselor, dan teladan bagi teman sebayanya dalam isu kesehatan reproduksi, dengan pendampingan tenaga kesehatan seperti bidan.

Posyandu Remaja

Pos pelayanan terpadu yang dikhususkan bagi remaja di tingkat komunitas, berfungsi untuk memberikan edukasi, pelayanan kesehatan dasar, konseling, serta kegiatan kreatif pendukung kesehatan reproduksi.

Pubertas

Fase perkembangan biologis ketika remaja mulai mengalami perubahan fisik dan hormonal yang menandai kemampuan reproduksi, ditandai dengan menarke pada perempuan dan mimpi basah pada laki-laki.

Stigma Sosial

Label negatif yang diberikan masyarakat terhadap isu kesehatan reproduksi seperti menstruasi, kontrasepsi, atau kehamilan remaja, yang sering menghambat keterbukaan informasi dan akses layanan.

UKS/M (Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah)

Program kolaboratif lintas sektor di sekolah untuk meningkatkan derajat kesehatan siswa, termasuk melalui edukasi kesehatan reproduksi dan deteksi dini masalah remaja.

WHO (World Health Organization)

Badan kesehatan dunia yang memberikan definisi, standar, dan rekomendasi terkait kesehatan reproduksi remaja secara global.

PROFIL PENULIS



Dina Isfentiani, S.Kep.Ns., M.Ked., Lahir di Ponorogo, 22 Januari 1964, dengan jenjang Pendidikan Tinggi S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK) Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya lulus tahun 2002. Pendidikan S2 ditempuh di Fakultas Kedokteran Program Magister Program Studi Ilmu Kedokteran Dasar Universitas Airlangga Surabaya lulus pada tahun 2010. Pada saat ini penulis menjadi dosen di Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya sejak berdiri tahun 2002 sampai dengan sekarang.

Beberapa mata kuliah yang diampu adalah Biokimia dalam praktik kebidanan, Anatomi dan Fisiologi, farmakologi, Komunikasi dalam praktik Kebidanan, Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal dan Basic Life Support. Selain mengajar, sebagai dosen penulis selalu aktif dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi lainnya melalui kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan baik secara kompetisi maupun mandiri, publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi, menulis buku dan hakcipta hasil penelitian. Kontak penulis dapat melalui isfentiani@gmail.com

Motto: Selalu libatkan Allah SWT disetiap urusan yang dijalankan



Bdn. Ida Susila, S.ST., M. Kes., lahir di Lamongan pada 23 Maret 1985. Setelah menamatkan pendidikan SMA Dr. Musta'in Romly, Jawa Timur, penulis melanjutkan pendidikan tinggi pada Diploma III Kebidanan IIK NU Tuban, kemudian menempuh Diploma IV Bidan Pendidik Di STIKES Insan Unggul Surabaya dan lulus pada tahun 2007. Karier profesional dimulai pada tahun 2007 di salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya, lalu melanjutkan studi Magister promosi kesehatan Universitas Diponegoro Semarang

dengan peminatan Kesehatan Reproduksi HIV/AIDS, yang diselesaikan pada tahun 2014. Saat ini penulis bekerja di Universitas Islam Lamongan, mengampu beberapa mata kuliah yang berfokus pada kesehatan reproduksi. Penulis menjabat sebagai Direktur Sekolah Vokasi Prodi D3 Kebidanan dan aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, di antaranya menulis buku, mempublikasikan karya ilmiah, menjadi narasumber seminar, dan pembicara dalam berbagai kegiatan. Motto: "Keberhasilan adalah milik yang pantang menyerah"

PROFIL PENULIS



Bd. Indah Yani Br. Tambunan, S.Tr.Keb., M.Kes., Lahir di Aek Nabara, 19 Januari 1986. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII pada Program Studi Akademi Kebidanan, Akademi Kebidanan Senior Medan tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan DIV pada Universitas Sumatera Utara dan lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Deli Husada Deli Tua Medan dan lulus tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2018 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Senior Medan hingga sampai saat ini (2025). Saat ini penulis bekerja di Universitas Senior Medan mengampu mata kuliah Fisiologi kehamilan, persalinan, nifas dan BBL, Asuhan Kebidanan pada masa nifas, Kesehatan Reproduksi, dll.. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan sudah turut andil dalam PDP. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: tambunanindah19@gmail.com
Motto: "make yourself valuable"



Bd. Nur Hidayah Afnas, S.ST., M.Biomed., yang akrab disapa Yaya, lahir di Padang pada 25 Oktober 1987. Setelah menamatkan pendidikan menengah di Gontor Putri 1, Jawa Timur, penulis melanjutkan pendidikan tinggi pada Diploma III Kebidanan, kemudian menempuh Diploma IV Bidan Pendidik dan lulus pada tahun 2012. Karier profesional dimulai pada tahun 2013 di salah satu perguruan tinggi swasta di Sumatera Barat, sambil melanjutkan studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dengan peminatan Reproduksi Kedokteran, yang diselesaikan pada tahun 2015. Saat ini penulis bekerja di Fakultas Kesehatan Universitas Sumatera Barat, mengampu beberapa mata kuliah yang berfokus pada kesehatan reproduksi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, di antaranya menulis buku, memublikasikan karya ilmiah, menjadi narasumber seminar, dan pembicara dalam berbagai kegiatan.
Motto: "Work with knowledge, create with heart"

PROFIL PENULIS



Siti Komariyah, S.SiT., M.Kes., Penulis lahir di Tulungagung, domisili di Kota Kediri. Penulis menyelesaikan pendidikan SPK di SPK Pemkab Kabupaten Tulungagung, Pendidikan P2B di RS Baptis Kota Kediri, Diploma 3 Kebidanan Akademi Kebidanan Dharma Husada Kediri, D4 Bidan Pendidik di FK UGM Yogyakarta, S2 Pendidikan Kesehatan di UNS lulus tahun 2009, saat ini sedang menempuh program Doktoral. Riwayat karir, Penulis pernah bekerja di RSIA Trisna Medika Tulungagung selama 7 tahun, kemudian dunia pendidikan di Akademi Kesehatan Dharma Husada Kediri prodi D III

Kebidanan mulai tahun 2003 sampai dengan April 2024. Mulai Mei 2024 bergabung dengan Universitas Strada Indonesia (USI) Prodi Profesi Kebidanan. Buku yang pernah di tulis tentang Kesehatan Reproduksi, Stimulasi Anak tumbuh kembang anak, Peduli Kesehatan Reproduksi Wanita, Diagnostik asuham kebidanan pada kehamilan dengan permasalahannya, Buku Ajar Psikologi Kebidanan, Kumpulan Latihan Soal Osce Kebidanan, SOP Pelayanan Kebidanan masa persalinan, buku ajar persalinan, masih Saat ini penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian kesehatan khususnya kebidanan yang telah terbit di jurnal Sinta, aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan terpublikasi di Jurnal Nasional. Jalin kerja sama dengan penulis via surel sitikomariyah.dh@gmail.com.



Dr. Bd. Ika Nur Saputri, SST., M.Keb., yang akrab disapa Ika, lahir di Bah Butong pada 18 Agustus 1987. Setelah menamatkan pendidikan menengah di SMAN 1 Pematang Siantar, penulis melanjutkan pendidikan tinggi pada Diploma III Kebidanan, kemudian menempuh Diploma IV Bidan Pendidik dan lulus pada tahun 2009. Karier profesional dimulai pada tahun 2010 di salah satu perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara, sambil melanjutkan studi Magister Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang yang diselesaikan pada tahun 2014. Tahun 2025 penulis

menyelesaikan pendidikan Program Doktor Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang. Saat ini penulis bekerja di Fakultas Kebidanan Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam, mengampu beberapa mata kuliah yang berfokus pada kebidanan dan kesehatan reproduksi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, di antaranya menulis buku, memublikasikan karya ilmiah, menjadi narasumber seminar, dan pembicara dalam berbagai kegiatan. Motto: "Syukur menjadikan hati tenang, sabar menjadikan langkah kuat"

Sinopsis

Bunga rampai Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia: Isu Terkini dan Peran Strategis Kebidanan menghadirkan panduan komprehensif yang merangkum tantangan, bukti ilmiah terbaru, dan praktik terbaik dalam pelayanan ramah remaja. Disusun oleh para akademisi dan praktisi kebidanan, buku ini menjembatani teori dan praktik—dari ruang kelas, puskesmas, dan klinik mandiri hingga program komunitas—dengan fokus pada literasi kesehatan, pencegahan, konseling, dan rujukan yang sensitif budaya serta berorientasi hak-hak remaja.

Bab Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja menempatkan literasi sebagai fondasi perubahan perilaku, menyajikan strategi komunikasi yang efektif melawan mitos dan stigma. Bab Pencegahan Kehamilan Tidak Diinginkan pada Remaja menguraikan pendekatan komprehensif: pendidikan seks berbasis bukti, akses kontrasepsi yang aman dan terjangkau, serta penguatan dukungan keluarga dan sekolah. Bab Infeksi Menular Seksual (IMS) pada Remaja menekankan skrining dini, konseling, manajemen kasus, dan jejaring rujukan yang ramah remaja untuk memutus rantai penularan.

Bab Menstruasi dan Permasalahan Terkait pada Remaja memperluas perspektif dari aspek biologis ke isu akses produk, sanitasi, manajemen nyeri, hingga martabat dan kehadiran sekolah. Bab Kesehatan Mental dan Seksualitas Remaja menautkan kesejahteraan psikologis dengan pengambilan keputusan seksual yang sehat, menawarkan alat asesmen sederhana, layanan konseling, dan alur rujukan yang aman. Semua pembahasan bermuara pada bab Peran Strategis Kebidanan yang merumuskan kompetensi inti bidan—promotif, preventif, kuratif, dan advokatif—serta kolaborasi lintas sektor dan inovasi layanan (telekonseling, klinik remaja, dan intervensi berbasis sekolah/komunitas).

Dirancang sebagai rujukan praktis dan akademik, buku ini relevan bagi mahasiswa kebidanan dan kesehatan, bidan, pengelola program, pendidik, dan pembuat kebijakan. Dengan bahasa yang jernih, studi kasus kontekstual Indonesia, dan rekomendasi siap-pakai, bunga rampai ini menjadi panduan strategis untuk memperkuat ekosistem kesehatan reproduksi remaja—agar setiap remaja Indonesia tumbuh sehat, berdaya, dan terlindungi haknya.

Bunga rampai Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia: Isu Terkini dan Peran Strategis Kebidanan menghadirkan panduan komprehensif yang merangkum tantangan, bukti ilmiah terbaru, dan praktik terbaik dalam pelayanan ramah remaja. Disusun oleh para akademisi dan praktisi kebidanan, buku ini menjembatani teori dan praktik dari ruang kelas, puskesmas, dan klinik mandiri hingga program komunitas dengan fokus pada literasi kesehatan, pencegahan, konseling, dan rujukan yang sensitif budaya serta berorientasi hak-hak remaja.

Bab Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja menempatkan literasi sebagai fondasi perubahan perilaku, menyajikan strategi komunikasi yang efektif melawan mitos dan stigma. Bab Pencegahan Kehamilan Tidak Diinginkan pada Remaja menguraikan pendekatan komprehensif: pendidikan seks berbasis bukti, akses kontrasepsi yang aman dan terjangkau, serta penguatan dukungan keluarga dan sekolah. Bab Infeksi Menular Seksual (IMS) pada Remaja menekankan skrining dini, konseling, manajemen kasus, dan jejaring rujukan yang ramah remaja untuk memutus rantai penularan.

Bab Menstruasi dan Permasalahan Terkait pada Remaja memperluas perspektif dari aspek biologis ke isu akses produk, sanitasi, manajemen nyeri, hingga martabat dan kehadiran sekolah.

Bab Kesehatan Mental dan Seksualitas Remaja menautkan kesejahteraan psikologis dengan pengambilan keputusan seksual yang sehat, menawarkan alat asesmen sederhana, layanan konseling, dan alur rujukan yang aman. Semua pembahasan bermuara pada bab Peran Strategis Kebidanan yang merumuskan kompetensi inti bidan promotif, preventif, kuratif, dan advokatif serta kolaborasi lintas sektor dan inovasi layanan (telekonseling, klinik remaja, dan intervensi berbasis sekolah/komunitas).

Dirancang sebagai rujukan praktis dan akademik, buku ini relevan bagi mahasiswa kebidanan dan kesehatan, bidan, pengelola program, pendidik, dan pembuat kebijakan. Dengan bahasa yang jernih, studi kasus kontekstual Indonesia, dan rekomendasi siap-pakai, bunga rampai ini menjadi panduan strategis untuk memperkuat ekosistem kesehatan reproduksi remaja agar setiap remaja Indonesia tumbuh sehat, berdaya, dan terlindungi haknya.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7426-22-2



9

786347

426222

